

جامعة البيان كلية التمريض المرحلة الثانية

مادة التقييم الصحي والفحص البدني

المختبرات العملية

2025-2026

جامعة البيان كلية التمريض المرحلة الثانية

مادة التقييم الصحي والفحص البدني

عملي / مختبر 1



Physical examination and Assessment techniques:
الفحص البدني وتقنيات التقييم:**Objectives:**
الأهداف:

At the end of this lab, the student will be able to:

في نهاية هذا المختبر، سيكون الطالب قادراً على:

- Identify techniques of physical examination
• تحديد تقنيات الفحص البدني
- Discuss the safe and correct method of using equipment in the assessment
• ناقش الطريقة الآمنة والصحيحة لاستخدام المعدات في التقييم
- Describe the methods for documenting findings in a complete and concise manner.
• صف الطرق المستخدمة لتوثيق النتائج بطريقة كاملة وموجزة.

Preparation:
التحضير:

1. Prepare equipment needed for assessment (stethoscope, torchlight, disposable gloves).
1. حضر المعدات اللازمة للتقييم (سماعة الطبيب، مصباح يدوي، قفازات يمكن التخلص منها).
2. Have good lighting (daylight or artificial if needed).
2. احرص على وجود إضاءة جيدة (ضوء طبيعي أو صناعي إذا لزم الأمر).
3. Screen the bed to provide privacy.
3. ضع ستارة حول السرير لتوفير الخصوصية.
4. Assure a quiet environment.
4. تأكد من وجود بيئة هادئة.
5. Wash hands.
5. اغسل يديك.
6. Explain examination procedures to the patient.
6. اشرح للمريض إجراءات الفحص.
7. Instruct for appropriate seating.
7. أعط تعليمات للجلوس المناسب.

ASSESSMENT TECHNIQUES:
أساليب التقييم:

The skills requisite for the physical Examination are:
المهارات المطلوبة للفحص البدني هي:

1. Inspection
1. التفتيش
2. Palpation
2. اللمس أو الفحص باللمس
3. Percussion
3. الإيقاع
4. Auscultation.
4. السمع بالقم

The skills are performed one at a time and in this order.
يتم أداء المهارات واحدة تلو الأخرى وبهذا الترتيب.

1. Inspection:
1. الفحص:

- a) Enough exposure of the area
(أ) تعرض كاف للمنطقة
- b) Inspect in an orderly sequence
(ب) افحص بترتيب منظم
- c) Compare the left and right side of the body
(ج) قارن بين الجانب الأيسر والجانب الأيمن من الجسم
- d) Listen to any sound
(د) استمع لأي صوت
- e) Smell any odour
(هـ) شم أي رائحة

2. Palpation:
2. اللمس:

- a) Palpation follows and often confirms points that you noted during inspection.
(أ) اللمس يتبع وغالباً ما يؤكد النقاط التي لاحظتها أثناء الفحص البصري.
- b) Involves touching the region or body part and noting what the various structures feel like.
(ب) يتضمن لمس المنطقة أو الجزء من الجسم وملاحظة كيف تبدو الهياكل المختلفة عند اللمس.
- c) With experience comes the ability to distinguish variations of normal from abnormal findings.
(ج) مع الخبرة تأتي القدرة على التمييز بين الاختلافات بين الطبيعي وغير الطبيعي.
- d) Performed in an organized manner from region to region.
(د) يُنفذ بطريقة منظمة من منطقة إلى أخرى.
- e) Palpation applies your sense of touch to assess these factors: texture; temperature; moisture; organ location and size; and any swelling, vibration or pulsation, rigidity or spasticity, crepitation, presence of lumps or masses, and presence of tenderness or pain.
(هـ) الفحص اللمس يستخدم حاسة اللمس لتقييم هذه العوامل: اللمس؛ درجة الحرارة؛ الرطوبة؛ موقع وحجم العضو؛ وأي تورم أو اهتزاز أو نبض، أو تيبس أو تشنج، المقلقة، وجود كتل أو أورام، ووجود ألم أو حساسية.

Different parts of the hands are best suited for assessing different factors:

أجزاء مختلفة من اليدين مناسبة أكثر لتقييم عوامل مختلفة:

- **Fingertips**—Best for fine tactile discrimination such as skin texture, swelling, pulsatility, and presence of lumps
• أطراف الأصابع — الأفضل للتمييز الحسي الدقيق مثل ملمس الجلد، الانتفاخ، النبض، ووجود كتل
- **A grasping action of the fingers and thumb**—To detect the position, shape, and consistency of an organ or mass
• حركة القبض بالأصابع والإبهام — لاكتشاف الموضع والشكل، و قوام عضو أو كتلة
- **The dorsa (backs) of hands and fingers**—Best for determining temperature because the skin here is thinner than on the palms
• ظهر اليدين والأصابع — الأفضل لتحديد درجة الحرارة لأن الجلد هنا أرق من باطن اليد
- **Base of fingers (metacarpophalangeal joints) or ulnar surface of the hand**—To detect vibration
• قاعدة الأصابع (مفاصل السلاميات الرسغية) أو السطح الزندي لليد — للكشف اهتزاز

Your palpation technique should be:

يجب أن تكون طريقك في التلمس:

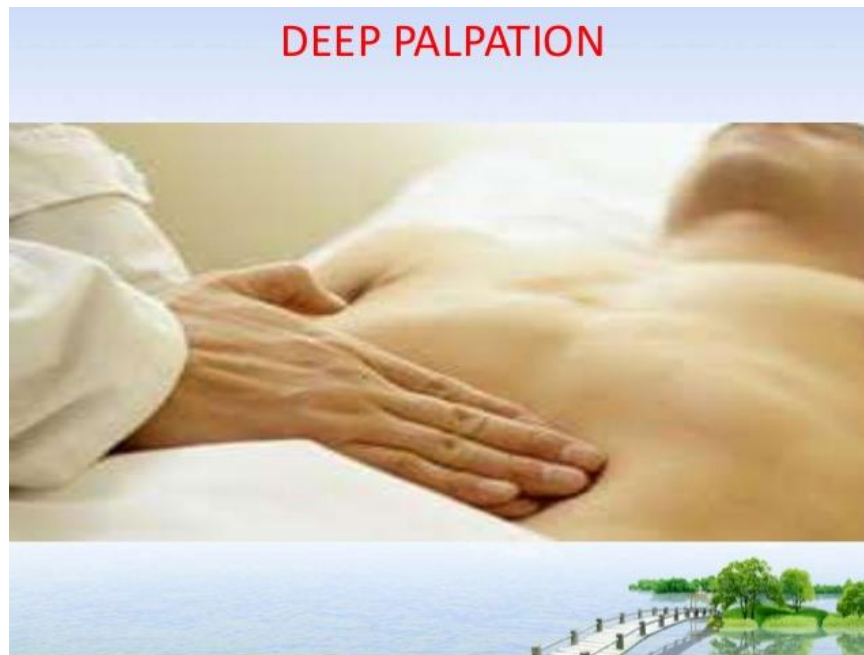
- Slow and systematic
بطيء ومنهجي
- Warm your hands by kneading them together or holding them under warm water
• قم بتدفئة يديك عن طريق فركهما معا أو وضعهما تحت ماء دافئ
- Identify any tender areas and palpate them last.
• حدد أي مناطق مؤلمة وافحصها في النهاية.
- Start with light palpation to detect surface characteristics and accustom the person to being touched.
• ابدأ بالتلمس الخفيف لاكتشاف خصائص السطح والتعود الشخص على أن يلمس.
- When deep palpation is needed (as for abdominal contents), intermittent pressure is better than one long, continuous palpation. Avoid any situation in which continuous or deep palpation could cause internal injury or pain.
• عند الحاجة إلى التلمس العميق (كما في محتويات البطن)، يكون الضغط المتقطع أفضل من جلسة فحص طويلة ومتواصلة واحدة. تجنب أي موقف يكون فيه الفحص مستمرا أو عميقا
• التلمس قد يسبب إصابة داخلية أو ألم.
- Bimanual palpation requires the use of both hands to envelop or capture certain body parts or organs such as the kidneys, uterus, or adnexa for more precise delimitation.
• الفحص باللمس باستخدام كلتا اليدين يتطلب استخدام اليدين لتغليف أو الإمساك بأجزاء معينة من الجسم أو الأعضاء مثل الكليتين، الرحم، أو الملحقات لتحديد بدقة أكبر.

Types of palpation:

أنواع التلمس:

- Light palpation
لمس خفيف
- Deep palpation
التلمس العميق
- Bimanual palpation
اللمس الثنائي

LIGHT PALPATION



Bimanual examination of the kidneys 1

One hand under the patients flank, fingers in the renal angle (between posterior costal margin and spine)



The other hand with fingers flat placed below the costal margin, lateral to the rectus muscle



Hands should be opposite one another

3. Percussion:

3. الإيقاع:

Percussion involves tapping the person's skin with short, sharp strokes to assess underlying structures. The strokes yield a palpable vibration and a characteristic sound that depicts the location, size, and density of the underlying organ.

- Warm your hands

• دفي يديك

- Perform percussion as follows:

• قم بالطرق كما يلي:

- **The Stationary Hand.**

اليد الثابتة.

- ✓ Hyperextend the middle finger of your non-dominant hand (the pleximeter) and place its distal portion *firmly* against the person's skin. Avoid the ribs and scapulae.
- ✓ Percussing over a bone yields no data because it always sounds "dull."
- ✓ Lift the rest of the stationary hand up off the person's skin otherwise the resting hand will dampen off the produced vibrations just as a drummer uses the hand to halt a drum roll.

- **The Striking Hand.**

اليد الضاربة.

- ✓ Use the middle finger of your dominant hand as the *striking* finger (the plexor).
- ✓ Hold your forearm close to the skin surface with your upper arm and shoulder steady but not rigid.
- ✓ The action is all in the wrist, and it *must* be relaxed.
- ✓ Bounce your middle finger off the stationary one.
- ✓ Aim for just behind the nail bed.
- ✓ Flex the striking finger so that its tip, not the finger pad, makes contact. It hits directly at right angles to the stationary finger.
- ✓ Percuss two times in this location using even, staccato blows.
- ✓ Lift the striking finger off quickly; a resting finger dampens vibrations.
- ✓ Then move to a new body location and repeat, keeping your technique even



□ **Fist percussion:**

فرض بالقبضة:

- ✓ Place one hand flat against body surface
ضع يدا واحدة مسطحة على سطح الجسم
- ✓ Strike the back of hand with the other hand clenched in a fist.
اضرب ظهر اليد باليد الأخرى وهي مضغوطة في قبضة.

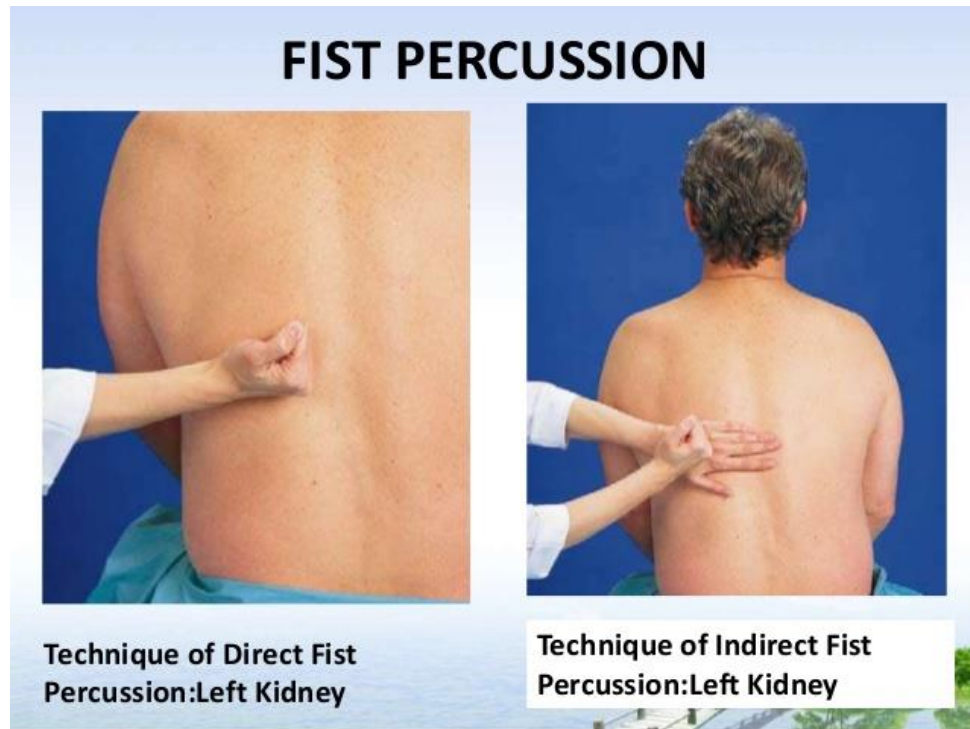


TABLE 9-1: Characteristics of Percussion Notes

	AMPLITUDE	PITCH	QUALITY	DURATION	SAMPLE LOCATION
Resonant 	Medium-loud	Low	Clear, hollow	Moderate	Over normal lung tissue
Hyperresonant 	Louder	Lower	Booming	Longer	Normal over child's lung Abnormal in the adult, over lungs with increased amount of air, as in emphysema
Tympany 	Loud	High	Musical and drumlike (like the kettle drum)	Sustained longest	Over air-filled viscus, e.g., the stomach, the intestine
Dull 	Soft	High	Muffled thud	Short	Relatively dense organ, as liver or spleen
Flat 	Very soft	High	A dead stop of sound, absolute dullness	Very short	When no air is present, over thigh muscles, bone, or over tumor

4. Auscultation:

4. السمع:

Auscultation is listening to sounds produced by the body such as the heart, blood vessels, lungs, and abdomen through a **stethoscope**.
الاستماع هو سماع الأصوات التي يصدرها الجسم مثل القلب والدم
الأوعية الدموية والرئتان والبطن من خلال سماعة الطبيب.

Perform as follows:

قم بالتالي:

- ✓ Choose a stethoscope with two endpieces —a diaphragm and a bell.
اختر سماعة طبية لها طرفان — غشاء وجرس.
- ✓ The **diaphragm** has a flat edge and is best for high-pitched sounds—breath, bowel, and normal heart sounds.
الحجاب الحاجز له حافة مسطحة وهو الأفضل للأصوات عالية النبرة—مثل النفس والأمعاء، وصوت القلب الطبيعي.
- ✓ Hold the diaphragm firmly against the person's skin, firm enough to leave a slight ring afterward.
أصغط الحجاب الحاجز بإحكام على جلد الشخص، بقوة كافية لترك حلقة خفيفة لاحقاً.
- ✓ The **bell** endpiece has a deep, hollow, cuplike shape. It is best for soft, low-pitched sounds such as extra heart sounds or murmurs.
نهاية الجرس لها شكل عميق، أجوف، يشبه الكوب. هو الأفضل للأصوات الناعمة والمنخفضة النغمة أصوات مثل أصوات القلب الإضافية أو الهمهمات.
- ✓ Hold it lightly against the person's skin, just enough so it forms a perfect seal.
ضعها بخفة على جلد الشخص، فقط بما يكفي لتشكيل ختماً مثالياً.
- ✓ Pressing harder causes the skin to act as a diaphragm, obliterating the low pitched sounds.
الضغط بقوة أكبر يجعل الجلد يعمل كغشاء، مما يمحو الأصوات المنخفضة أصوات.
- ✓ Some newer stethoscopes have one endpiece with a “tunable diaphragm.” This enables you to listen to both low- and high-frequency sounds without rotation of the endpiece.
بعض السماعات الطبية الحديثة تحتوي على قطعة نهاية واحدة مع "حجاب حاجز قابل للضبط". هذا يمكنك من الاستماع إلى الأصوات منخفضة وعالية التردد دون تدوير نهاية القطعة.

Examination Setting:

إعداد الامتحان:

The examination room should be warm and comfortable, quiet, private, and well lit.

- When possible, stop any distracting noises.
يجب أن تكون غرفة الفحص دافئة ومريحة وهادئة وخاصة ومضيق جيداً.
- Discourage interruptions.
عندما يكون ذلك ممكناً، حاول إيقاف أي أصوات مشتتة.
- Lighting with natural daylight is best, although artificial light will suffice.
حاول تجنب المقاطعات.
- Position a wall or standing lamp for high-intensity lighting.
الإضاءة الطبيعية طوال النهار هي الأفضل، رغم أن الضوء الصناعي يكفي.
- The examination table is positioned so both sides are easily accessible and at a height at which you can stand without stooping.
ضع مصباح حائط أو قائم للحصول على إضاءة شديدة.
- The table should be equipped to raise the patient's head up to 45 degrees.
تم وضع طاولة الفحص بحيث يكون من السهل الوصول إلى كلا الجانبين وارتفاع يمكنك من يمكنه الوقوف دون الانحناء.
- A roll-up stool is needed for the sections of the examination for which you must be sitting.
يجب أن يكون الطاولة مجهزة لرفع رأس المريض حتى 45 درجة.
- A bedside stand or table should be nearby to allow you to lay out your equipment.
تحتاج إلى كرسي صغير قابل للطي للأجزاء من الفحص التي يجب عليك الجلوس خلالها.
- يجب أن يكون هناك منضدة أو طاولة بجانب السرير لتتمكن من وضع أجهزتك عليها.

Approach to the patient:

الاقترب من المريض:

1. When possible, begin with the client in a sitting position, so that both front and back can be examined.
1. عندما يكون ذلك ممكناً، ابدأ بالعميل وهو جالس، بحيث يمكن معالجة كلا الجانبين الأمامي والخلفي تم فحصه.
2. Completely expose the part to be examined but drape the rest of the body appropriately.
2. اكشف الجزء الذي سيتم فحصه بالكامل لكن غط باقي الجسم بشكل مناسب.
3. Conduct the examination systematically from head to foot so as not to miss any system or body part.
3. قم بإجراء الفحص بشكل منظم من الرأس إلى القدمين حتى لا تلاحظ أي نظام أو جزء من الجسم.
4. While examining each region, consider the underlying anatomic structures, their function, and possible abnormalities.
4. أثناء فحص كل منطقة، ضع في اعتبارك البنى التشريحية الأساسية ووظيفتها، والتشوهات المحتملة.
5. Because the body is bilaterally symmetrical, for the most part, compare findings on one side with those on the other.
5. لأن الجسم متماثل من الجانبين إلى حد كبير، قارن النتائج على جانب واحد مع هؤلاء على الجانب الآخر.
6. Explain all procedures to the patient while the examination is being conducted, to avoid alarming or worrying the patient and to encourage cooperation.
6. اشرح كل الإجراءات للمريض أثناء إجراء الفحص، لتجنب يقلق المريض أو يثير قلقه ويشجع على التعاون.

General appearance and Vital signs
المظهر العام والعلامات الحيوية**Objectives:**
الأهداف:

At the end of this lab, the student will be able to:

في نهاية هذا المختبر، سيكون الطالب قادراً على:

- Identify key history questions
• تحديد أسئلة التاريخ الرئيسية
- Demonstrate the ability to safely and accurately complete of comprehensive examination.
• إظهار القدرة على إكمال الفحص الشامل بأمان ودقة.

Equipment:
المعدات:

1. Thermometer
1. ميزان حرارة
2. Sphygmomanometer
2. جهاز قياس الضغط
3. Stethoscope
3. سماعة طبية

Preparation:
التحضير:

1. Prepare equipment needed for assessment
1. حضر المعدات اللازمة للتقييم
2. Have good lighting (daylight or artificial if needed).
2. احرص على وجود إضاءة جيدة (ضوء طبيعي أو صناعي إذا لزم الأمر).
3. Screen the bed to provide privacy.
3. ضع ستارة حول السرير لتوفير الخصوصية.
4. Instruct for appropriate seating.
4. أعط تعليمات للجلوس المناسب.
5. Use appropriate communication skills.
5. استخدم مهارات الاتصال المناسبة.

Procedure:
الإجراء:

Steps خطوات	Normal findings نتائج طبيعية
□ Begin observation in the first contact with the patient (in the waiting room or while the patient in bed) ابدأ الملاحظة عند الاتصال الأول مع المريض (في غرفة الانتظار أو بينما المريض في السرير) □ Continue throughout the interview systematically as the first step in the examination of each body part استمر طوال المقابلة بشكل منهجي كخطوة أولى في فحص كل جزء من الجسم	
Inspection: Observe the following: التفتيش: لاحظ ما يلي: □ Race, sex, general physical development, nutritional state, mental alertness, evidence of pain, restlessness, body position, clothes, apparent age, hygiene, grooming العرق، الجنس، التطور البدني العام، الحالة الغذائية، اليقظة العقلية، دليل على الألم، القلق، الجسم، الوضع، الملابس، العمر الظاهر، النظافة، العناية الشخصية	□ Careful observation of the general state of the individual provides many clues about a person's body image and how he/she behaves and also some ideas of how well or ill the client is. ملاحظة دقيقة للحالة العامة يوفر للفرد العديد من الأدلة عن صورة جسم الشخص وكيف هو/هي يتصرف وأيضا بعض الأفكار عن مدى صحة أو سوء حالة العميل.
□ Behavior سلوك	□ Cooperate attitude & behavior سلوكيات متعاونة
□ Mood مزاج	□ Mild anxiety or tenseness قلق لوتوتر خفيف
□ Dress هستاق	□ Dressed for occasion مرتديا ملابس مناسبة لل المناسبة
□ Gait المشي	□ Erect posture, coordinate; smooth & steady gait وضعية منتصبة، تنسيق؛ انسيابي مشية ثابتة

□ Body build بنية الجسم □ Weight client with light clothing & no shoes وزن العميل وهو يرتدي ملابس خفيفة أحذية □ Measure the height of the client قيس طول العميل	□ Bilateral, firm and developed muscle عضلات ثنائية، قوية ومتطورة □ Varies يختلف
□ Monitor temperature راقب درجة الحرارة • Oral شفهي • Rectal شرجي • Tympanic طبلي • Axillary إبطي	□ Body temperature is usually lowest in early AM & highest in early PM (35.6-37.7° C) درجة حرارة الجسم عادة ما تكون في أدنى مستوياتها في الصباح الباكر وأعلى في المساء (35.6-37.7° C) • Hot fluids, smoking and gum chewing may elevate temperature, while cold fluids may lower it. • سوائل ساخنة، التدخين والعلكة المضغ قد يرفع درجة الحرارة، بينما قد تخفض السوائل الباردة منها. • About (0.6 ° C) higher than oral temperature • حوالي (0.6 درجة مئوية) أعلى من درجة الفم درجة الحرارة • About (0.6 ° C) higher than oral temperature • حوالي (0.6 درجة مئوية) أعلى من الفم درجة الحرارة • About (0.6 ° C) lower than oral temperature. • حوالي (0.6 درجة مئوية) أقل من الفم درجة الحرارة • Environmental temperature may alter body temperature. قد يغير درجة الحرارة المحيطة درجة حرارة الجسم.
□ Monitor pulse (Radial... etc.) راقب النبض (الشريان الكعبري... إلخ) □ Check for: تحقق من: • Rate السعر • Rhythm الإيقاع • Equality & Volume المساواة	• 60-100 bpm • ١٠٠-٦٠ نبضة في الدقيقة • Regular عادي • Equal bilaterally, strength normal • متساوي في الجانبين، القوة طبيعية
□ Monitor respiration and check for: راقب التنفس وتحقق من: • Rate السعر • Rhythm الإيقاع • Depth العمق	• 12-20 breaths/min • 12-20 نفس/دقيقة • Regular عادي • Equal bilaterally chest expansion • توسع الصدر متساوي في الجانبين
□ Monitor Blood pressure after client is seated or in a supine position quietly for 10 minutes راقب ضغط الدم بعد أن يكون العميل جالس أو في وضعية الاستلقاء بهدوء لمدة 10 دقائق □ Then repeat with client standing ثم كرر بينما يقف العميل	□ Varies depends on age. يختلف حسب العمر. • Systolic 120 mmhg • ضغط الدم الانقباضي 120 ملم زئبق • Diastolic 80 mmhg • ضغط الدم الانبساطي 80 ملم زئبق • Pulse pressure 40 mmhg • فرق الضغط النبضي 40 ملم زئبق

جامعة البيان كلية التمريض المرحلة الثانية

مادة التقييم الصحي والفحص البدني

عملي / مختبر 2

Review of Systems:
Skin, Hair
and Nails



Skin, Hair, and Nail Assessment

تقييم الجلد والشعر والأظافر

Objectives:

الأهداف:

At the end of this lab, the student will be able to:

في نهاية هذا المختبر، سيكون الطالب قادراً على:

- Demonstrate the ability to safely and accurately complete a comprehensive examination of the skin
إظهار القدرة على إكمال مهمة شاملة بأمان ودقة
فحص الجلد
- Demonstrate the ability to accurately & comprehensively document skin assessment data in an organized manner.
إظهار القدرة على الدقة
بيانات التقييم بطريقة منظمة
- Evaluate assessment data of the skin to determine problems & identify client's concerns.
تقييم بيانات فحص الجلد لتحديد المشاكل
المخاوف.

Preparation:

التحضير:

8. Adequate lighting
إضاءة كافية
9. Comfortable room temperature
درجة حرارة الغرفة المريحة
10. Expose the body part to be inspected
اكتشف الجزء من الجسم الذي سيتم فحصه
11. Cleanse skin if necessary
1.1. نظف البشرة إذا لزم الأمر
12. Try to control external variables that may influence skin color & confuse your findings.
1.2. حاول التحكم في العوامل الخارجية التي قد تؤثر على لون البشرة
النتائج.

SUBJECTIVE DATA:

البيانات الشخصية:

1. Past history of skin disease (allergies, hives, psoriasis, eczema)
1. التاريخ السابق لأمراض الجلد (الحساسية، الحشوي، الصدفية، الأكزيما)
2. Change in pigmentation
2. تغير في الصبغة
3. Change in mole (size or color)
3. تغيير في الشامخة (الحجم أو اللون)
4. Excessive dryness or moisture
4. الجفاف أو الرطوبة المفرطة
5. Pruritus
5. حكة
6. Excessive bruising
6. الكدمات الزائدة
7. Rash or lesion
7. طفح جلدي أو آفة
8. Medications (any that cause allergic skin response, increased sunlight sensitivity)
8. الأدوية (أي أدوية تسبب رد فعل تحسسي على الجلد أو زيادة الحساسية لأشعة الشمس)
9. Hair loss
9. تساقط الشعر
10. Change in nails
10. تغير في الأظافر
11. Environmental or occupational hazards (sun exposure, indoor tanning, toxic chemicals, insect bites)
11. المخاطر البيئية أو المهنية (التعرض لأشعة الشمس، تسمير البشرة داخل الأماكن المغلقة، السموم الكيميائية، لدغات الحشرات)
12. Patient-centered care (daily hygiene; use of soaps, cosmetics, or chemicals)
12. الرعاية التي تركز على المريض (النظافة اليومية؛ استخدام الصابون أو مستحضرات التجميل أو المواد الكيميائية)

OBJECTIVE DATA:

البيانات الموضوعية:

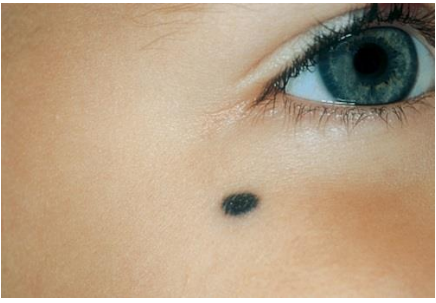
EQUIPMENT NEEDED

المعدات المطلوبة:

- Strong direct lighting (natural daylight is ideal to evaluate skin characteristics or use halogen light)
إضاءة قوية ومباشرة (يفضل ضوء النهار الطبيعي لتقييم خصائص البشرة أو استخدام ضوء الهالوجين)
- Small centimeter ruler
مسطرة صغيرة بالسنتيمتر
- Penlight
مصباح يدوي صغير
- Gloves
قفازات

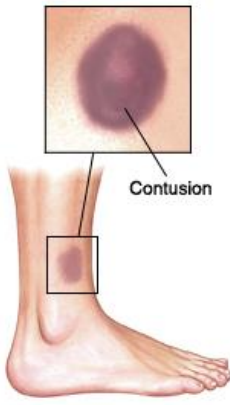
Procedure: Inspect and Palpate the Skin

الإجراء: فحص ولمس الجلد

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Color لون □ General Pigmentation: التصبغ العام: General pigmentation is darker in sun-exposed areas. Common (benign) pigmentations also occur: التصبغ العام يكون أغمق في الشمس- المناطق المكشوفة. شائعة (حميدة) pigmentations also occur: تحدث التصبغات أيضا. • Freckles (ephelides)—A small, flat increase of brown melanin pigment النمش (ephelides)—زيادة صغيرة ومسطحة صبغة الميلانين البنية  • Nevus (mole)—A proliferation of melanocytes, tan-to-brown color, flat or raised • شامة (وحمة) — تكاثر ل الخلايا الصبغية، لون بني فاتح إلى بني، مسطح أو مرفوع  • Birthmarks—May be tan to brown color • علامات الولادة — قد تكون بلون بني فاتح إلى بني  □ Advise anyone with moles or birthmarks to perform periodic skin self-examinations. Watch for danger signs listed here. Ask a family member to check any areas that the person cannot see (e.g., the back). نصيحة لأي شخص لديه شامات أو علامات ولادة لأجراء فحص دوري للجلد بنفسك. راقب علامات الخطر مدرج هنا. اطلب من أحد أفراد العائلة التحقق أي أماكن لا يستطيع الشخص رؤيتها (على سبيل المثال، الظهر).	Danger signs: Abnormal characteristics of pigmented lesions are summarized with the mnemonic: علامات الخطر: الخصائص غير الطبيعية ل تلخص الأحرف المصنوعة مع تذكرني: ABCDE: أ ب ج د هـ A. Asymmetry of a pigmented lesion. أ. تماثل في الأفة المصبوغة. B. Border irregularity. ب. خلل في الحواف. C. Color variation (areas of black, gray, blue, red, white, pink) or dark black color. ج. تغير اللون (مناطق سوداء، رمادي، أزرق، أحمر، أبيض، وردي) أو غامق اللون الاسود. D. Diameter greater than 6 mm. د. قطر أكبر من 6 مم. E. Elevation or evolution. الارتفاع أو التطور. In addition, report a change in a mole's size, a new pigmented lesion; or the development of itching, burning, or bleeding in a mole. Any of these signs should raise suspicion of malignant melanoma and warrant referral. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ عن تغيير في الشامة الحجم، أفة جديدة ملونة؛ أو تطور الحكة أو الحرقان أو نزيف في شامة. أي من هذه العلامات ينبغي أن يثير الشك في وجود خبيث سرطان الجلد الميلانيني ويستدعي الإحالة.

□ Widespread Color Change. تغير اللون بشكل واسع Note any: لاحظ أي: □ pallor (white) شحوب (أبيض) □ erythema (red) احمرار (أحمر) □ cyanosis (blue) الزرقة (أزرق) □ and jaundice (yellow) واليرقان (أصفر)  <i>Erythema</i> الاحمرار	
Temperature درجة الحرارة □ Use the backs (dorsa) of your hands and palpate bilaterally. استخدم ظهر يديك و افحص بالأحساس من الجانبين □ The skin should be warm with equal temperature bilaterally. يجب أن تكون البشرة دافئة بشكل متساو □ Hands and feet may be slightly cooler in a cool environment. قد تكون اليدين والقدمان أكثر برودة قليلاً في بيئة راتعة. □ Hypothermia. Generalized coolness may be induced such as in hypothermia used for surgery or high fever. انخفاض حرارة الجسم. شعور بالبرودة العام قد يتم تحفيزه مثل في انخفاض حرارة الجسم يستخدم في الجراحة أو حمى. Localized coolness is expected with an immobilized extremity, as when a limb is in a cast or with an intravenous infusion. من المتوقع شعور محلي بالبرودة مع طرف مشلول، كما عندما يكون أحد الأطراف في جبيرة أو عن طريق التسريب الوريدي. □ Hyperthermia. Generalized hyperthermia occurs with an increased metabolic rate such as in fever or after heavy exercise. فرط الحرارة. عام تحدث فرط الحرارة مع زيادة معدل الأيض مثلما يحدث في الحمى أو بعد ذلك تمارين شديدة. A localized area feels hyperthermic with trauma, infection, or sunburn. تشعر المنطقة الموضعية بالحرارة الزائدة مع صدمة، عدوى، أو حروق الشمس.	□ General hypothermia accompanies central circulatory disturbance such as with shock. انخفاض حرارة الجسم العام يصاحب اضطراب الدورة الدموية المركزي مثل بصدمة. Localized hypothermia occurs in peripheral arterial insufficiency and in Raynaud's disease because of vasospasm. تحدث انخفاض حرارة محلي في الأطراف قصور شرياني وفي حالة رينود المرض بسبب تشنج الأوعية الدموية. □ Warm, moist skin occurs with hyperthyroidism as a result of hypermetabolic state. الجلد الدافئ والرطب يحدث مع فرط نشاط الغدة الدرقية نتيجة حالة فرط الأيض.
Moisture رطوبة □ Perspiration appears normally on the face, hands, axilla, and skinfolds in response to activity, a warm environment, or anxiety. العرق يظهر عادة على الوجه اليدين وتحت الإبط وطيّات الجلد استجابة ل نشاط، بيئة دافئة، أو قلق. □ Diaphoresis, or profuse perspiration, accompanies an increased metabolic rate such as occurs in heavy activity or fever. التعرق، أو إفراز العرق بغزارة، يرافقه زيادة في الأيض معدل يحدث أثناء النشاط الكبير أو حمى.	□ Diaphoresis occurs with thyrotoxicosis and stimulation of the nervous system with anxiety or pain. يحدث التعرق المفرط مع فرط نشاط الغدة الدرقية وتنشيط الجهاز العصبي يقلق أو ألم.

15

Mobility and Turgor الحركة والانتفاخ - Pinch up a large fold of skin on the anterior chest under the clavicle. قم بقرص ثنية كبيرة من الجلد على الجزء الأمامي من الصدر تحت الترقوة. ❖ Mobility: is the skin's ease of rising المرونة: هي سهولة تحريك الجلد ❖ Turgor: is its ability to return to place promptly when released. التورغور: هو قدرته على العودة إلى مكانه على الفور عند الإفصاح.	- Mobility is decreased when edema is present. تقل القدرة على الحركة عندما يكون هناك وذمة الحاضر. - Poor turgor is evident in severe dehydration or extreme weight loss the pinched skin recedes slowly or "tents" and stands by itself. الجمود الضعيف واضح في الحالات الشديدة الجفاف أو فقدان الوزن المفرط الجلد المقرصن يتراجع ببطء أو «يتخيم» ويظل منتصباً.
Vascularity or Bruising الوعائية أو الكدمات ❖ Cherry (senile) angiomas are small, smooth, slightly raised, bright red dots that commonly appear on the trunk in adults older than 30 years of age. الأورام الدموية الكرزية (الشيخوخية) صغيرة، نقاط ناعمة، مرتفعة قليلاً، حمراء زاهية التي تظهر عادة على الجذع في البالغون الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً.  - They normally increase in size and number with aging and are not significant. عادة ما يزداد حجمها و العدد يزداد مع التقدم في العمر وألبيت مهمة. - Any bruising (contusion) should be consistent with the expected trauma of life. أي كدمة (رض) يجب أن تكون متوافق مع الصدمات المتوقعة في الحياة.  - Normally there is no venous dilation or varicosity. عادة لا يوجد توسع وريدي أو دوالي. - Document the presence of any tattoos (a permanent skin design from indelible pigment) on the person's chart. وثق وجود أي وشوم (تصميم جلدي دائم من غير القابل للمحو الصبغة) على مخطط الشخص. - Advise the person that the use of tattoo needles and tattoo parlor equipment of doubtful sterility increases the risk of infection. نصيحة للشخص حول استخدام الوشم إبر ومعدات صالون الوشم العقم المشكوك فيه يزيد من خطر عدوى.	- Multiple bruises at different stages of healing and excessive bruises above the knees or elbows raise concern about physical abuse. كدمات متعددة في مراحل مختلفة الشفاء والكدمات الزائدة فوق الركبة أو المرافق تثير قلق بشأن الإساءة الجسدية. - Needle marks or tracks from intravenous injection of street drugs may be visible on the antecubital fossae, forearms, or any available vein. علامات أو آثار الإبرة من حقن المخدرات بالوريد قد يكون مرئياً في منطقة المرفق الأمامية الجفء الساعدين، أو أي وريد متاح.

Lesions:

الآفات:

□ Note:

ملاحظة:

1. Color

1. اللون

2. Elevation: Flat, raised, or pedunculated

2. الارتفاع: مسطح، مرتفع، أو منبسط على ساق

3. Pattern or shape: The grouping or distinctness of each lesion, e.g., annular, grouped, confluent, linear. The pattern may be characteristic of a certain disease.

3. الشكل أو النمط: التجميع أو تميز كل آفة، مثلاً، الحلقية، مجمعة، متصلة، خطية. النمط قد يكون من خصائص مرض معين.

4. Size in centimeters: Use a ruler to measure. Avoid descriptions such as "quarter size" or "pea size."

4. الحجم بالسنتيمترات: استخدم مسطرة لقياس. تجنب الوصفات مثل "ربع حجم" أو "حجم حبة البازلاء".

5. Location and distribution on body. Is it generalized or localized to area of a specific irritant (around jewelry, watchband, around eyes)?

5. الموقع والتوزيع على الجسم. هل هو تعميم أو تقتصر على منطقة معينة (مهيئ محدد (حول المجوهرات، سوار الساعة، حول العينين)؟

6. Any exudate? Note its color or odor.

6. أي إفراز؟ لاحظ لونه أو رائحته.

□ Wear a glove if you anticipate contact with blood, mucosa, any body fluid, or an open skin lesion.

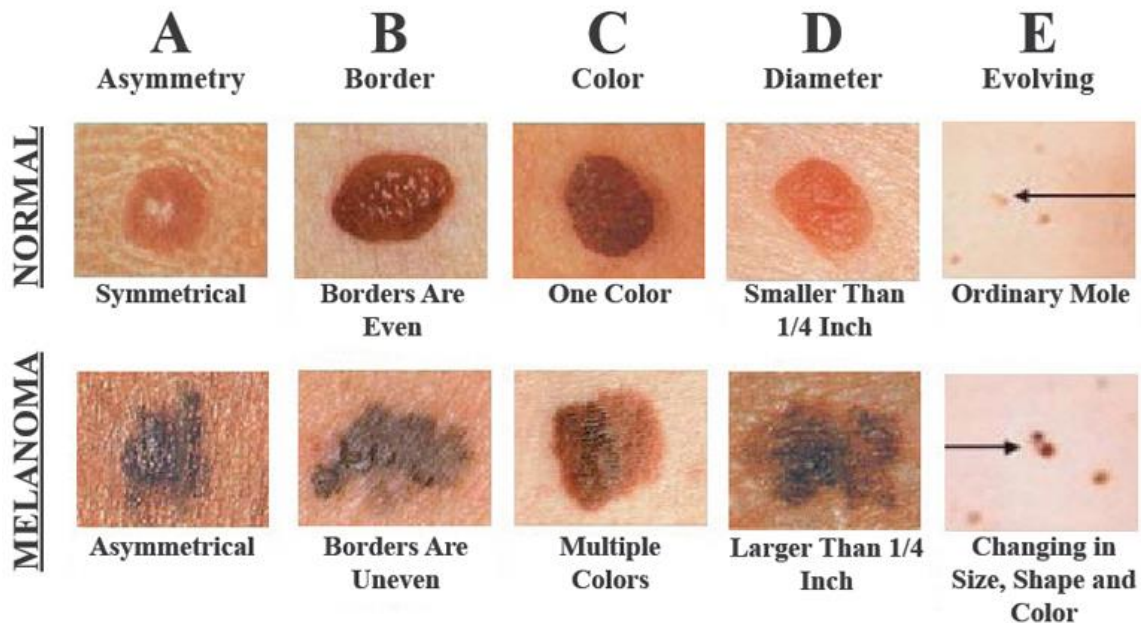
ارتد قفازاً إذا كنت تتوقع ملامسة الدم، الغشاء المخاطي، أي سائل من الجسم، أو جرح مفتوح على جلدك.

□ Lesions are traumatic or pathologic changes in previously normal structures. When a lesion develops on previously unaltered skin, it is **primary**.

الآفات تكون صابدة أو مرضية تغيرات في ما كان طبيعياً سابقاً الهياكل. عندما تتكون آفة على بشرة لم تتغير من قبل، هو أساسي

□ However, when a lesion changes over time or because of a factor such as scratching or infection, it is **secondary**.

ومع ذلك، عندما تتغير الآفة مع مرور الوقت أو بسبب عامل مثل الحكّة أو العدوى، هو ثانوي

The ABCDEs of Detecting Melanoma**Procedure: Inspect and Palpate the Hair**

الإجراء: فحص ولمس الشعر

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Color لون □ Hair color comes from melanin production and may vary from pale blonde to total black. لون الشعر يأتي من إنتاج الميلانين وقد تتفاوت من الأشقر الفاتح إلى الأسود الكامل. □ Graying begins as early as the 30s as a result of genetic factors. يبدأ الشيب في الظهور مبكراً في الثلاثينات نتيجة من العوامل الجينية.	

Texture قوام □ Scalp hair may be fine or thick and look straight, curly, or kinky. It should look shiny. قد تكون شعرة فروة الرأس ناعمة أو كثيفة وتبدو مستقيمة، مجعد، أو خشن. يجب أن يبدو لامعاً.	□ Note dull, coarse, or brittle scalp hair. لاحظ فروة الرأس الباهتة أو الخشنة أو الهشة. 
Lesions آفات □ The scalp should be clean and free of any lesions or pest inhabitants. يجب أن يكون فروة الرأس نظيفة وخالية من أي الآفات أو الكائنات المسببة للمرض. □ Many people normally have seborrhea (dandruff), which is indicated by loose white flakes. العديد من الناس عادة يعانون من دهنية الجلد (القشرة)، والتي تشير إليها القشور البيضاء المتساقطة.	□ Distinguish dandruff from nits (eggs) of lice, which are oval, adhere to the hair shaft, and cause intense itching. تمييز قشرة الرأس عن بيض القمل (بيض) الذي يكون بيضاوي الشكل، يلتصق إلى ساق الشعر، وتسبب شعوراً شديداً حكة.

Procedure: Inspect and Palpate the Nails

الإجراء: فحص وتلمس الأظافر

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Shape and Contour الشكل والملمس □ The nail surface is normally slightly curved or flat, and the posterior and lateral nail folds are smooth and rounded. سطح الظفر يكون عادة قليلاً منحنياً أو مسطحاً، والخلفي و التثنيتات الجانبية للأظافر ناعمة و ممتددة. □ Nail edges are smooth, rounded, and clean, suggesting adequate self-care. حواف الأظافر ناعمة ومستديرة و نظيفة، مما يوحي بالعناية الذاتية الكافية. □ View the index finger at its profile and note the angle of the nail base; it should be about 160 degrees. انظر إلى الإصبع السبابة من جانبه و لاحظ زاوية قاعدة الظفر؛ يجب أن يكون حوالي 160 درجة. □ The nail base is firm to palpation. قاعدة الظفر صلبة عند اللمس. □ Curved nails with a convex profile are a variation of normal. الأظافر المقوسة ذات الملف المحدب هي اختلاف عن الطبيعي. □ They may look like clubbed nails, but notice that the angle between nail base and nail is normal (i.e., 160 degrees or less). قد تبدو مثل الأظافر المضخمة، لكن لاحظ الزاوية بين قاعدة الظفر و الظفر طبيعي (أي 160 درجة أو أقل).	□ Spoon nails (concave curves) may occur with iron-deficiency anemia. قد تظهر أظافر الملعقة (المنحنيات المقعرة) مع فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. □ Paronychia (inflammation of base of nail) occurs with trauma or infection. التهاب محيط الظفر (التهاب قاعدة الظفر) يحدث مع الصدمة أو العدوى. □ Jagged nails, nails bitten to the quick, or traumatized nail folds from chronic nervous picking suggest nervous habits. أظافر مسننة، أظافر مضطومة حتى اللحم، أو تثنيتات الأظافر المتضررة من المزمن الخدش في الشعر تشير إلى عادات قلق. □ Chronically dirty nails suggest poor self-care or occupations in which it is impossible to keep them clean. الأظافر القذرة المزمنة تشير إلى ضعف العناية بالنفس أو الوظائف التي تكون فيها الرعاية أو الوظائف التي تكون فيها من المستحيل إبقاؤهم نظيفين. □ Clubbing of nails occurs with congenital, cyanotic heart disease; emphysema; and chronic bronchitis. تتورم الأظافر مع الحالات الخلقية، أمراض القلب الزرقاء، الانفاخ، الرئوي و الالتهاب الشعبي المزمن. □ In early clubbing the angle straightens out to 180 degrees, and the nail base feels spongy to palpation في الحالات المبكرة، يستقيم الزاوية إلى 180 درجة، وتشعر قاعدة الظفر نسيجي عند اللمس.
Consistency الاتساق □ The nail surface is smooth and regular, not brittle or splitting. سطح الظفر ناعم ومنتظم، ليس هشاً أو متشققة. □ The nail adheres firmly to the nail bed, and the nail base is firm to palpation. الظفر يلتصق بقوة بسرير الظفر، وقاعدة الظفر صلبة عند اللمس.	□ Pits, transverse grooves, or lines may indicate a nutrient deficiency or accompany acute illness with disturbed nail growth. قد تكون هناك حفر أو أخاديد عرضية أو خطوط تشير إلى نقص في عنصر غذائي أو قد يصاحب المرض الحاد اضطراب نمو الأظافر. □ Nail thickness is uniform. Nails are thickened, ridged, with arterial insufficiency. سمك الأظافر متجانس. الأظافر هي سميك، محطوط، مع شرياني قصور. □ A spongy nail base accompanies clubbing. قاعدة الظفر الإسفنجية تصاحب التضخم إلى التواء.

Color □ The translucent nail plate shows a pink nail bed underneath. لوحة الظفر الشفافة تظهر لونا ورديا □ Dark-skinned people may have brown-black pigmented areas or linear bands or streaks along the nail edge. قد يكون لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة لون بني-مناطق أو شرائط سوداء ملونة مناطق على حافة الظفر □ Many people normally have white hairline linear markings from trauma or picking at the cuticle. الكثير من الناس عادة يكون لديهم لون ابيض خطوط دقيقة على فروة الرأس نتيجة الإصابة أو نتف الجلد حول الظفر □ Note any abnormal markings in the nail beds. لاحظ أي علامات غير طبيعية في الظفر	□ Cyanosis or marked pallor. الزرقة أو شحوب واضح □ Brown linear streaks are abnormal in light-skinned people and may indicate melanoma. الخطوط البنية الطولية غير طبيعية في الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة وقد يشير إلى سرطان الجلد الميلاني □ Splinter hemorrhages occur with subacute bacterial endocarditis; transverse ridges, or Beau's lines, occur with trauma. سقطان النزيفات الشظوية مع التهاب الشغف البكتيري تحت الحاد تحدث الحزور العرضية، أو خطوط بو، مع الصدمة
□ Capillary Refill. Depress the nail edge to blanch and then release, noting the return of color. إعادة امتلاء الشعيرات الدموية. اضغط على الظفر الحافة للتبييض ثم التحرير، مع الملاحظة عودة اللون □ Normally color return is instant or within a few seconds in a cold environment. This indicates the status of the peripheral circulation. عادة ما يكون عودة اللون فوريا أو خلال بضع ثوان في بيئة باردة هذا يشير إلى حالة الجهاز الطرفي □ A sluggish color return takes longer than 1 or 2 seconds. دوران عودة اللون البطيئة تستغرق وقتا أطول من ثانية أو اثنتين	□ Cyanotic nail beds or sluggish color return—Consider cardiovascular or respiratory dysfunction. أظافر زرقاء أو لون بطيء العودة—فكر في القلب أو خلل في الجهاز التنفسي

Koilonychia in iron deficiency anaemia



- Koilonychia or spoon-shaped nails in iron deficiency anaemia. Koilonychia has a high degree of specificity for iron deficiency but it is a relatively uncommon feature, occurring only in severe chronic iron deficiency.





Paronychia

أظافر مسننة

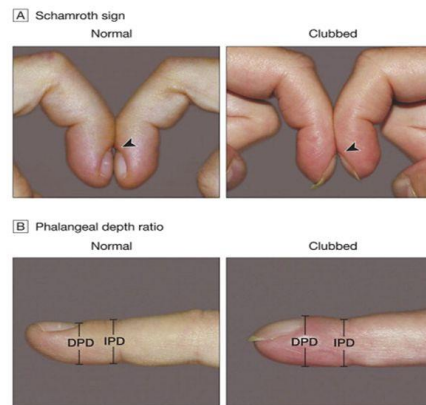
التهاب حول الظفر



Jagged nails



Examination: Schamroth Sign



Cyanosis of the nail beds

ADAM.

جامعة البيان كلية التمريض المرحلة الثانية

مادة التقييم الصحي والفحص البدني

عملي / مختبر 3

Review of Systems:
Head, Neck &
Regional Lymphatics



Head, Neck, & Cervical lymph node Assessment

الرأس، الرقبة،

Objectives:

الأهداف:

At the end of this lab, the student will be able to:
في نهاية هذا المختبر، سيكون الطالب قادراً على:

- Demonstrate the ability to safely and accurately complete a comprehensive examination of head, neck, & lymph node
إظهار القدرة على إكمال مهمة شاملة بأمان ودقة
فحص الرأس والعنق
- Demonstrate the ability to accurately & comprehensively document assessment data in an organized & legible manner.
إظهار القدرة على الدقة
البيانات بشكل منظم
- Evaluate assessment data to determine problems & identify client's concerns.
تقييم بيانات التقييم لتحديد المشكلات

Preparation/ Equipment:

التحضير / المعدات:

- Clean gloves
قفازات نظيفة
- Small cup of water for client during thyroid exam
كوب صغير من الماء للعميل أثناء فحص الغدة الدرقية

SUBJECTIVE DATA:

البيانات الشخصية:

1. Headache
1. صداع
2. Head injury
2. إصابة في الرأس
3. Dizziness
3. الدوخة
4. Neck pain
4. ألم الرقبة
5. Limitation of motion
5. محدودية الحركة
6. Lumps or swelling
6. كتل أو تورم

OBJECTIVE DATA:

البيانات الموضوعية:

Procedure: The Head / Inspect and Palpate the Skull and Scalp for the followings:
الإجراء: الرأس / فحص وجس الجمجمة وفروة الرأس من أجل الأمور التالية:

- Size
الحجم
- Shape (symmetrical & round)
شكل (متماثل)
- Consistency (hard & smooth)
الاتساق (صعب)

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Normocephalic describes a round, symmetric skull appropriately related to body size. نورموشيفاليك يصف جمجمة دائرية ومتناظرة مرتبطة بشكل مناسب بحجم الجسم.	Microcephaly — صغير الرأس Abnormally small head.
□ The skull normally feels symmetric and smooth. عادة ما يكون الجمجمة متساوية ومستوية الملمس. □ The cranial bones with normal protrusions are the forehead, the lateral edge of each parietal bone, the occipital bone, and the mastoid process behind each ear. العظام الجمجمية ذات البروزات الطبيعية هي الجبهة، الحافة الجانبية لكل عظمة جدارية، وعظمة مؤخرة الرأس، والبنوة الخشائية خلف كل أذن. □ There is no tenderness to palpation. لا يوجد أي حساسية عند التحسس.	□ Macrocephaly— كبيرة الرأس Abnormally large head (e.g., hydrocephaly and acromegaly). رأس كبير بشكل غير طبيعي (مثل الانتسقاء الدماغي و (جيزة الأطراف الكبيرة). □ Lumps, depressions, or abnormal protrusions. نتوءات أو انخفاضات، أو انتفاخات غير طبيعية.
□ Palpate the temporal artery above the zygomatic (cheek) bone between the eye and the top of the ear. اضغط على الشريان الصدغي فوق عظمة الوجنة (الخد) العظم بين العين وأعلى الأذن. □ Palpate the temporomandibular joints (TMJ) located anterior to each ear as the person opens the mouth and note normally smooth movement with no limitation or tenderness. تحسس مفاصل الفك الصدغي (TMJ) الموجودة في الأمام لكل أذن بينما يفتح الشخص فمه و الملاحظة بشكل طبيعي حركة سلسة بدون أي قيود أو ألم.	□ Crepitation, limited range of motion, or tenderness. فرقعة، نطاق محدود الحركة، أو الحساسية.

Range of Microcephaly Severity



MACROCEPHALY

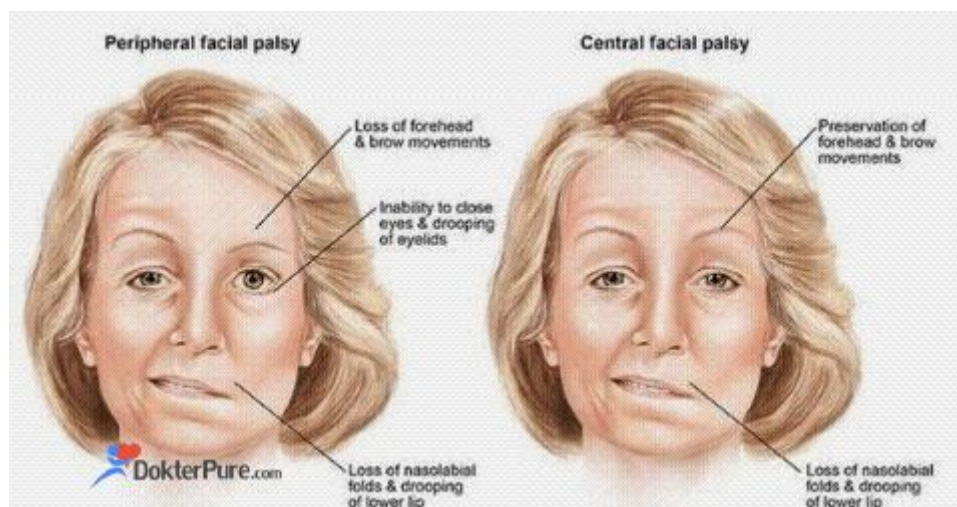
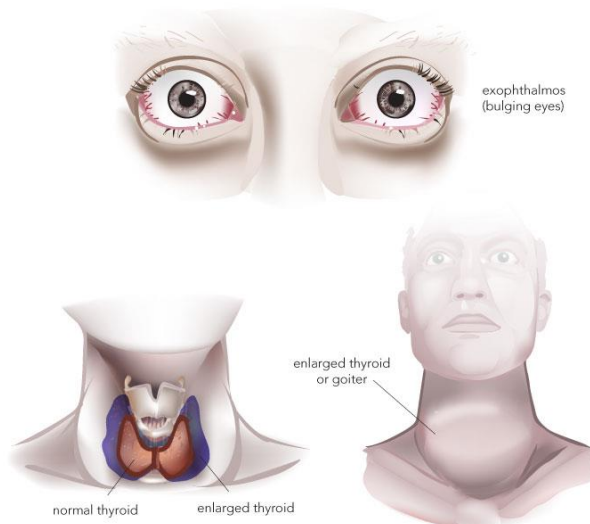
- **Definition:** Head circumference (occipito frontal)
> 2 standard deviation(SD) above the mean for age
and sex.



Procedure: The Head / Inspect and Palpate the face (symmetry & facial features)

الإجراء: الرأس / فحص الوجه ولمسه (التأظر)

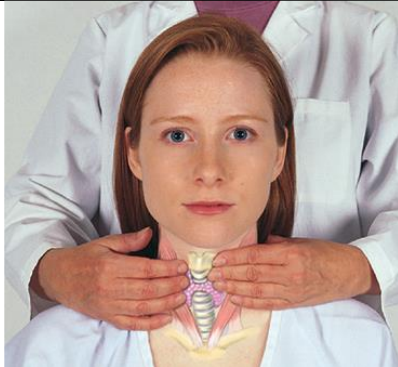
Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
- Note the facial expression and its appropriateness to behavior or reported mood. لاحظ تعبير الوجه و ملائمة للسلوك أو ما تم الإبلاغ عنه مزاج. - Anxiety is common in hospitalized or ill persons. القلق شائع بين المرضى أو المحتجزين في المستشفى الأشخاص.	Hostility or aggression. Tense, rigid muscles may indicate anxiety or pain; a flat affect may indicate depression. عداوة أو عدوان. متوتر، متصلب قد تشير العضلات إلى القلق أو الألم؛ أ التعبير العاطفي البارد قد يشير إلى الاكتئاب.
- Note symmetry of eyebrows, palpebral fissures, nasolabial folds, and sides of the mouth. لاحظ تماثل الجوانب والجمجمة الجفنية الشقوقات، التجاعيد الأنفية الشفوية، وجوانب الفم. - Note any abnormal facial structures (coarse facial features, exophthalmos, and changes in skin color or pigmentation) or any abnormal swelling. لاحظ أي تشوهات في ملامح الوجه (ملامح وجه خشنة، وجحوظ العينين، و تغيرات في لون الجلد أو تصبغه) أو أي تورم غير طبيعي. - Also note any involuntary movements (tics) in the facial muscles. Normally there are none. لاحظ أيضاً أي حركات لا إرادية (الحركات اللاإرادية) في عضلات الوجه. عادة هناك لا يوجد.	- Marked asymmetry shows with central brain lesion (e.g., stroke) or with peripheral cranial nerve VII damage (e.g., Bell palsy – facial palsy-). يظهر التفاوت الواضح في المنتصف أفة دماغية كمثال السكتة الدماغية) أو مع تلف العصب القحفي السابع الطرفي (على سبيل المثال، شلل بيل – شلل الوجه –). (e.g., Bell palsy – facial palsy-). - Edema in the face is noted first around the eyes (periorbital) and the cheeks, where the subcutaneous tissue is relatively loose. لاحظ الوذمة في الوجه أولاً حول العينان (حول العين) والخدود، أين يوجد النسيج تحت الجلد رخوا نسبياً. - Note grinding of jaws, tics or fasciculation, or excessive blinking. لاحظ طحن الكفين، أو التمركات اللاإرادية أو ارتعاش العضلات، أو الرمش المفرط.



Procedure: The Neck / Inspect and Palpate the Neck

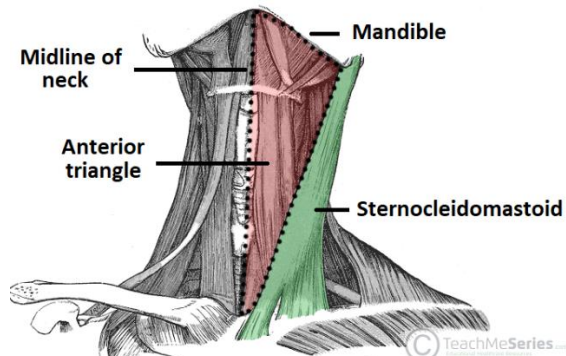
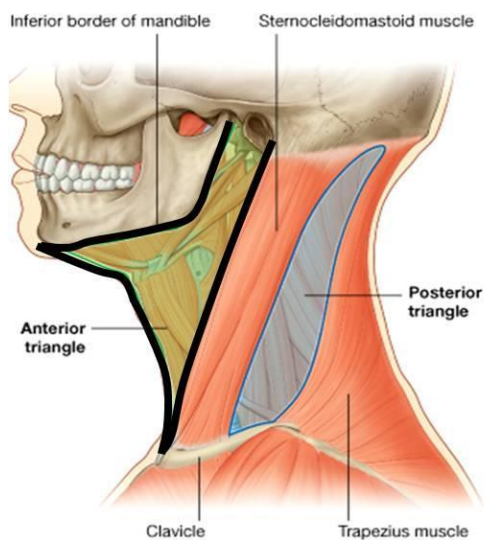
الإجراء: الرقبة / فحص الرقبة بالمعاينة واللمس

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Symmetry. Head position is in the midline; accessory neck muscles are symmetric. التناظر: وضع الرأس في الخط الوسيط: عضلات الرقبة المساعدة متماثلة.	Head tilt occurs with muscle spasm. يميل الرأس مع تشنج العضلات. Head and neck rigidity occurs with arthritis. تصلب الرأس والرقبة يحدث مع التهاب المفاصل.
- Range of Motion. Ask the person to touch the chin to the chest, turn the head to the right and left, try to touch each ear to the shoulder (without elevating shoulders), and extend the head backward. مدى الحركة: اطلب من الشخص أن يلمس الذقن إلى الصدر، أدير الرأس إلى اليمين ويسار، حاول لمس كل أذن الكتف (دون رفع الكتفين)، وامتد الرأس للخلف. - When the neck is supple, motion is smooth and controlled. عندما يكون الرقبة مرنة، يكون الحركة سلسة وتحت السيطرة.	- Note any limitation of movement. لاحظ أي محدودية في الحركة. - Note pain at any particular movement. لاحظ الألم عند أي حركة معينة. - Note ratchet movement or limitation of movement, as with cervical arthritis or inflammation of neck muscles. ملاحظة حركة أو قيد السقاطة من الحركة، كما في التهاب المفاصل العنقي أو التهاب عضلات الرقبة. - With arthritis the neck is rigid, and the person turns at the shoulders rather than the neck. مع التهاب المفاصل، يكون الرقبة صلبة، و الشخص يدور عند الكتفين بدلاً من ذلك من الرقبة.
- Lymph Nodes. Using a gentle circular motion of your finger pads and beginning with the preauricular lymph nodes in front of the ear. العقد اللمفاوية: استخدام حركة دائرية لطيفة من أطراف أصابعك والبدء مع العقد اللمفاوية قبل الأذنية من الأمام. - Palpate the 10 groups of lymph nodes in a routine order. أفحص 10 مجموعات من العقد اللمفاوية في طلب روتيني. - Be systematic and thorough. كن منهجياً وشاملاً. - Use gentle pressure because strong pressure could push the nodes into the neck muscles. استخدم ضغطاً خفيفاً لأن الضغط القوي قد يدفع العقد إلى عضلات الرقبة. - It is usually most efficient to palpate with both hands, comparing the two sides for the symmetry, their location, size, shape, delimitation (discrete or matted together), mobility, consistency, and tenderness. عادة ما يكون من الأكثر كفاءة أن تتحسس بكلتا اليدين، مقارنة الجانبين من أجل التناظر، موقعهم، الحجم، الشكل، التحديد (منفصل أو متجمع معاً)، الحركة، الاتساق، والنعومة.	Lymphadenopathy is palpable يمكن الشعور بتضخم الغدة اللمفاوية enlargement of the lymph nodes (>1 cm) from infection, allergy, or neoplasm. تضخم الغدة اللمفاوية (>1 سم) من العدوى أو الحساسية أو الورم. <u>The following are commonly associated with lymphadenopathy but are not definitive in all circumstances:</u> فيما يلي ما يرتبط عادةً مع تضخم العقد اللمفاوية لكنهم ليسوا نهائياً في جميع الظروف: • Acute infection—Nodes are bilateral, enlarged, warm, tender, and firm but freely movable. • عدوى حادة—العقد ثنائية الجانب، متضخم، دافئ، طري، وصلب لكن قابل للحركة بحرية. • Chronic inflammation, e.g., in tuberculosis the nodes are clumped. • الالتهاب المزمن، على سبيل المثال، في الدرن، العقد متكتلة. • Cancerous nodes are hard, enlarged, unilateral, nontender, and fixed. • العقد السرطانية تكون صلبة ومتضخمة، من جانب واحد، غير مؤلم، وثابت.
Cervical nodes often are palpable in healthy people, although palpability decreases with age. Normal nodes feel movable, discrete, soft, and nontender. غالباً ما تكون العقد العنقية ملموسة لدى الأشخاص الأصحاء الذين، على الرغم من أن الملموسة تقل مع العمر. العقد الطبيعية تكون قابلة للحريك ومنفصلة.	• Nodes in persons with HIV infection are enlarged, firm, nontender, and mobile. • العقد لدى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية هي متضخم، صلب، غير مؤلم، وقابل للحركة. - Occipital lymphadenopathy is common. تضخم العقد اللمفاوية القذالية شائع.
- If nodes are enlarged or tender, check the area they drain for the source of the problem. إذا كانت العقد متضخمة أو مؤلمة، تحقق من المنطقة التي يصرفون منها للمصدر. - Look proximal (upstream) to the location of the node, e.g., the nodes in the upper cervical or submandibular area often relate to inflammation or a neoplasm in the head and neck. انظر بالقرب (أعلى مجرى) من موقع العقد، على سبيل المثال، العقد في الأعلى غالباً ما تتعلق بمنطقة الرقبة أو تحت الفك إلى التهاب أو ورم في الرأس والرقبة. - Follow up on or refer your findings. تابع نتائجك أو أحلها للآخرين. - An enlarged lymph node deserves prompt attention, particularly when you cannot find the source of the problem. عقدة لمفية متضخمة تستحق السرعة الانتباه، خاصة عندما لا تستطيع أن تجد مصدر المشكلة.	• A single, enlarged, nontender, hard left supraclavicular node may indicate a neoplasm in the thorax or abdomen. • واحدة، متضخمة، غير مؤلمة، صلبة على اليسار العقدة فوق الترقوية قد تشير إلى ورم في الصدر أو البطن. • Painless, rubbery, discrete nodes that appear gradually occur with Hodgkin lymphoma. • عقد غير مؤلمة، مطاطية، منفصلة والتي تظهر تدريجياً مع هودجكين سرطان الغدة اللمفاوية.
- Thyroid Gland. Position a standing lamp to shine tangentially across the neck to highlight any possible swelling. الغدة الدرقية: ضع مصباحاً واقعياً ليضيء تلمع بجانب الرقبة إلى إبراز أي تورم محتمل. - Supply the person with a glass of water and first inspect the neck as the person takes a sip and swallows. زود الشخص بكوب من الماء، أفحص الرقبة أولاً بينما يأخذ الشخص يرسف وبلع.	

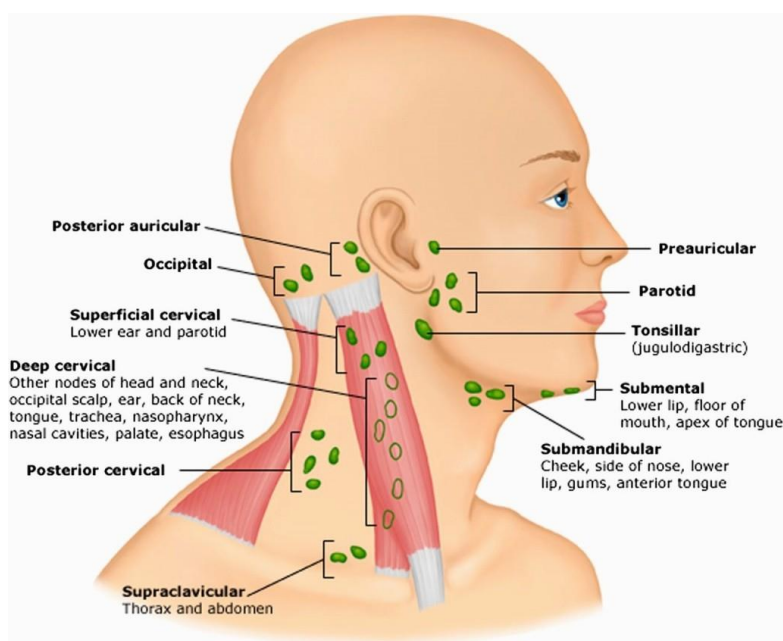
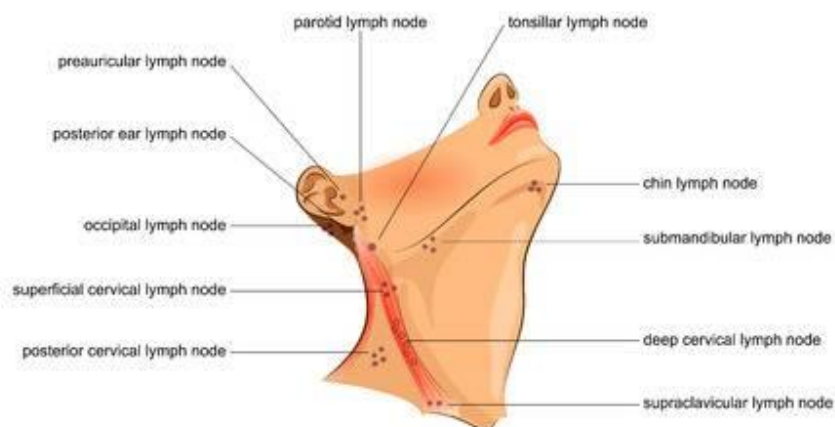
□ Thyroid tissue moves up with a swallow. يبتلع تسيج الغدة الدرقية يعلو على عند البلع. □ To palpate the thyroid, move behind the person. لمس الغدة الدرقية، تحرك إلى الخلف شخص. □ Ask him or her to sit up very straight and then bend the head slightly forward and to the right. اطلب منه أو منها أن يجلس بشكل مستقيم جداً أو ثم انحن بالراس قليلا إلى الأمام وإلى اليمين. □ This relaxes the neck muscles on the right side. هذا يرخي عضلات الرقبة على الجانب الأيمن جانبي. □ Use the fingers of your left hand to push the trachea slightly to the right. استخدم أصابع يديك اليسرى لدفع القصبة الهوائية مائلة قليلا إلى اليمين.	
□ Curve your right fingers between the trachea and the sternomastoid muscle, retracting it slightly, and ask the person to take a sip of water. قم بثنى أصابعك اليمنى بين القصبة الهوائية وذراع صدريه الرقبة، مع سحبها للخلف بشكل طفيف، واطلب من الشخص أن يأخذ رشفة من ماء. □ The thyroid moves up under your fingers with the trachea and larynx as the person swallows. الغدة الدرقية تتحرك تحت أصابعك مع القصبة الهوائية والحنجرة مثال الشخص السنتوي. □ Reverse the procedure for the left side. اعكس الإجراء للجانب الأيسر. □ Usually you cannot palpate a normal adult thyroid. عادة لا يمكنك لمس بالغ طبيعى الغدة الدرقية. □ If the person has a long, thin neck, you sometimes can feel the thyroid isthmus over the tracheal rings. إذا كان الشخص لديه رقبة طويلة ورقيقة، أنت أحيانا يمكن أن تشعر بجسم الغدة الدرقية الحلقاء القصية. □ The lateral lobes usually are not palpable; check them for enlargement, consistency, symmetry, and the presence of nodules. الفصوص الجانبية عادة لا يمكن لمسها؛ افحصهم للتضخم، والاتساق، والتناظر، ووجود العقيدات.	□ Abnormalities include enlarged lobes that are easily palpated before swallowing or that are tender to palpation or the presence of nodules or lumps تشمل الشذوذات فصوصا متضخمة التي يمكن الشعور بها بسهولة قبل البلع أو التي تكون حساسية لـ اللمس أو وجود عقيدات أو كتوءات



Head range of motion
نطاق حركة الرأس



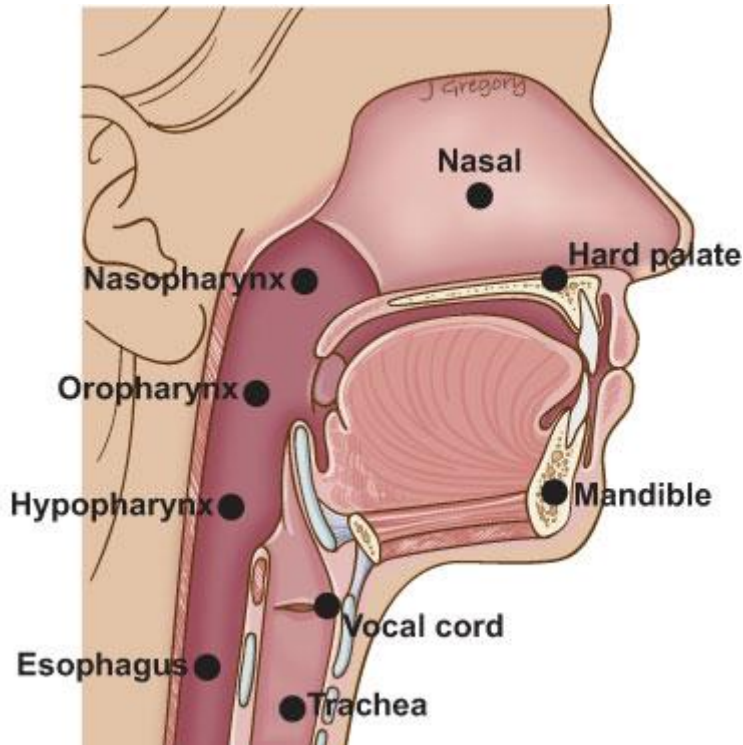
ANATOMY OF CERVICAL LYMPH NODES



جامعة البيان كلية التمريض المرحلة الثانية

مادة التقييم الصحي والفحص البدني

عملي / مختبر 4



Nose, Mouth & throat Assessment الأنف، الفم

Nose, Mouth & Throat (Oropharynx) Assessment
الأنف، الفم**Objectives:**
الأهداف:

At the end of this lab, the student will be able to:

في نهاية هذا المختبر، سيكون الطالب قادراً على:

- Identify & list history questions related to nose & sinus.
حدد
- Chose appropriate assessment technique for evaluating Nose, Sinus, Mouth & Oropharynx.
• اختر التقنية المناسبة للتقييم للأنف، الجيوب، الفم
- Discuss the safe and accurate method of using equipment in nose & sinus
• مناقشة الطريقة الآمنة والدقيقة لاستخدام المعدات في الأنف
- Demonstrate the ability to safely and accurately complete & document a comprehensive examination of nose, mouth & oropharynx in organized & eligible manner
• إظهار القدرة على إكمال المهام بأمان ودقة
فحص شامل للأنف والفم
بطريقة مؤهلة

SUBJECTIVE DATA:
البيانات الشخصية:**Nose**
أنف

1. Discharge
1. إفراز
2. Frequent colds (upper respiratory infections, or URI)
2. نزلات البرد المتكررة (التهابات الجهاز التنفسي العلوي، أو URI)
3. Sinus pain
3. ألم الجيوب الأنفية
4. Trauma
4. الصدمة
5. Epistaxis (nosebleeds)
5. نزيف الأنف (الرغاف)
6. Allergies
6. الحساسية
7. Altered smell
7. تغير حاسة الشم

Mouth and Throat
الفم والحنك

8. Sores or lesions
8. القرح أو الإفات
9. Sore throat
9. التهاب الحلق
10. Bleeding gums
10. نزيف اللثة
11. Toothache
11. وجع الأسنان
12. Hoarseness
12. بحة في الصوت
13. Dysphagia
13. صعوبة البلع
14. Altered taste
14. تغير في الطعم
15. Smoking, alcohol consumption
15. التدخين، شرب الكحول
16. Patient-centered care (dental care pattern, dentures or appliances)
16. الرعاية التي تركز على المريض (نمط رعاية الأسنان، الأسنان الصناعية أو الأجهزة)

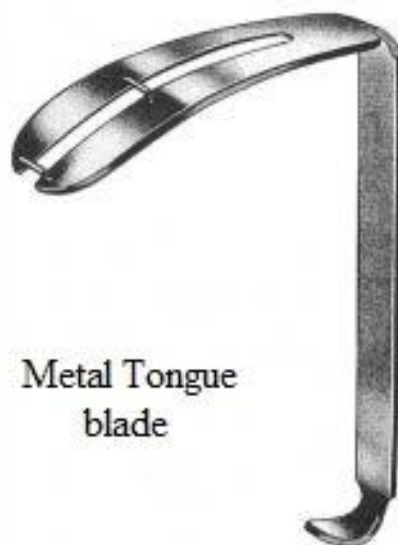
Preparation:
التحضير:

- Position the person sitting up straight with his or her head at your eye level.
• ضع الشخص جالساً بشكل مستقيم مع جعل رأسه في مستوى عينيك.
- Remove dentures.
• أزل الأسنان الصناعية.

Equipment needed:
المعدات المطلوبة:

- Otoscope with short, wide-tipped nasal speculum attachment or nasal speculum and penlight
• منظار أذن مع وصلة ميسم أنفي قصيرة وعريضة أو ميسم أنفي وفلم ضوء
- Tongue blade
• شفرة لسان
- Cotton gauze pad (4 × 4 inches)
• ضماد شاش قطني (4 × 4 بوصة)
- Gloves
• قفازات

NASAL SPECULUM



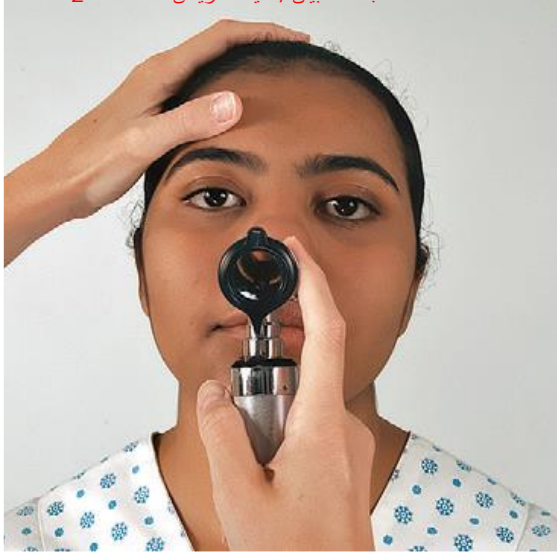
OBJECTIVE DATA:

البيانات الموضوعية:

Procedure: Inspect and Palpate the Nose

الإجراء: فحص واللمس للأنف

Normal Range of Findings	Abnormal Findings
المنطق الطبيعي للنتائج The nose is symmetric, in the midline, and in proportion to other facial features. Inspect for any deformity, asymmetry, inflammation, or skin lesions. الأنف متماثل، في الخط الأوسط، و نسبية إلى الملامح الأخرى للوجه. افحص من أجل أي تشوه، أو عدم تماثل، أو التهاب، أو آفات الجلد.	نتائج غير طبيعية Absence of sniff indicates obstruction, e.g., nasal polyps, rhinitis. غياب الشم يشير إلى وجود انسداد مثلاً: زوائد الأنفية، التهاب الأنف.
تخرجت الجيوب - Test the patency of the nostrils. - This reveals any obstruction, which can be explored later with the nasal speculum. اختبر مرور الهواء في فتحتي الأنف. هذا يكشف أي انسداد، والذي يمكن أن يكون تم استكشافه لاحقاً مع الأنف	مراة طبية Speculum
الجيوب الأنفية Attach the short, wide-tipped speculum to the otoscope head and insert into the nasal vestibule, avoiding pressure on the nasal septum. قم بإرفاق المنظار القصير ذو النهاية العريضة بال رأس منظار الأذن وأدخله في الأنف الدهليز، مع تجنب الضغط على الأنف	الكاسر - Inspect the nasal mucosa, noting its normal red color and a smooth moist surface. - Note any swelling, discharge, bleeding, or foreign body. افحص الغشاء المخاطي للأنف، مع ملاحظة حالته الطبيعية لون أحمر وسطح ناعم ورطب. لاحظ أي تورم، إفرازات، نزيف، أو جسم غريب.
- Observe the nasal septum for deviation, perforation, or bleeding. - A deviated septum is common and not significant unless airflow is obstructed. لاحظ الحاجز الأنفي للتحقق من أي انحراف، ثقب أو نزيف. انحراف الحاجز الأنفي شائع وليس له أهمية إلا إذا كان تدفق الهواء مستخدماً.	Rhinitis—Nasal mucosa is swollen and bright red with a URI. Discharge is common with rhinitis and sinusitis, varying from watery and copious to thick, purulent, and green-yellow. - With chronic allergy, mucosa looks swollen, boggy, pale, and gray. A deviated septum looks like a hump or shelf in one nasal cavity. Perforation is seen as a spot of light from penlight shining in other naris. Epistaxis commonly comes from the anterior septum. التهاب الأنف — الغشاء المخاطي للأنف متورم و أحمر فاقع مع URI. الإفراز. شائع مع التهاب الأنف و التهاب الجيوب الأنفية، يتفاوت من مائي و غزير إلى سميك، صديدي، وأخضر- أصفر. مع الحساسية المزمنة، تبدو الغشاء المخاطي منتفخ، رخوة، باهية ورملية. انحراف الحاجز الأنفي يبدو مثل نتوء أو رف في إحدى تجاويف الأنف. يرى الثقب كنقطة من الضوء من ضوء القلم الذي يلعب في منخر آخر. نزيف الأنف عادة يأتي من الحاجز الأمامي.
- Inspect the turbinates, the bony ridges curving down from the lateral walls. - The middle and inferior turbinates appear the same light red color as the nasal mucosa. - Note any swelling but do not try to push the speculum past it. Turbinates are quite vascular and tender if touched. افحص القرنيات، الحواف العظمية ينحني للأسفل من الجدران الجانبية. تبدو القرنيات الوسطى والسفلى نفس اللون الأحمر الفاتح مثل الغشاء المخاطي للأنف. لاحظ أي تورم ولكن لا تحاول دفع تجاوز المرأة القرنيات الأنفية كبيرة نوعاً ما وعائى وحساس عند لمسه.	Polyps are smooth, pale gray, avascular, mobile, and nontender. الزوائد اللحمية ناعمة، وشاحبة ولامدية، خالي من الأوعية الدموية، متحرك، وغير مؤلم.
Note any polyps, benign growths that accompany chronic allergy, and distinguish them from normal turbinates. لاحظ أي زوائد، نمو حميد الذي يصاحب الحساسية المزمنة، ويميزهم عن الثوربينات العادية.	



Palpate the Sinus Areas

افحص مناطق الجيوب الأنفية باللمس

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
- Using your thumbs, press over the frontal sinuses below the eyebrows and over the maxillary sinuses below the cheekbones. - Do not press directly on the eyeballs. - The person should feel firm pressure but no pain.	Sinus areas are tender to palpation in people with chronic allergies and acute infection (sinusitis).

Inspect the Mouth

افحص الفم

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Lips شفايف	
- Inspect the lips for color, moisture, cracking, or lesions. - Black persons may have bluish lips, which is normal.	- In light-skinned people circumoral pallor occurs with shock and anemia; cyanosis with hypoxemia and chilling; cherry red lips with carbon monoxide poisoning; acidosis from aspirin poisoning, or ketoacidosis. Cheilitis (perleche)—cracking at the corners. Herpes simplex, other lesions



Types of Cheilitis



**Angular
Cheilitis**



**Granulomatous
Cheilitis**



**Actinic
Cheilitis**



**Exfoliative
Cheilitis**



**Eczematous
Cheilitis**

© www.medindia.net



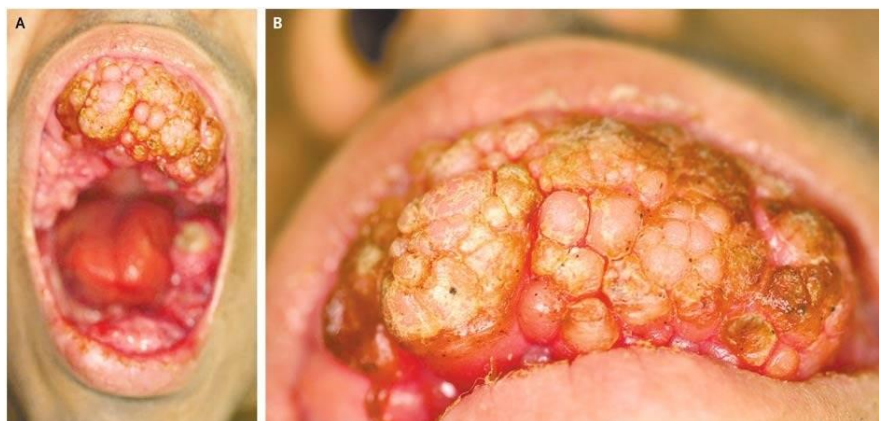
Herpes simplex



Figure 3. Blisters (herpes simplex) on the inner and outer surfaces of the lower lip.

Herpes simplex

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Teeth and Gums الأسنان واللثة	
- Teeth normally appear white, straight, evenly spaced, and clean and free of debris or decay. عادة ما تكون الأسنان بيضاء ومستقيمة، متباعدة بالتساوي، ونظيفة وخالية من الحطام أو التسوس. - Note any diseased, absent, loose, or abnormally positioned teeth. لاحظ أي مرض، أو غيب، أو ارتخاء، أو الأسنان الموجودة في وضع غير طبيعي.	- Discolored teeth—appear brown with excessive fluoride use, yellow with tobacco use. الأسنان المتغيرة اللون—تظهر بنية مع الاستخدام المفرط للفلوريد، أصفر مع استخدام التبغ. - Grinding down of tooth surface. طحن سطح السن. - Plaque—Soft debris. Caries— اللويحة—الحطام الطري. التسوس— - Decay. تسوس.
- Ask the person to bite and note alignment of the upper and lower jaw. اطلب من الشخص أن يعض ودون ملاحظة الفك العلوي والسفلي. - Normal occlusion in the back is upper teeth resting directly on the lowers; in the front, the upper incisors slightly override the lower incisors. الإطباق الطبيعي في الخلف هو الأسنان العليا يمتد مباشرة على الأسنني، من الأمام، القواطع العلوية تتجاوز قليلا القواطع السفلية.	Malocclusion, e.g., protrusion of upper or lower incisors. سوء الإطباق، مثل بروز الأسنان العلوية أو الأسنان الأمامية السفلية.
- Normally, the gums look pink or coral with a stippled (dotted) surface. عادة، اللثة تبدو وردية أو بلون المرجان مع سطح منقط (منقط). - Gum margins are tight and well defined. حواف اللثة صلبة ومحددة جيدا. - Check for swelling; retraction of gingival margins; and spongy, bleeding, or discolored gums. تحقق من الانتفاخ؛ انجسار اللثة؛ والهوامش؛ وسوي، تارف، أو لثة متغيرة اللون. - Black people normally may have a dark, melanotic line along the gingival margin. هامة قد يكون لدى الأشخاص السود بشرة داكنة، خط ملائيمي على طول حافة اللثة.	Gingival hypertrophy, crevices between teeth and gums, pockets of debris. تضخم اللثة، الشقوق بين الأسنان والأسنان واللثة، جيوب من الحطام. - Gums bleed with slight pressure, indicating gingivitis. اللثة تنزف مع ضغط خفيف، يشير إلى التهاب اللثة. - Dark line on gingival margins occurs with lead and bismuth poisoning. ظهور خط داكن على حواف اللثة بالتسمم بالرصاص والبيزموت.



Medication induced Gingival hypertrophy

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Tongue لسان	
- The tongue color is pink and even. لون اللسان وردي ومنتظم. - The dorsal surface is normally roughened from the papillae. السطح الظهري عادة ما يكون خشنياً من الحليمات. - A thin white coating may be present. قد يكون هناك طبقة رقيقة بيضاء. - Ask the person to touch the tongue to the roof of the mouth. اطلب من الشخص لمس اللسان بـ سقف الفم. - Its ventral surface looks smooth and glistening and shows veins. سطحه البطني يبدو ناعماً ولامعاً ويظهر الأوردة. - Saliva is present. اللعاب موجود.	- Beefy red, swollen tongue. لسان أحمر منتفخ وسمين. - Smooth glossy areas. مناطق ناعمة لامعة. - Enlarged tongue occurs with mental retardation, hypothyroidism, and acromegaly. يحدث تورم اللسان مع المشكل العقلي، تأخر في النمو، قصور الغدة الدرقية، و تضخم الأطراف. - Dry mouth occurs with dehydration, fever; tongue has deep vertical fissures. جفاف الفم يحدث مع الجفاف، حمى؛ اللسان فيه شقوق عمودية عميقة.
- With a glove, hold the tongue with a cotton gauze pad for traction and swing it out and to each side. باستخدام قفاز، امسك اللسان بقماش قطني ضمادة شاش للسحب وتحريكها للخارج و لكل جانب. - Inspect for any white patches or lesions—normally none are present. افحص وجود أي بقع بيضاء أو تقرحات—عادة لا يوجد أي. - If any occur, palpate these lesions for induration. إذا حدث أي منها، افحص هذه الآفات باللمس من أجل التصلب.	Oral precancerous and cancerous lesions الأورام السابقة للسرطان والسرطانية في الفم آفات
- Carefully inspect the tongue and the entire U-shaped area under the tongue. افحص اللسان وجميع الأجزاء بعناية منطقة على شكل حرف U تحت اللسان. - Note any white patches, nodules, or ulcerations. لاحظ أي بقع بيضاء أو عقيدات أو قروح. - If lesions are present or with any person older than 50 years of age or with a positive history of smoking or alcohol use, put on a glove and palpate the area. إذا كانت هناك آفات أو مع أي شخص أكبر من 50 عاماً أو لديه نتيجة إيجابية تاريخ التدخين أو استخدام الكحول، ضع على ارتد قفازاً وفحص المنطقة باللمس. - Notice any induration. انتبه لأي تصلب.	- Excessive saliva and drooling. زيادة اللعاب وسيلان الفم. - Any lesion or ulcer persisting for more than 2 weeks must be investigated. أي آفة أو قرحة تستمر لفترة أطول يجب التحقيق في الأمور التي تتجاوز أسبوعين. - Indurated area may be a mass or lymphadenopathy and must be investigated. قد يكون الجزء المتصلب كتلة أو تضخم العقد الليمفاوية ويجب أن يكون تم التحقيق.



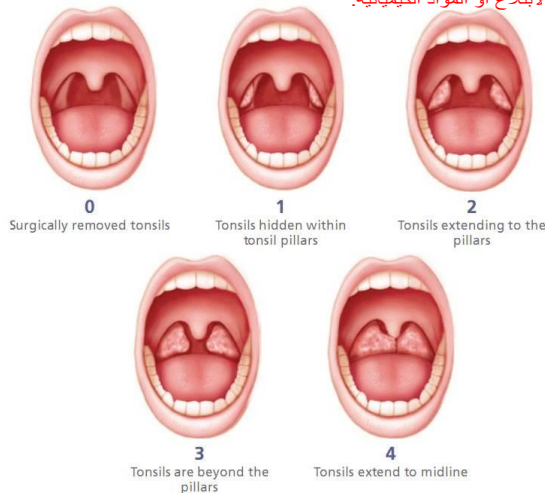
Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Buccal Mucosa الغشاء المخاطي للفم	
- The buccal mucosa looks pink, smooth, and moist, although patchy hyperpigmentation is common and normal in dark-skinned people. الطبقة المخاطية الخدية تبدو وردية وناعمة و رطبة، مع وجود فرط تصبغ متقطع هو شائع وطبيعي بين ذوي البشرة الداكنة. - Stensen's duct, the opening of the parotid salivary gland, looks like a small dimple opposite the upper second molar. قناة ستينسن، فتحة الغدة النكفية الغدة اللعابية، تشبه حفرة صغيرة مقابل الضرس العلوي الثاني. - You may also see a raised occlusion line on the buccal mucosa parallel with the level the teeth meet; this is due to the teeth closing against the cheek. قد ترى أيضا خط إنسداد مرتفع على الغشاء المخاطي الفمي بمحاذاة المستوى الذي تلتقي الأسنان؛ هذا بسبب إغلاق الأسنان على الخد. - Fordyce's granules are small, isolated white or yellow papules on the mucosa of cheek, tongue, and lips. حببيات فورديس صغيرة ومعزولة وبيضاء أو حطاطات صفراء على غشاء الخد المخاطي، اللسان والشفاة. - These little sebaceous cysts are painless and not significant. هذه الأكياس الدهنية الصغيرة غير مؤلمة و غير مهم.	- Dappled brown patches are present with Addison's disease (chronic adrenal insufficiency). توجد بقع بنية مرقطة مع مرض اديسون (الغدة الكظرية المزمنة قصور). - Orifice of Stensen's duct looks red with mumps. يبدو فوهة قناة ستينسن حمراء مع النكاف. - The chalky white raised patch of leukoplakia is precancerous. الرقعة البيضاء المرفوعة المطفية اللوكوبلاكيا هي حالة قبل سرطانية.

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Palate حنك	
- The more anterior hard palate is white with irregular transverse rugae. الحنك الصلب الأمامي أكثر بيضاء مع نتوءات عرضية غير منتظمة. - The posterior soft palate is pink, smooth, and upwardly movable. الحنك الرخو الخلفي وردي وناعم، وقابل للحريك للأعلى. - A common variation is a nodular bony ridge down the middle of the hard palate, a torus palatinus تكوين شائع هو حدية عظمية أسفل منتصف سقف الحلق الصلب، توروس بلاتينوس - Ask the person to say "ahhh" and note the soft palate and uvula rise in the midline. اطلب من الشخص أن يقول "اه" ولاحظ يعلو الحنك الرخو والبلع في الخط الوسطي. - This tests one function of cranial nerve X, the vagus nerve. هذا يختبر وظيفة واحدة للعصب القحفي العاشر، العصب المبهم.	- The hard palate appears yellow with jaundice. يبدو الحنك الصلب أصفر مع اليرقان. - In Blacks with jaundice it may look yellow, muddy yellow, or green-brown. في الأشخاص السود الذين لديهم صفرة قد يبدو أصفر، أصفر موحل، أو بني مائل إلى الأخضر. - Oral Kaposi's sarcoma is a bruise-like, dark red, macular lesion, usually on the hard palate, that is a common early lesion with AIDS. ساركوما كابوزي الفموية تبدو ككدمات، أحمر غامق، آفة بقعية، عادة على الحنك الصلب، هذا من الآفات المبكرة الشائعة معصاب بالإيدز. - A bifid uvula appears as if split in two; it is more common in Native Americans اللحامة المشقوق تظهر كما لو أنها منقسمة إلى جزأين؛ إنها أكثر شيوعا بين السكان الأصليين لأمريكا



Inspect the Throat
أفحص الحلق

Normal Range of Findings	Abnormal Findings
النتائج الطبيعية للتفتيش □ The tonsils are the same pink as the oral mucosa, and their surface is peppered with indentations or crypts. اللوزتان لونهما وردي مثل الفم الغشاء المخاطي، وسطحها مغطى بنقاط التجاويف أو المقابر الصغيرة. □ <u>There should be no exudate on the tonsils.</u> لا يجب أن يكون هناك إفرازات على اللوزتين. □ <u>Tonsils are graded in size as:</u> يتم تصنيف اللوزتين حسب الحجم كالآتي: □ 1+: Visible 1 : مرئي □ 2+: Halfway between tonsillar pillars and uvula 2: في منتصف الطريق بين أعمدة اللوزتين و uvula □ 3+: Touching the uvula 3 : لمس اللوزة □ 4+: Touching each other 4 : لمس بعضهما البعض □ You may normally see 1+ or 2+ tonsils in healthy people, especially in children. قد ترى عادة 1 أو 2 لوزة في الأشخاص الأصحاء خاصة الأطفال. □ Depress the tongue with a tongue blade. اضغط على اللسان باستخدام شفرة اللسان. □ Scan the posterior pharyngeal wall for color, exudate, and lesions. أفحص الجدار الخلفي للبلعوم للون، الإفرازات، والآفات. □ When finished, discard the tongue blade. بعد الانتهاء، تخلص من شفرة اللسان. □ Touching the posterior wall with the tongue blade elicits the gag reflex. لمس الجدار الخلفي باللسان الشفرة تسبب رد فعل القيء. □ This tests cranial nerves IX and X. هذا يختبر العصبين القحفيين التاسع والعاشر. □ Test cranial nerve XII, the hypoglossal nerve, by asking the person to stick out the tongue. It should protrude in the midline. اختبر العصب القحفي الثاني عشر، العصب تحت اللساني، من خلال طلب الشخص أن يخرج اللسان. يجب أن يبرز في الخط الوسطي. □ Children enjoy this request. يستمتع الأطفال بهذا الطلب. □ Note any tremor, loss of movement, or deviation to the side. لاحظ أي ارتعاش أو فقدان للحركة أو انحراف إلى الجانب.	النتائج غير طبيعية □ With an acute infection tonsils are bright red and swollen and may have exudate or large white spots. مع الإصابة الحادة، تكون اللوزتان متوهجتين مع الإصابة الحادة، تكون اللوزتان متوهجتين أحمر ومنتفخ وقد يكون هناك إفراز أو أحمر ومنتفخ وقد يكون هناك إفراز أو large white spots. □ A white membrane covering the tonsils may accompany infectious mononucleosis, leukemia, and diphthemia. غشاء أبيض يغطي اللوزتين قد يرافق العدوى أحادية النوى، سرطان الدم، والدفتيريا. □ Tonsils are enlarged to 2+, 3+, or 4+ with an acute infection. تضخم اللوزتان إلى 2 أو 3 أو 4 مع عدوى حادة. □ With damage to cranial nerve XII, the tongue deviates toward the paralyzed side. مع تلف العصب القحفي الثاني عشر، اللسان ينحرف نحو الجانب المشلول. □ A fine tremor of the tongue occurs with hyperthyroidism, a coarse tremor with cerebral palsy and alcoholism. يحدث اهتزاز خفيف في اللسان مع فرط نشاط الغدة الدرقية، رجفة خشنة مع الشلل الدماغي والإفراط في شرب الكحول. □ Diabetic ketoacidosis has an accompanying sweet fruity breath odor; this acetone smell also occurs in children with malnutrition or dehydration. الحمض الكيتوني السكري له رائحة نفس حلوة فاكهية مصاحبة؛ رائحة الأسيتون هذه تحدث أيضا عند الأطفال مع سوء التغذية أو الجفاف. □ Others are an ammonia breath odor with uremia; a musty odor with liver disease; a foul, fetid odor with dental or respiratory infections; and alcohol odor with alcohol ingestion or chemicals. البريورنيا؛ رائحة عفنة مع مرض الكبد؛ رائحة كريهة ومنتفخة مع أسنان أو جهاز تنفسي الالتهابات؛ ورائحة الكحول مع الكحول ingestion or chemicals.



جامعة البيان كلية التمريض المرحلة الثانية

مادة التقييم الصحي والفحص البدني

عملي / مختبر 5



Ear Assessment

تقييم الأذن

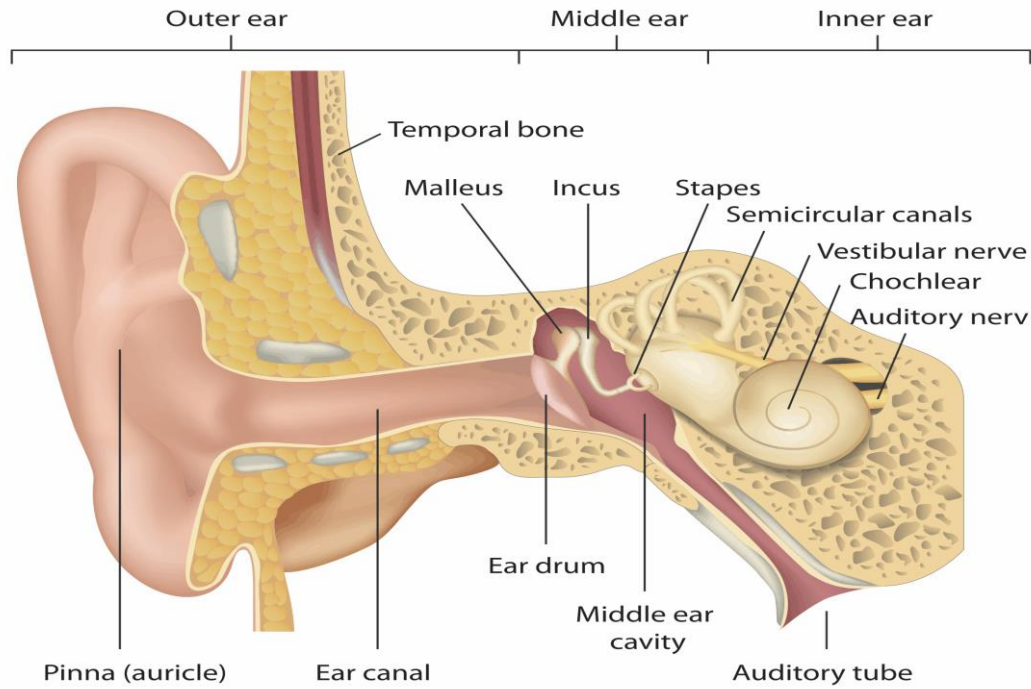
Objectives:

الأهداف:

At the end of this lab, the student will be able to:

في نهاية هذا المختبر، سيكون الطالب قادراً على:

- Demonstrate the ability to safely and accurately complete the ear assessment.
 - Demonstrate the ability to accurately document ear assessment data in an organized manner.
- إظهار القدرة على إكمال تقييم الأذن بأمان ودقة.
إظهار القدرة على توثيق بيانات تقييم الأذن بدقة في طريقة منظمة.



Equipment needed:

المعدات المطلوبة:

- Otoscope with bright light (fresh batteries give off white, not yellow, light)
 - Tuning forks
- منظار أذن مع ضوء ساطع (البطاريات الجديدة تعطي ضوء أبيض وليس أصفر)
شوكات الضبط

Tool: Otoscope



Preparation:

التحضير:

- Position the adult sitting up straight with his or her head at your eye level.
• وضع الشخص البالغ جالساً بشكل مستقيم بحيث يكون رأسه على مستوى عينيك.
- If ear canal is obstructed with cerumen (شمع الاذن) the preferred method for cleaning is by softening cerumen with warmed solution of mineral oil.
• إذا كان قناة الاذن مسدودة بالشمع، فإن الطريقة المفضلة لـ التنظيف يكون بتليين الشمع باستخدام محلول دافئ من زيت معدني.
- Irrigate the canal with warm water.
• قم بشطف القناة بالماء الدافئ.
- Do not irrigate if the history or the examination suggests perforation or infection.
• لا تروي المياه إذا كان التاريخ المرضي أو الفحص يشير إلى وجود ثقب أو عدوى.

SUBJECTIVE DATA:

البيانات الشخصية:

1. Earaches
1. آلام الاذن
2. Infections
2. العدوى
3. Discharge
3. إفراز
4. Hearing loss
4. فقدان السمع
5. Environmental noise
5. الضوضاء البيئية
6. Tinnitus
6. طنين الاذن
7. Vertigo
7. الدوخة
8. Patient-centered care (hearing last checked, method of cleaning ears)
8. الرعاية المركزة على المريض (آخر مرة تم فيها فحص السمع، طريقة تنظيف الاذن)

OBJECTIVE DATA:

البيانات الموضوعية:

Procedure: Inspect and Palpate the External Ear

الإجراء: فحص ولمس الاذن الخارجية

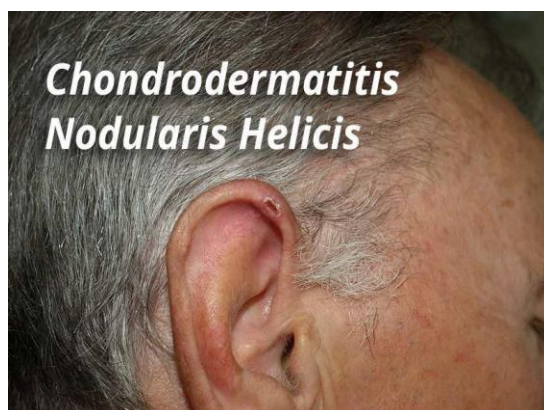
Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Size and Shape الحجم والشكل □ The ears are of equal size bilaterally with no swelling or thickening. الأذنان متساويتان في الحجم من الجانبين مع لا يوجد تورم أو سماكة.	□ Microtia—Ears smaller than 4 cm vertically. صغر الأذن — الأذن أصغر من 4 سم عمودياً. □ Macrotia—Ears larger than 10 cm. اعتلال كبير الأذن — الأذن أكبر من 10 سم. □ Edema. وتضخم.
Skin Condition حالة البشرة □ The skin is intact, with no lumps or lesions. الجلد سليم، بدون أي كتل أو آفات. □ Darwin's tubercle, a small painless nodule at the helix, is sometimes present. This is a congenital variation and is not significant. ورم داروين، عقدة صغيرة غير مؤلمة في الحلزون، يكون أحياناً موجوداً. هذا هو تفاوت خلقي وليس ذو أهمية.	□ Reddened, excessively warm skin indicates inflammation. جلد محمر وساخن جداً يشير إلى الالتهاب. □ Crusts and scaling occur with otitis externa and with eczema, contact dermatitis, and seborrhea. تحدث القشور والتقشر مع التهاب الأذن الخارجي ومع الأكزيما، اتصال التهاب الجلد، والذهن الجلدي. □ Enlarged tender lymph nodes in the region indicate inflammation of the pinna or mastoid process. تضخم الغدد اللمفاوية المؤلم في تشير المنطقة إلى الالتهاب في الصيوان أو العملية الزلاقية. □ Tophi, sebaceous crust, chondrodermatitis, keloid, carcinoma التوفي، القشور الدهنية، التهاب الغضروف الجلدي، الجذرة، السرطان

Darwin's Ear Points

Tenderness □ The pinna and tragus should feel firm, and movement should produce no pain. يجب أن يكون الصيوان واللحاء صلبين، و يجب ألا يسبب الحركة أي ألم □ Palpating the mastoid process should be painless. يجب فحص القناتي اللحمي باللمس برفق.	□ Pain with movement occurs with otitis externa and furuncle. يحدث ألم مع الحركة مع التهاب الأذن الخارجية ودمامل. □ Pain at the mastoid process may indicate mastoiditis or lymphadenitis of the posterior auricular node. قد يكون هناك ألم عند القناتي الخشائي يشير إلى التهاب الخشاء أو التهاب العقد اللمفاوية في العقدة الالتهابية الخلفية.
External Auditory Meatus □ There should be no swelling, redness, or discharge. لا يجب أن يكون هناك تورم أو احمرار أو إفراز.	□ A sticky yellow discharge accompanies otitis externa, or it may indicate otitis media if the drum has ruptured. يصحبها إفراز أصفر لزج التهاب الأذن الخارجية، أو قد يشير إلى التهاب الأذن media إذا كان الطبل قد تمزق.
□ Some cerumen is usually present. عادة ما يكون هناك بعض شمع الأذن. □ The color varies from gray-yellow to light brown and black, and the texture varies from moist and waxy to dry and desiccated. يتنوع اللون من الرمادي المصفر إلى القاتح بني وأسود، والملمس يختلف بين رطب وشمعي إلى جاف وجاف.	□ Impacted cerumen is a common cause of conductive hearing loss. الشمعة المتأثرة بالضغط هي سبب شائع لفقدان السمع التوصيلي.



Crusts and scaling
القشور والتقشير



ندبة كلويد



keloid

The Otoscopic Examination

الفحص بالotoscope

- Choose the largest speculum that fits comfortably. Tilt the person's head slightly away from you toward the opposite shoulder.
اختر أكبر منظار يناسبك بشكل مريح. ارفع رأس الشخص بعيداً قليلاً نحو الكتف المعاكس.
- This method brings the obliquely sloping eardrum into better view.
تجلب هذه الطريقة الانحدار المائل طيلة الأذن إلى رؤية أفضل.
- Pull the pinna up and back on an adult or older child; this helps straighten the S-shape of the canal.
ارفع الصيوان لأعلى وللخلف على البالغة أو الطفل الأكبر؛ هذا يساعد على تقويم ال-S-شكل القناة.
- (Pull the pinna down on an infant or child younger than 3 years of age.)
(اسحب الصيوان للأسفل لدى الرضيع أو الطفل أصغر من 3 سنوات.)
- Hold the otoscope upside down along your fingers and have the dorsum (back) of your hand along the person's cheek, braced to steady the otoscope.
امسك منظار الأذن مقلوباً على طول الأصابع ويمتلك ظهر يديك على وجنة الشخص؛ استعد تثبيت منظار الأذن.



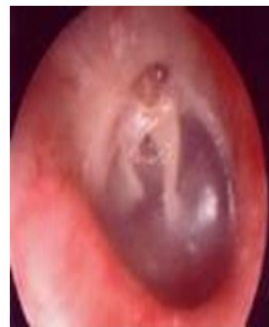
External Canal

القناة الخارجية

- Note any redness and swelling, lesions, foreign bodies, or discharge.
لاحظ أي احمرار وتورم، وافات، أجسام غريبة، أو إفرازات.
- If any discharge is present, note the color and odor. (Also clean any discharge off the speculum before examining the other ear to avoid contamination with possibly infectious material.)
إذا كان هناك أي إفراز، لاحظ لونه ورائحته. (نظف أي إفراز أيضاً المنظار قبل فحص الآخر الأذن لتجنب التلوث المحتمل بالمادة المعدية.)
- For a person with a hearing aid, note any irritation on the canal wall from poorly fitting ear molds.
بالنسبة للشخص الذي يستخدم جهاز السمع، لاحظ أي تهيج في جدار القناة بسبب سوء تركيب قوالب الأذن.

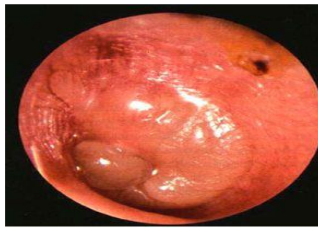
- Redness and swelling occur with Otitis externa; the canal may be completely closed with swelling.
يحدث الاحمرار والتورم مع التهاب الأذن الخارجي؛ قد يكون القناة كاملة مغلقة مع تورم.
- Purulent otorrhea suggests otitis externa or otitis media if the drum has ruptured.
الإفرازات الصديدية من الأذن توحى بالتهاب الأذن الخارجية أو التهاب الأذن الوسطى إذا تمزقت طبلة الأذن.
- Frank blood or clear watery drainage (cerebrospinal fluid leak) after trauma suggests basal skull fracture and warrants immediate referral.
دم صريح أو إفراز مائي صاف (تسرب السائل الدماغي النخاعي) بعد الإصابة يشير إلى كسر قاعدة الجمجمة و warrants immediate referral.
- Cerebrospinal fluid feels oily and tests positive for glucose.
سوائل الدماغ والحبل الشوكي تكون دهنية ويتم اختبارها إيجابياً للجلوكوز.
- Foreign body, exostosis, polyp, furuncle
جسم غريب، نتوء عظمي، زائدة لحمية، فم

Normal Ear Canal and Eardrum

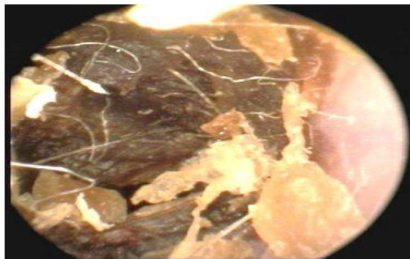


Abnormalities in the Ear Canal

Acute Otitis Media



Otitis Externa



Excessive Cerumen



Exostosis (pre-surgery) blocking ear canal.

Ear canal skin reflected to reveal bony growth.

Tympanic membrane (ear drum) exposed following exostosis removal and skin flaps replaced.

Furunculosis

A **boil (furuncle)** is an infection of a hair follicle]

A **carbuncle** occurs when a group of hair follicles next to each other become infected



Tympanic Membrane غشاء طبلي - Color and Characteristics. The normal eardrum is shiny and translucent, with a pearl-gray color. اللون والخصائص. الطبلة الطبيعية هي طبلة الأذن لامعة وشفافة، مع لون رمادي لؤلؤ. - The cone-shaped light reflex is prominent in the anterior inferior quadrant (at the 5-o'clock position in the right drum and the 7-o'clock position in the left drum). الانعكاس الضوئي على شكل مخروط هو بارز في الجزء الأمامي السفلي الكوارت (في موضع الساعة 5 في الطبلة اليمنى والساعة 7 في الطبلة اليسرى). - This is the reflection of the otoscope light. هذا هو انعكاس ضوء منظار الأذن. - Sections of the malleus are visible through the translucent drum—the umbo, manubrium, and short process. أجزاء من المطرقة تكون مرئية من خلال الطبلة الشفافة—العقدة، اليد العليا، والنتوء القصير. (Infrequently the incus behind the drum shows as a whitish haze in the upper posterior area.) (نادراً ما يحدث في السندان خلف الطبلة يظهر كضبابية بيضاء في الجزء العلوي المنطقتة الخلفية.) - At the periphery the annulus looks whiter and denser. على الأطراف، يبدو الحلق أكثر بيضاء وكثيف.	- Yellow-amber color of the drum occurs with serous otitis media. يحدث اللون الأصفر الكهرماني للطبلة مع التهاب الأذن الوسطى الصديدي. - Red color occurs with acute otitis media. اللون الأحمر يظهر مع التهاب الأذن الحاد. - Absent or distorted landmarks. وسائط المعالم غائبة أو مشوهة. - Air/fluid level or air bubbles behind the drum indicate serous otitis media. مستوى الهواء/السوائل أو فقاعات الهواء خلف طبلة الأذن تشير إلى التهاب الأذن الوسطى المصللي.
Position: الوظيفة: The eardrum is flat and slightly pulled in at the center. طبلة الأذن مسطحة ومشدودة قليلاً في المنتصف.	- Retracted drum due to vacuum in middle ear. الطبلة انشدت للخلف بسبب الفراغ الأذن الوسطى. - Bulging drum from otitis media. طبلة متورمة بسبب التهاب الأذن الوسطى.
Integrity of Membrane: سلامة الغشاء: - The normal tympanic membrane is intact. غشاء الطبلة الطبيعي سليم. - Some adults may show scarring or a dense white patch on the drum as a sequela of repeated ear infections. بعض البالغين قد يظهر لديهم ندوب أو كثافة بيضاء على الطبلة كنتيجة لالتهابات المتكررة في الأذن.	- Perforation shows as a dark oval area or as a larger opening on the drum. يظهر الثقب كم منطقة داكنة بيضاوية أو كم فتحة أكبر على الطبلة. - Vesicles on drum. الحويصلات على الطبلة.

Normal Eardrum

Right Eardrum



Left Eardrum



Dr K.K. (Karade)

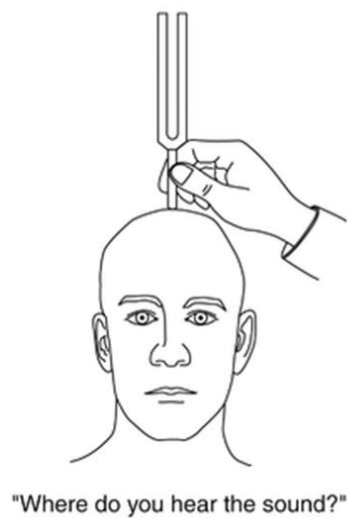
Procedure: Test Hearing Acuity

الإجراء: اختبار قدرة السمع

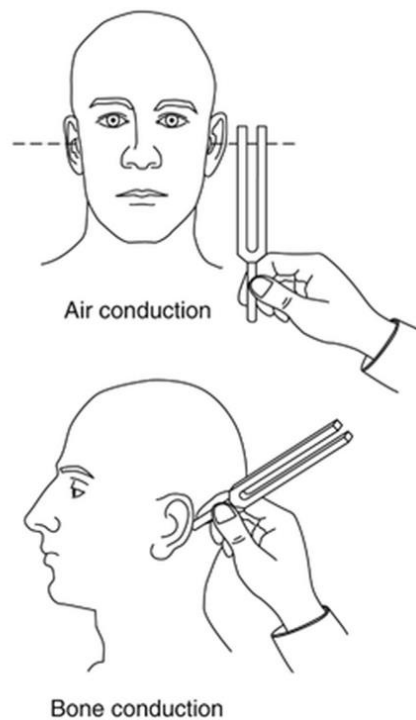
Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Whispered Voice Test اختبار الصوت الهمسني	
- Stand behind the person at arm's length (2 feet). قف خلف الشخص على مسافة طول الذراع (حوالي 2 قدم). - Test one ear at a time while masking hearing in the other ear by placing one finger on the tragus and pushing it in and out of the auditory meatus. اختبر أذن واحدة في كل مرة أثناء حجب السمع في الأذن الأخرى بالاذن الأخرى بوضع إصبع واحد على الترابض و دفعه داخل وخارج المشارة السمعية. - Exhale fully and whisper slowly a set of 3 random numbers and letters such as "5, B, 6." أففر بالكامل وامسح ببطء مجموعة من 3 أشياء عشوائية الأرقام والحروف مثل "5، B، 6." - Normally the person repeats each number/letter correctly after you say it. عادة الشخص يكرر كل رقم/حرف بشكل صحيح بعد أن تقول. - If the response is not correct, repeat the whispered test using a different combination of 3 numbers and letters. إذا لم يكن الرد صحيحاً كرر اختبار الهمس باستخدام مجموعة مختلفة من 3 أرقام وحروف. - A passing score is correctly repeating at least 3 out of a possible 6 numbers/ letters النجاح هو تكرار ما لا يقل عن 3 من 6 أرقام/حروف ممكنة. - Assess the other ear using another set of whispered items, "4, K, 2." قم بتقييم الأذن الأخرى باستخدام مجموعة أخرى من الهمسات المحتملة، "4، K، 2."	- The person is unable to hear whispered items. الشخص غير قادر على السمع الأشياء الهمسنية. - A whisper is a high-frequency sound and is used to detect high-tone loss. الهمسة هي عالية تردد الصوت و هو يستخدم لكشف النبرة العالية خسارة.
Tuning Fork Tests اختبارات شوكة الرنين	
- Tuning fork tests measure hearing by air conduction (AC) or bone conduction (BC), in which the sound vibrates through the cranial bones to the inner ear. اختبارات شوكة الرنين تقيس السمع عن طريق النقل الجوي (AC) أو التوصيل العظمي (BC)، حيث الصوت (AC) يهتز عبر عظام الجمجمة إلى الأذن الداخلية. - The AC route through the ear canal and middle ear is usually more sensitive. مسار التيار المتردد عبر قناة الأذن والأذن الوسطى هو عادة أكثر حساسية. - Traditionally these tests were taught تقليدياً كانت هذه الاختبارات تدريس. Weber tuning fork test results: vibration heard equally in both ears. نتائج اختبار شوكة ويبر: الاهتزاز مسموع بالتساوي في كلا الأذنين. Rinne tuning fork test results: AC > BC (AC is twice as long BC) نتائج اختبار شوكة رينيه: AC > BC (AC ضعف BC) - Close to 40% of normal hearing people lateralize the Weber test. Thus these tests should not be used for general screening. قريباً 40٪ من الأشخاص ذوي السمع الطبيعي من تحديد الجهة اختبار ويبر. لذا لا ينبغي استخدام هذه الاختبارات ل فحص العام.	- With documented hearing loss, these tests may help distinguish conductive loss from sensori-neural loss. مع وجود تسجيلات سمعية قد تساعد هذه الاختبارات في حالة الخسارة تمييز الموصل فقدان السمع العصبي الحسي خسارة. - But they cannot screen a conductive loss from a mixed conductive/sensori-neural loss. لكنهم لا يستطيعون فحص فقدان التوصيل من مختلط توصيل/حسي فقدان عصبي.

Performing the whisper test.

WEBER TEST

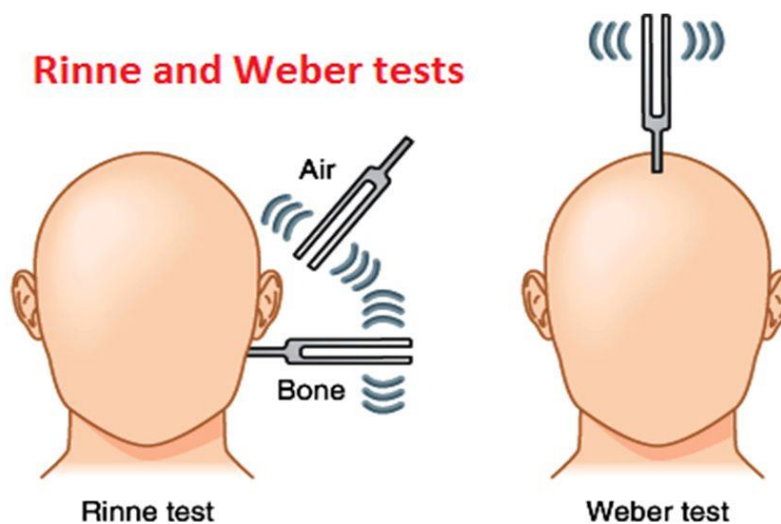


RINNE TEST



TEST RESULTS

Rinne and Weber tests



Hearing loss	Rinne test (Conduction)	Weber test (Localization)
None	Air > bone	Midline
Sensorineural	Air > bone	Normal ear
Conductive	Bone > air	Affected ear

جامعة البيان كلية التمريض المرحلة الثانية

مادة التقييم الصحي والفحص البدني

عملي / مختبر 6



Eye Assessment & Examination
تقييم العين

Eye Assessment

تقييم العين

Objectives:

الأهداف:

At the end of this lab, the student will be able to:

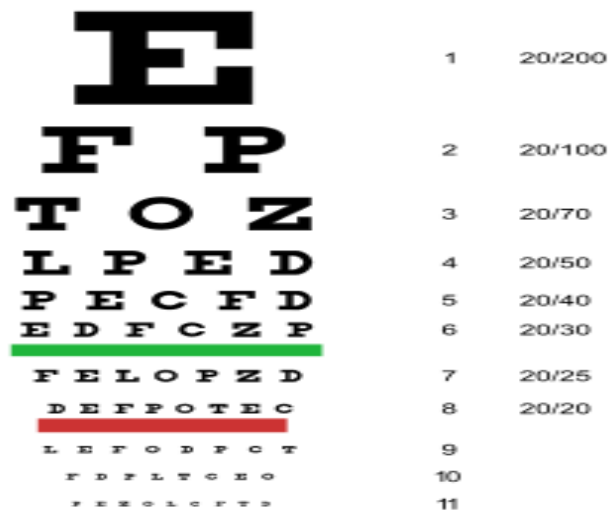
في نهاية هذا المختبر، سيكون الطالب قادراً على:

- Demonstrate the ability to safely and accurately complete a comprehensive examination of eye
إظهار القدرة على إكمال مهمة شاملة بأمان ودقة
فحص العين
- Demonstrate the ability to accurately document eye assessment data in an organized manner.
إظهار القدرة على توثيق بيانات تقييم العين بدقة في
بطريقة منظمة.

Equipment needed:

المعدات المطلوبة:

- Snellen eye chart
مخطط سنيل للعين
- Handheld visual screener / near vision card
فاحص بصري محمول / بطاقة النظر القريب
- Opaque card or occlude
بطاقة غير شفافة أو تغطية
- Penlight
مصباح يدوي صغير
- Ophthalmoscope
منظار العين
- Ruler
مسطرة



Snellen eye chart
مخطط سنيل للعين



Ophthalmoscope
منظار العين

Preparation:
التحضير:

- Position the client in sitting up position / head at your eye level
• وضع العميل في وضع الجلوس / واجه رأسه بمستوى عينيك
- Well lighted room, & could be darkened for ophthalmoscopic examination
• غرفة مضاءة جيدا،

SUBJECTIVE DATA:

البيانات الشخصية:

1. Vision difficulty (decreased acuity, blurring, blind spots) تشوش النظر (انخفاض الحدة، تشوش النظر، بقع عمياء)
2. Pain
3. **Strabismus** (الحول)، **diplopia** (ازدواج البصر)
3. الحول (Strabismus)، ازدواج البصر (diplopia)
4. Redness, swelling
5. Watery, discharge
6. Past history of ocular problems
7. **Glaucoma** (الزرق) - الماء الأزرق أو الماء الأسود
7. الزرق - الماء الأزرق أو الماء الأسود
8. Use of glasses or contact lenses
9. Patient-centered care (vision last tested, method of care for contacts or glasses, efforts to protect eyes)
9. الرعاية المركزة على المريض (آخر مرة تم اختبار الرؤية، طريقة الرعاية للعدسات اللاصقة أو النظارات، جهود لحماية العين)

OBJECTIVE DATA:

البيانات الموضوعية:

Procedure: Test Central Visual Acuity
الإجراء: اختبار حدة البصر المركزي

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Snellen Eye Chart مخطط سنيل للعين	
- Position the person on a mark exactly 20 feet from the chart. Leave glasses or contact lenses in place. Shield one eye at a time during the test. - Ask the person to read through the chart to the smallest line of letters possible.	Hesitancy, squinting, leaning forward, misreading letters.
- Record the result using the numeric fraction at the end of the last successful line read. - Indicate whether any letters were missed and whether corrective lenses were worn (e.g., "Right eye 20/30—1, with glasses").	
Normal visual acuity is 20/20. The top number (numerator) indicates the distance the person is standing from the chart; the denominator gives the distance at which a normal eye can read a particular line.	- The larger the denominator, the poorer the vision. If vision is poorer than 20/30, refer to an eye specialist. - Impaired vision occurs with refractive error, opacity in the media (cornea, lens, vitreous), or disorder in the retina or optic pathway.
Near Vision / Cover card test الرؤية القريبة / اختبار بطاقة التغطية	
- For people older than 40 years of age or for those who report increasing difficulty reading, test near vision using a handheld vision screener with various sizes of print (e.g., a Jaeger card). - Hold the card in good light about 35 cm (14 inches) from the eye.	Impaired near vision, Presbyopia (قصر البصر). Decrease in power of accommodation with aging, is suggested when the person moves the card farther away. Myopia, Impaired far vision (قصر النظر، بعد النظر، ضعف الرؤية البعيدة).

2 - Test each eye separately with glasses on. - A normal result is "14/14" in each eye read without hesitancy and without moving the card closer or farther away.	المرحلة تقديم الصحة / المختبر
---	--

Test Visual Fields:

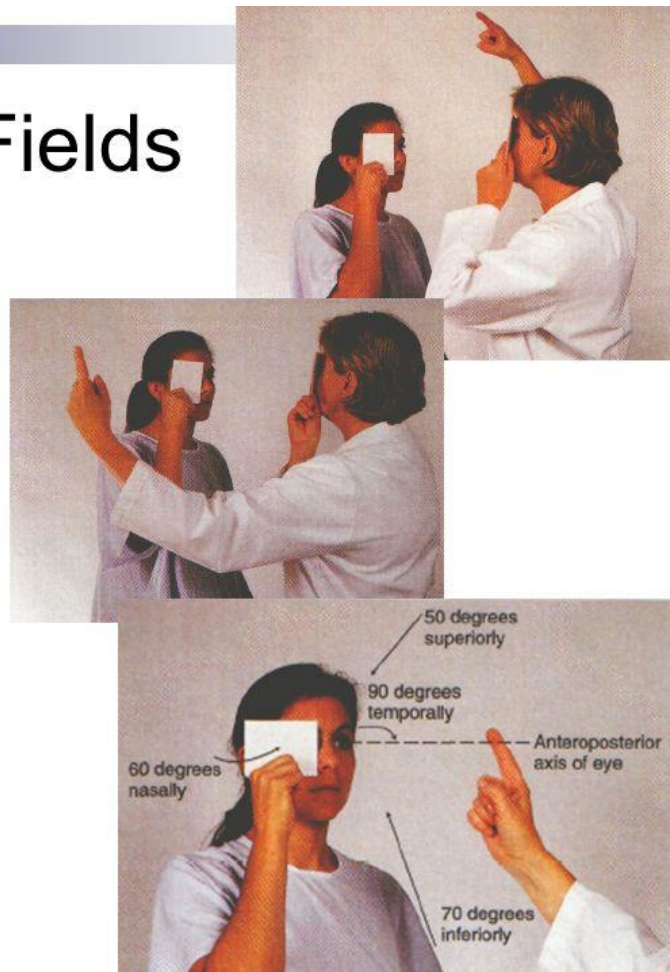
اختبار المجالات البصرية:

Confrontation Test	
- Position yourself at eye level with the patient and about 2 feet away. - Direct him or her to cover one eye with an opaque card and look straight at you with the other eye. - Hold your finger as a target midline between you and the other person and slowly advance it in from the periphery in several directions (upward, downward, temporally, nasally).	
Ask the person to say "now" as the wiggling fingertip is first seen; this should be just as you also see it.	- If the person is unable to see as you do, the test suggests peripheral field loss. - Refer to an eye specialist for more precise testing.

Testing Visual Fields

■ Confrontation test

- Measures peripheral vision compared to examiner (assuming examiner's vision is normal)
- Both examiner and pt cover one eye with a card, stand about 2 feet away, and maintain eye contact
- Advance finger, starting from periphery, and ask patient to say "now" when the finger is first visible
- Inability to see when the examiner sees suggests peripheral field loss



Inspect Extraocular Muscle Function

فحص وظيفة عضلات العين الخارجية

Diagnostic Positions Test اختبار المواقف التشخيصية	
- Leading the eyes through the 6 cardinal positions of gaze elicits any muscle weakness during movement. قيادة العينين عبر الستة الأساسية توجهات النظر تستثير أي عضلة الضعف أثناء الحركة. - Ask the person to hold the head steady and follow the movement of your finger, only with the eyes. اطلب من الشخص أن يثبت رأسه اتبع حركة إصبعك فقط بالعينين. - Hold your finger back about 12 inches so the person can focus on it comfortably; move it to each of the 6 positions, hold it momentarily, then move it back to center. امسك إصبعك للخلف حوالي 12 بوصة بحيث يمكن للشخص التركيز عليه بشكل مريح؛ حركه إلى كل من المواقف الستة، واقبضه لحظة، ثم أعده إلى الوسط. - Progress clockwise تقدم باتجاه عقارب الساعة - A normal response is parallel tracking of the object with both eyes. رد الفعل الطبيعي هو التتبع الموازي لشيء - له كلتا العينين.	- Eye movement is not parallel. حركة العين ليست متوازية. - Failure to follow in a certain direction indicates weakness of an Extraocular muscle (EOM) or dysfunction of the cranial nerve that innervates it. الفشل في اتباع اتجاه معين يشير إلى ضعف في عضلة خارج المقلة (EOM) أو خلل في العصب القحفي الذي يغصبه.
	
- In addition to parallel movement, note any nystagmus, a fine oscillating movement best seen around the iris. بالإضافة إلى الحركة المتوازية، لاحظ أي نystagmus، حركة اهتزازية دقيقة يرى بشكل أفضل حول القرنية. - Mild nystagmus at extreme lateral gaze is normal; nystagmus at any other position is not. رأية خفيفة عند النظر الجانبي الأقصى هي طبيعية؛ التحرك اللاإرادي للعين في أي وضعية أخرى يكون غير طبيعي. - Finally note that the upper eyelid continues to overlap the superior part of the iris, even during downward movement. وأخيرا لاحظ أن الجفن العلوي يستمر لتداخل مع الجزء العلوي من القرنية، حتى أثناء الحركة نحو الأسفل.	- Nystagmus occurs with disease of the semicircular canals in the ears, a paretic eye muscle, multiple sclerosis, or brain lesion. النystagmus تحدث مع مرض القنوات الدائرية في الأذنين، متضعف عضلة العين، التصلب المتعدد، أو الدماغ أفة. - A white rim of sclera between the lid and the iris, referred to as "lid lag," occurs with hyperthyroidism. حلقة بيضاء من الصلبة بين الجفن وقرنية التي يشار إليها باسم "تأخر الجفن"، تحدث مع فرط نشاط الغدة الدرقية.

Inspect External Ocular Structures

فحص الهياكل الخارجية للعين

General عام	
Note the person's ability to move around the room with vision functioning well enough to avoid obstacles and respond to your directions. لاحظ قدرة الشخص على التحرك حول غرفة تعمل فيها الرؤية بشكل جيد بما فيه الكفاية لتجنب العقبات والرد على ما لديك.	Groping with hands. التلمس باليدين.
The facial expression is relaxed with adequate vision. التعبير على الوجه مسترخي مع رؤية كافية.	Squinting or craning forward. التحديق أو الانحناء للأمام.
Eyebrows الحواجب	
Normally the eyebrows are present bilaterally, move symmetrically as the facial expression changes, and have no scaling or lesions. عادة الحواجب موجودة ثنائياً، تحرك بشكل متماثل كما في الوجه تغييرات في التعبير، ولا توجد أي عملية تكبير أو آفات.	- Unequal or absent movement with nerve damage. حركة غير متساوية أو غائبة مع العصب ضرر. - Scaling with seborrhea. التقشير مع دهن فروة الرأس.

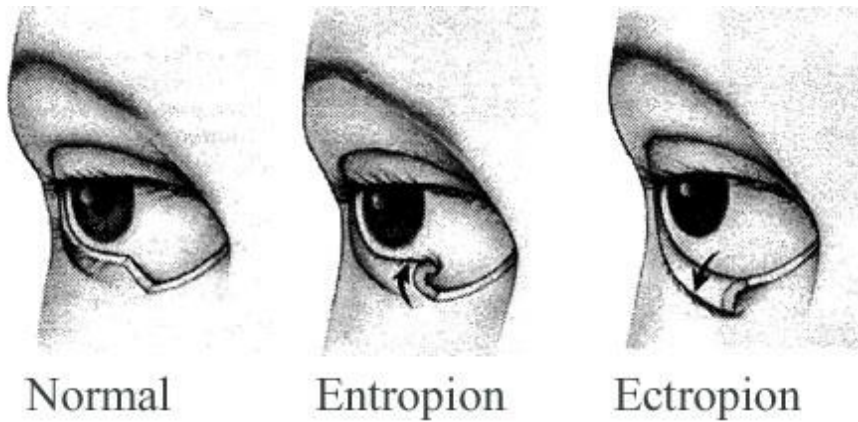
Eyelids and Lashes الجفون والأشواط	
The upper lids normally overlap the superior part of the iris and approximate completely when closed.	Lid lag occurs with hyperthyroidism.
The skin is intact without redness, swelling, discharge, or lesions.	Incomplete closure creates risk for corneal damage
The palpebral fissures are horizontal in non-Asians, whereas palpebral fissures of Asians normally have an upward slant.	Ptosis—drooping of upper lid as with myasthenia gravis.
The eyelashes are evenly distributed along the lid margins and curve outward.	Periorbital edema, lesions.
	Ectropion and entropion
Eyeballs العيون	
The eyeballs are aligned normally with no protrusion or sunken appearance.	Exophthalmos—protruding eyes
Blacks may normally have a slight protrusion of the eyeball beyond the supraorbital ridge.	Enophthalmos—sunken eyes.
Conjunctiva and Sclera المتلحمة والصلبة	
Ask the person to look up. Using your thumbs, slide the lower lids down along the bony orbital rim.	General reddening
Take care not to push against the eyeball.	
Inspect the exposed area.	
The eyeball looks moist and glossy.	
Numerous small blood vessels normally show through the transparent conjunctiva.	Cyanosis of the lower lids.
Otherwise the conjunctivae are clear and show the normal color of the structure below—pink over the lower lids and white over the sclera.	Pallor near the outer canthus of the lower lid may indicate anemia (the inner canthus normally contains less pigment).
Note any color change, swelling, or lesions.	
The sclera is china white, although occasionally it is gray-blue or “muddy” color in Blacks. Dark-skinned people may have small brown macules (like freckles) on the sclera; do not confuse these with foreign bodies or petechiae.	Scleral icterus is a yellowing of the sclera extending up to the cornea, indicating jaundice.
Blacks may have yellowish fatty deposits beneath the lids away from the cornea.	Tenderness, foreign body, discharge, or lesions.
Do not confuse these yellow spots with the overall scleral yellowing that accompanies jaundice.	



pallor
شحوب



BEFORE AND AFTER IMAGE WHEN TREATED WITH PTOSIS SURGERY



Exophthalmos **Enophthalmos**



Inspect Anterior Eyeball Structures
تفقد هياكل مقدمة كرة العين

Cornea and Lens القرنية والعدسة	
- Shine a light from the side across the cornea and check for smoothness and clarity. سلط ضوءاً من الجانب عبر القرنية وتحقق من السلاسة والوضوح. - There should be no opacities (cloudiness) in the cornea, the anterior chamber, or in the lens behind the pupil. لا يجب أن يكون هناك أي عتبات (غيوم) في القرنية، الغرفة الأمامية، أو في العدسة خلف البؤبؤ. - Do not confuse arcus senilis with an opacity. This is a normal finding in aging people. لا تخلط بين القوس العيني المسن وعتامة. هذا أمر طبيعي مع التقدم في العمر.	A corneal abrasion causes irregular ridges in reflected light, usually visible only with fluorescein stain. خدش القرنية بسبب عدم انتظام النتوءات في الضوء المنعكس، غالباً ما تكون مرئية فقط باستخدام صبغة الفلورسين.
Iris and Pupils قزحية و حدقة العين	
- The iris normally has a round, regular shape and an even coloration. القزحية عادة ما تكون لها شكل دائري ومنظم ولون متساوي. - Normally the pupils appear round, regular, and of equal size. عادة تظهر الحدقات مستديرة ومنظمة، وبقياس الحجم. - In adults resting size is from 3 to 5 mm. في البالغين، يكون الحجم عند الراحة من 3 إلى 5 ملم. - A small number of people (5%) have pupils of two different sizes, a condition called anisocoria. عدد قليل من الناس (5%) لديهم بؤبؤ بحجمين مختلفين، وهو حالة تسمى anisocoria.	- Irregular shape. شكل غير منتظم. - Pupils with unequal size occur with a central nervous system injury. يحدث تفاوت في حجم الحدقتين مع إصابة الجهاز العصبي المركزي.
- To test the pupillary light reflex, darken the room and ask the person to gaze into the distance. (This dilates the pupils.) اختبار انعكاس حدقة العين للضوء، قم بتعتيم الغرفة واطلب من الشخص أن ينظر إلى البعد. (هذا يوسع البؤبؤ.) - Advance a light in from the side,* and note the response. Normally you will see (1) constriction of the pupil on the same side (a direct light reflex), and (2) simultaneous constriction of the other pupil (a consensual light reflex). قدم ضوءاً من الجانب،* ولاحظ الرد. عادة ستري (1) انقباض البؤبؤ في نفس الجانب (الانعكاس الضوئي المباشر)، و(2) انقباض حدقة العين الأخرى (انعكاس الضوء المتوافق).	- Dilated pupils. حدقات متوسعة. - Dilated and fixed pupils. حدقات متوسعة وثابتة. - Constricted pupils. حدقة متضيق. - Unequal or no response to light استجابة غير متساوية أو عدم وجود استجابة للضوء
Always advance the light in from the side to test the light reflex. دائماً حرك الضوء من الجانب نحو الأمام. - If you advance from the front, the pupils will constrict to accommodate for near vision. اختبر انعكاس الضوء. - Thus you do not know what the pure response to the light would have been. إذا تقدمت من الأمام، سيقوم الطلاب بتضييق للتعويض مع الرؤية القريبة. هكذا أنت لا تعرف ما هو الرد النقي إلى الضوء كان سيكون.	
Test for accommodation by asking the person to focus on a distant object. اختبار التكيف عن طريق السؤال شخص يركز على جسم بعيد. - This process dilates the pupils. هذه العملية توسع بؤبؤ العين. - Then have the person shift the gaze to a near object such as your finger held about 7 to 8 cm (3 inches) from the nose. ثم اجعل الشخص يحول نظره إلى شيء قريب شيء مثل أصبعك ممسك على بعد حوالي 7 إلى 8 سم (3 بوصات) من الأنف.	
A normal response includes (1) pupillary constriction and (2) convergence of the axes of the eyes. تشمل الاستجابة الطبيعية (1) انقباض الحدقة وانقباض و(2) تقارب المحاور من العينين.	- Absence of constriction or convergence. غياب الانقباض أو التقارب. - Asymmetric response. استجابة غير متماثلة.
Record the normal response to these maneuvers as PERRLA, or Pupils Equal, Round, React to Light, and Accommodation. سجل الاستجابة الطبيعية لهذه الحركات مثل PERRLA، أو البؤبؤ متساوي، مستدير، يستجيب للضوء، والتكيف.	



Figure III–16 Testing cranial nerve III for accommodation.

From Cranial Nerves 3rd Ed. ©2010

Wilson-Pauwels, Stewart, Akesson, Spacey, PMPH-USA

Ophthalmoscopic examination

فحص الشبكية بالمطاطار

Inspect the Ocular Fundus

افحص قاع العين

- Darken the room to help dilate the pupils.
قم بتعتيم الغرفة للمساعدة في توسيع البؤبؤ.
- Remove eyeglasses from yourself or the other person; they obstruct close movement, and you can compensate for their correction by using the diopter setting.
أزل النظارات عن نفسك أو عن الشخص الآخر؛ فهي تعيق الحركة القريبة، و يمكنك تعويض تصحيحهم باستخدام ضبط الديوبتر.
- Contact lenses can be left in.
يمكن للعدسات اللاصقة أن تبقى.
- Select the large round aperture with the white light of the ophthalmoscope for routine examination.
اختر الفتحة الكبيرة المستديرة ذات الضوء الأبيض في منظار العين للفحص الروتيني.
- If the pupils are small, use the smaller white light.
إذا كانت البؤبؤ صغيرة، استخدم الضوء الأبيض الأصغر.
- Tell the person, "Please keep looking at that light switch [or mark] on the wall across the room, even though my head will get in the way."
قل للشخص: «من فضلك استمر في النظر إلى مفتاح [أو علامة] على الحائط المقابل»
- Staring at a distant fixed object helps dilate the pupils and hold the retinal structures still.
التنظر إلى جسم ثابت بعيد يساعد على توسيع الحدقة وإبقاء هياكل الشبكية ثابتة.
- Match sides with the person: that is, hold the ophthalmoscope in your *right* hand up to your *right* eye to view the person's *right* eye.
وافق الجوانب مع الشخص: أي، امسك منظار العين بيدك اليمنى نحو العين اليمنى لرؤية عين الشخص اليمنى.
- You must do this to avoid bumping noses during the procedure. Place your free hand on the person's shoulder or forehead.
يجب أن تفعل هذا لتجنب اصطدام الأنوف أثناء الإجراء. ضع يدك الحرة على كتف أو جبهة الشخص.
- Systematically inspect the structures in the ocular fundus: (1) optic disc, (2) retinal vessels, (3) general background, and (4) macula.
افحص بشكل منهجي الهياكل في قاع العين: (1) القرص البصري، (2) الأوعية الدموية الشبكية، (3) الخلفية العامة، و (4) البقعة الصفراء.
- (Note that the illustration shows a large area of the fundus.)
ملاحظة أن الرسم يوضح مساحة كبيرة من القاع.
- Your actual view through the ophthalmoscope is much smaller, slightly larger than 1 disc diameter.)
رؤيتك الفعلية من خلال منظار العين أصغر بكثير، أكبر قليلاً من قرص واحد (القطر).



Optic Disc

قرص العصب البصري

□ The most prominent landmark is the optic disc, located on the nasal side of the retina. □ Explore these characteristics:	□
□ Color—Creamy yellow-orange to Pink	□ Pallor. Hyperemia.
□ 2. Shape—Round or oval	□ Irregular.
□ 3. Margins—Distinct, sharply demarcated, although the nasal edge may be slightly fuzzy	□ Blurred margins.
□ 4. Cup-to-disc ratio—Distinctness varies. When visible, cup is a brighter yellow-white than the rest of the disc. Its width is not more than one half of the disc diameter (DD).	□ Cup extending to the disc border

Retinal Vessels

أوعية الشبكية

Follow a paired artery and vein out to the periphery in the four quadrants, noting these points:	□
□ 1. Number—A paired artery and vein pass to each quadrant. Vessels look straighter at the nasal side.	□ Absence of major vessels.
□ 2. Color—Arteries are brighter red than veins. They also have the arterial light reflex, a thin strip of light down the middle.	□
□ 3. A : V ratio—The ratio comparing the artery-to-vein width is 2 : 3 or 4 : 5.	□ Arteries too constricted. □ Veins dilated.
□ 4. Caliber—Arteries and veins show a regular decrease in caliber as they extend to periphery.	□ Focal constriction. □ Neovascularization.
□ 5. Arteriovenous (AV) crossing—An artery and vein may cross paths.	□ Crossings more than 2 DD away from disc. □ Nicking or pinching of underlying vessel.

University of Al Bayan/ College of Nursing 2 nd stage جامعة البصرة / كلية التمريض	Health assessment / Lab 6 تقييم الصحة / المختبر المرحلة
□ This is not significant if within 2 DD of disc and if no sign of interruption in blood flow. هذا ليس مهما إذا كان ضمن 2 DD من القرص وإذا لم يكن هناك أي علامة على انقطاع تدفق الدم. □ There should be no indenting or displacing of vessel. لا يجب أن يكون هناك أي مسافة بادئة أو تحريك الوعاء.	□ Vessel engorged peripheral to crossing. الوعاء ممتلئ بجانب التقاطع.
□ 6. Tortuosity—Mild vessel twisting when present in both eyes is usually congenital and not significant. 6. الالتواء — الالتواء خفيف للأوعية عند وجوده في كلا العينين، يكون عادةً خلقيًا وليس مهمًا.	□ Extreme tortuosity or marked asymmetry in two eyes. التعرج الشديد أو عدم التماثل الملحوظ في عينين.
□ 7. Pulsations—Present in veins near the disc as their drainage meets the intermittent pressure of arterial systole (often hard to see). 7. النبضات — موجودة في الأوردة بالقرب من القرص عندما يلتقي تصريفهم بالمتقطع ضغط الانقباض الشرياني (غالبًا ما يكون صعبًا للظفر).	□ Absent pulsations غياب النبضات

General Background of the Fundus

الخلفية العامة للقاع

□ The color normally varies from light red to dark brown—red, generally corresponding with the person's skin color. There should be no lesions obstructing the retinal structures. اللون عادة يتراوح من الأحمر الفاتح إلى بني غامق—أحمر، يتوافق عموماً مع لون بشرة الشخص. يجب أن لا توجد آفات تعيق الشبكية هيكلية.	□ Abnormal lesions—hemorrhages, exudates, microaneurysms. الآفات غير الطبيعية—النزيف، الإفرازات، تمدد الأوعية الدقيقة.
--	--

Macula

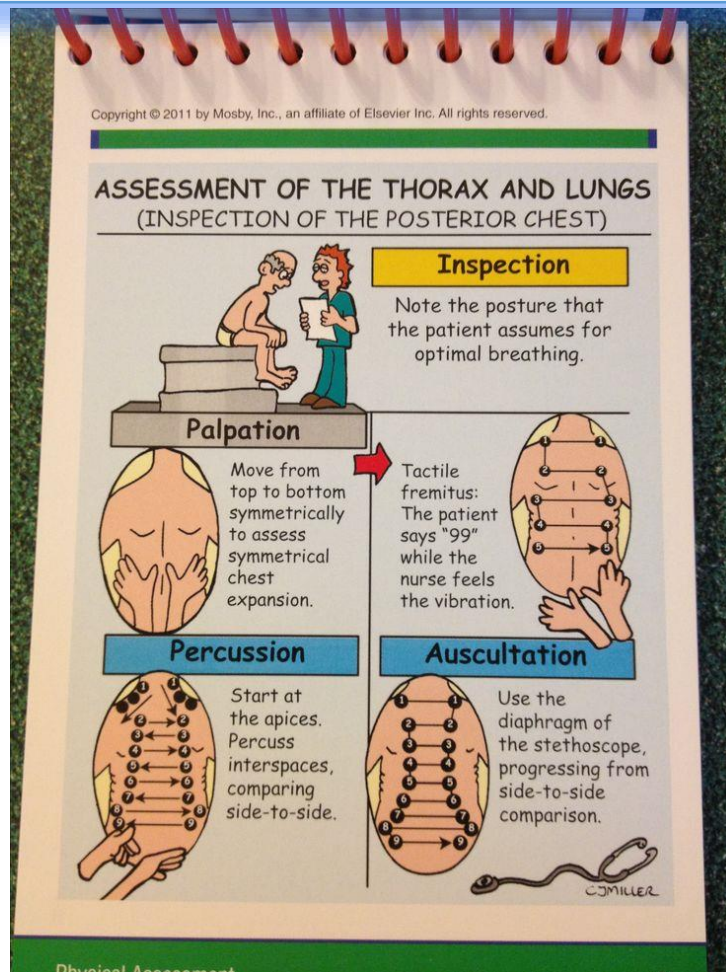
بقعة

□ The macula is 1 DD in size and is located 2 DD temporal to the disc. البقعة الصفراء حجمها 1 DD وتقع على بعد 2 DD زمنيًا من القرص. □ Inspect this area last in the fundus examination. افحص هذه المنطقة في النهاية عند الفحص القاعي للعين. □ A bright light on this area of central vision causes some watering, discomfort, and pupillary constriction. ضوء ساطع في هذه المنطقة من الرؤية المركزية يسبب بعض الدموع والآنز عايج و انقباض البؤبؤ.	□ Clumped pigment occurs with trauma or retinal detachment. يحدث الصباغ المتكثل مع الصدمة أو انفصال الشبكية. □ Hemorrhage or exudate in the macula occurs with macular degeneration. نزيف أو إفراز في البقعة الصفراء يحدث مع التنكس البقعي.
□ Note that the normal color of the area is somewhat darker than the rest of the fundus but even and homogeneous. Clumped pigment may occur with aging. لاحظ أن اللون الطبيعي للمنطقة هو أغمق قليلاً من باقي القاع لكن متساو ومتجانس. متكثل قد يظهر الصباغ مع التقدم في العمر.	□

جامعة البيان كلية التمريض المرحلة الثانية

مادة التقييم الصحي والفحص البدني

عملي / مختبر 7



Thorax and Lungs Assessment

الصدر والرئتان التقييم

Objectives:

الأهداف:

At the end of this lab, the student will be able to:

في نهاية هذا المختبر، سيكون الطالب قادراً على:

- Demonstrate the ability to safely and accurately complete thorax & lung assessment.
إظهار القدرة على إكمال الصدر بأمان ودقة تقييم.
- Demonstrate the ability to accurately document thorax & lung assessment in organized & eligible manner.
إظهار القدرة على توثيق الصدر بدقة منظم.

SUBJECTIVE DATA:

البيانات الشخصية:

1. Cough (duration, productive of sputum)
السعال (المدة، هل يصاحبه بلغم)
2. Shortness of breath (with level of activity)
ضيق في التنفس (مع مستوى النشاط)
3. Chest pain with breathing
ألم في الصدر مع التنفس
4. Past history of respiratory disease (bronchitis, emphysema, asthma, pneumonia, tuberculosis)
تاريخ مرضي سابق لأمراض الجهاز التنفسي (التهاب الشعب الهوائية، انتفاخ الرئة، الربو، الالتهاب الرئوي، السل)
5. Smoking history (age started, number of packs per day, number of years smoked)
تاريخ التدخين (العمر عند البدء، عدد العلب يومياً، عدد سنوات التدخين)
6. Environmental exposure that affects breathing (e.g., occupational hazard, urban environment)
التعرض البيئي الذي يؤثر على التنفس (مثل المخاطر المهنية، الحضرية)
7. Patient-centered care (last TB skin test, chest x-ray image, influenza immunization)
الرعاية المتمركزة حول المريض (آخر اختبار جلدي للسل، صورة أشعة للصدر، تطعيم الإنفلونزا)

OBJECTIVE DATA:

البيانات الموضوعية:

Preparation:

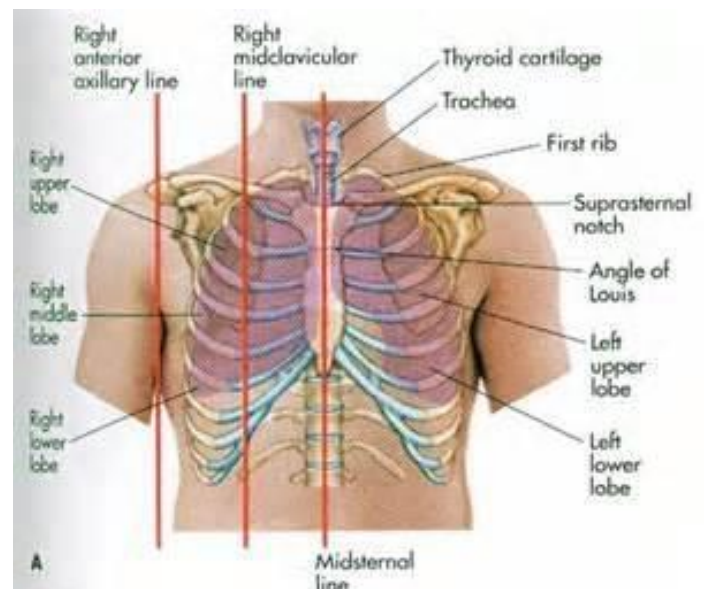
التحضير:

- Ask the person to sit upright and males to disrobe to the waist.
اطلب من الشخص الجلوس بشكل مستقيم ومن الذكور خلع ملابس الجزء العلوي من الجسم.
- Leave the gown on females open at the back.
اتركي القستان للإناث مفتوحاً من الخلف.

Equipment needed:

المعدات المطلوبة:

- Stethoscope
سماعة طبية
- Small ruler marked in centimeters
مسطرة صغيرة محددة بالسنتيمترات
- Marking pen
قلم تمييز
- Alcohol wipe (to clean endpiece)
منديل كحولي (لتنظيف الطرف النهائي)





Procedure: Inspect the Posterior Chest

الإجراء: فحص الجزء الخلفي من الصدر

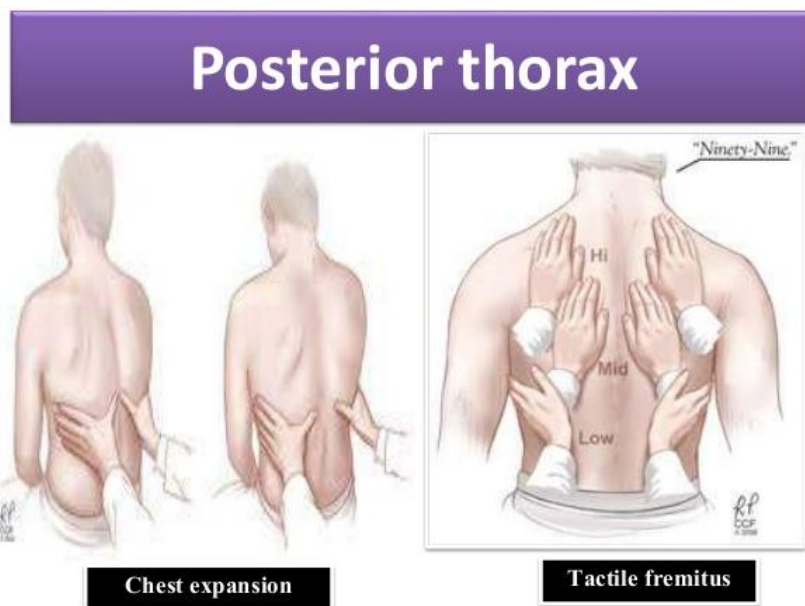
Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Shape and Configuration. الشكل والتكوين.	
- The spinous processes are in a straight line. المسامات الشوكية في خط مستقيم - The thorax is symmetric with downward sloping ribs. الصدر متماثل نحو الأسفل - The scapulae are placed symmetrically. توضع التوابع الكتف بشكل متماثل	When severe, skeletal deformities may limit thoracic cage excursions, including scoliosis (S-shaped curvature) and kyphosis (outward curvature) of the thoracic spine. عندما تكون شديدة، قد تحدث تشوهات هيكلية تقيد حركات القفص الصدري، بما في ذلك انحناء جانبي للعمود الفقري (شكل حرف S) وحناء (الحناء للخارج) في العمود الفقري الصدري
- The anteroposterior (AP) diameter of the chest is less than the transverse diameter. القطر الأمامي الخلفي (AP) لـ الصدر أقل من القطر العرضي - The ratio of AP-to-transverse diameter is 1 : 2 or 0.7/1. نسبة القطر الأمامي الخلفي إلى القطر العرضي هي 1 : 2 أو 0.7/1	Transverse diameter, or “barrel chest,” with ribs horizontal, occurs in chronic emphysema due to hyperinflation of the lungs. القطر العرضي، أو “صدر البرميل”، مع الأضلاع أفقية، يحدث في الحالات المزمنة مع تضخم الرئوي بسبب التضخم الزائد للرئتين
The neck muscles and trapezius muscles are developed normally for age and occupation. عضلات الرقبة وعضلات التراپيزيوس يتم تطويرها بشكل طبيعي حسب العمر و المهنة	Neck muscles are hypertrophied in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) from aiding in forced respirations. عضلات الرقبة متضخمة في الحالات المزمنة مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) من المساعدة في التنفس القسري.
Position موضع	
This includes a relaxed posture with arms comfortably at the sides or hands in the lap. يشمل هذا وضعية مسترخية مع الذراعين بشكل مريح على الجانبين أو اليدين في حضن	With COPD, a tripod position (leaning forward with arms braced against knees, chair, or bed) gives leverage so the rectus abdominis, intercostal, and accessory neck muscles can aid in expiration. مع مرض الانسداد الرئوي المزمن، وضعية الترابيود (الانحناء متقدم للأمام مع تثبيت الذراعين على الركبتين، الكرسي، أو السرير) يعطي قوة دفع لذلك العضلة المستقيمة البطنية، بين الأضلاع، والرقبة المساعدة يمكن للعضلات أن تساعد في الزفير.
Skin Color and Condition لون الجلد وحالته	
- Color should be consistent with person's genetic background, with no cyanosis or pallor. يجب أن يكون اللون متماثلاً مع الشخص الخلفية الجينية، بدون زرقة أو شحوب - Note any lesions. ملاحظة أي آفات.	

Palpate the Posterior Chest

افحص الصدر الخلفي باللمس

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Symmetric Expansion التوسع المتماثل	
- Confirm symmetric chest expansion by placing your warmed hands on the posterolateral chest wall with thumbs at the level of T9 or T10. تأكد توسع الصدر بشكل متماثل عن طريق وضع يديك المدفونتين على الجدار الصدري الخلفي الجانبي مع الإبهامين عند مستوى T9 أو T10. - Slide your hands medially to pinch up a small fold of skin between your thumbs. حرك يديك نحو الداخل لقرص ثنية صغيرة من الجلد بين إبهاميك. - Ask the person to take a deep breath; your thumbs should move apart symmetrically. اطلب من الشخص أن يأخذ نفساً عميقاً؛ أنت يجب أن تتحرك الإبهامان بعيداً عن بعضهما بشكل متماثل. - Note any lag in expansion. لاحظ أي تأخر في التوسع.	- Unequal chest expansion occurs with marked atelectasis or pneumonia, thoracic trauma such as fractured ribs, or pneumothorax. يحدث توسع الصدر بشكل غير متساو مع انخماص رئوي أو التهاب رئوي واضح، صدمة مثل كسور الأضلاع، أو استرواح الصدر. - Pain accompanies deep breathing when the pleurae are inflamed. الألم يصاحب التنفس العميق عندما الغشاء الجنبي ملتهب.
Tactile Fremitus الاهتزاز التلمسي	
- Tactile fremitus: is a palpable vibration. الاهتزاز التلمسي: هو اهتزاز يمكن الشعور به - Use the palmar base (the ball) of the fingers of one hand and touch the person's chest while he or she repeats the words “ninety-nine” or “blue moon.” استخدم قاعدة راحة اليد (الكروية) أصابع يد واحدة ولمس الشخص الصدر بينما هو أو هي يكرر الكلمات “ninety-nine” or “blue moon.” - Start over the lung apices and palpate from one side to another; the vibrations should feel the same in the corresponding area on each side. ابدأ من قمم الرئتين وفحص باللمس من جانب إلى آخر؛ يجب أن تكون الاهتزازات أشعر بنفس الشيء في المنطقة المقابلة على كل جانب.	Decreased fremitus occurs when anything obstructs transmission of vibrations, e.g., obstructed bronchus, pleural effusions or thickening, pneumothorax, emphysema. يحدث انخفاض الاهتزاز إلى ما عداً عندما يحدث أي شيء يعيق انتقال الاهتزازات، على سبيل المثال، انسداد القصبة، أو انصبابات جنيبة أو تضخم، انخماص الرئة، انتفاخ الرئة.

University of Al Bayan/ College of Nursing 2nd stage جامعة البصرة / كلية التمريض	Health assessment / Lab 7 تقييم الصحة / المختبر المرحلة
□ Normally fremitus is most prominent between the scapulae and around the sternum, sites where the major bronchi are closest to the chest wall. Fremitus normally decreases as you progress down because more and more tissue impedes sound transmission. عادة ما يكون الرنين الصدري أكثر وضوحاً بين الكتفين وحول القص، المواقع التي توجد فيها الشعب الهوائية الرئيسية الأقرب لجدار الصدر. الاهتزاز عادة ما ينخفض كلما تقدمت للأسفل لأنه يحيق المزيد والمزيد من الأنسجة انتقال الصوت.	□ Increased fremitus occurs with compression or consolidation of lung tissue, e.g., lobar pneumonia يزداد الرعشة مع ضغط أو تلاحق الرئة نسيج، مثل التهاب الرئة القضي
Chest Wall	
□ Using the fingers, gently palpate the entire chest wall. باستخدام الأصابع، قم بتحسس كل شيء بلطف جدار الصدر □ Note any areas of tenderness, increased skin temperature and moisture, any superficial lumps or masses, and any skin lesions. لاحظ أي مناطق حساسية أو زيادة درجة حرارة ورطوبة الجلد، أي شيء كتل أو كتل سطحية، وأي جلد	□ Crepitus is a coarse, crackling sensation palpable over the skin surface. الفرقة هي إحساس خشين ومتفتت يمكن الشعور به فوق سطح الجلد □ It occurs in subcutaneous emphysema when air escapes from the lung and enters the subcutaneous tissue, as after open thoracic injury or surgery. يحدث في النفاخ تحت الجلد عندما يخرج الهواء من الرئة ويدخل النسيج تحت الجلد، كما بعد الفتح إصابته أو جراحة صدرية.



Tactile Fremitus

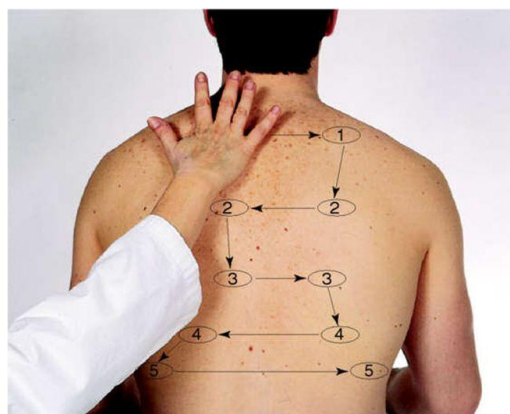
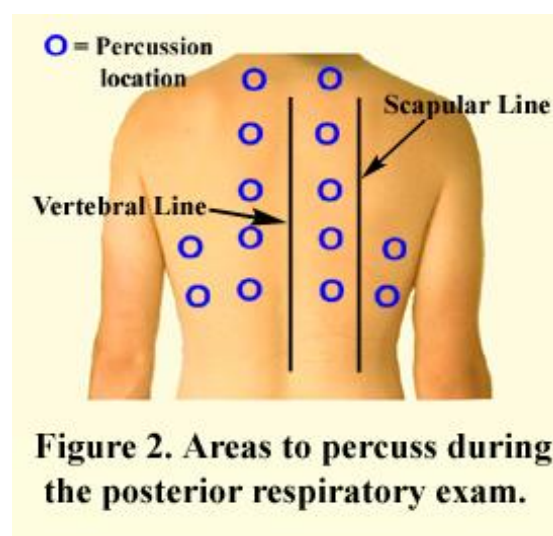
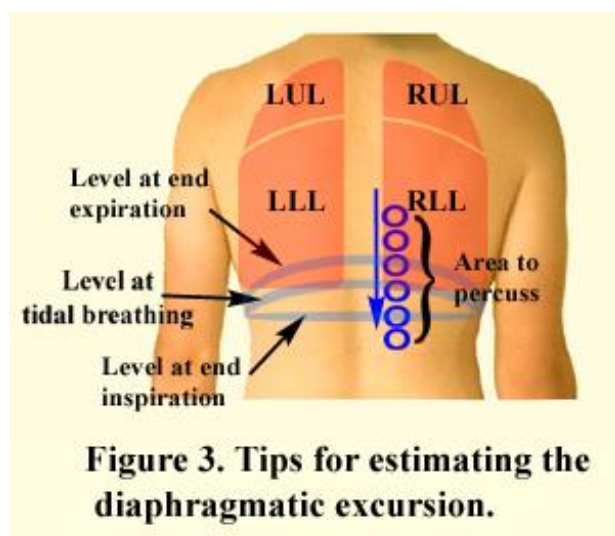


Figure 16-14. p. 462.

Percuss the Posterior Chest

اضغط على الصدر الخلفي

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Lung Fields حقول الرئة	
- Start at the apices and percuss in the interspaces: make a side-to-side comparison all the way down the lung region. ابدأ من القمم واضرب برفق في المسافات البينية: قم بمقارنة جانبية إلى جانبية كل الطريق لأسفل منطقة الرئة. - Percuss at 5-cm intervals. اضرب على فترات قدرها 5 سم. - Avoid the scapulae and ribs. تجنب الكتفين والضلوع. - Resonance predominates in healthy lung tissue in the adult. الرنين يهيمن في الرئة السليمة النسيج في البالغ. - The resonant note may be modified somewhat in athletes with heavily muscular chest walls and in heavily obese adults in whom subcutaneous fat produces scattered dullness. قد يتم تعديل النغمة الرنانة بعض الشيء في الرياضيين الذين لديهم جدار صدري عضلي جدا وفي البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين الدهون تحت الجلدية تنتج ضبابية متفرقة.	Hyperresonance is found when too much air is present, as in emphysema or pneumothorax. يوجد الصدى المفرط عندما يكون هناك الكثير كمية كبيرة من الهواء موجودة، كما في الانفاخ الرئوي أو استرواح الصدر. - A dull note signals abnormal density in the lungs, as with pneumonia, pleural effusion, atelectasis, or tumor. تشير النغمة الباهتة إلى كثافة غير طبيعية في الرئتان، كما هو الحال مع الالتهاب الرئوي، الجنبى انصباب، انخماص، أو ورم.
Diaphragmatic Excursion. تحرك الحجاب الحاجز - Percuss to map out the lower lung border, both in expiration and inspiration. اضرب بخفة لتحديد حد الرئة السفلى، كلا عند الزفير والشهيق. - Measure the difference. قيس الفرق. - This diaphragmatic excursion should be equal bilaterally and measure about 3 to 5 cm in adults, although it may be up to 7 to 8 cm in well-conditioned people. يجب أن تكون حركة الحجاب الحاجز متساوي من الجانبين ويبلغ حوالي 3 إلى 5 سم في البالغين، على الرغم من أنه قد يصل إلى 7 إلى 8 سم في الأشخاص ذوي اللياقة الجيدة.	An abnormally high level of dullness on the chest wall and absence of excursion occur with pleural effusion or atelectasis of the lower lobes. يحدث مع الانصباب الجنبي أو الانخماص الرئوي من الفصوص السفلية.



Auscultate the Posterior Chest

استمع إلى الجزء الخلفي من الصدر

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Breath Sounds أصوات التنفس	
- Instruct the person to breathe through the mouth a little bit deeper than usual. أخبر الشخص أن يتنفس عبر الفم أعماق قليلا من المعتاد. - While standing behind the person, listen to the following lung areas—posterior from the apices at C7 to the bases (around T10) and laterally from the axillae down to the 7th or 8th rib. أثناء الوقوف خلف الشخص، استمع إلى المناطق التالية في الرئتين الخلفيتين من القمم عند C7 وصولاً إلى القواعد (حوالي T10) وجانبياً من الإبطتين نزولاً إلى السابع أو الضلع الثامن. - Use the side-to-side in sequence. استخدم الحركة الجانبية قياساً.	

University of Al Bayan/ College of Nursing 2nd stage المرحلة / تقييم الصحة / المختبر	Health assessment / Lab 7
□ You should expect to hear three types of normal breath sounds: يجب أن تتوقع سماع ثلاثة أنواع من أصوات التنفس الطبيعية: □ bronchial (sometimes called <i>tracheal</i> or <i>tubular</i>) قصبي (أحياناً يسمى قصبي أو أنبوبي) □ bronchovesicular برونكو فزيكولار □ and vesicular وحويصني	
□ Note the normal location of the three types of breath sounds لاحظ الموقع الطبيعي للثلاثة أنواع أصوات التنفس	□ Decreased or absent breath sounds occur: انخفاض أو غياب التنفس تحدث الأصوات: □ When the bronchial tree is obstructed by secretions, mucous plug, or a foreign body. عندما تكون شجرة الشعب الهوائية مسدودة بواسطة إفرازات، سدادة مخاطية، أو شيء غريب الجسم. □ In emphysema, due to loss of elasticity in the lung fibers and decreased force of inspired air. في النفاخ، بسبب فقدان المرونة في الألياف الرئة وانخفاض القوة في الهواء المستنشق. □ When anything obstructs transmission of sound such as pleurisy or pleural thickening or air (pneumothorax) or fluid (pleural effusion) in the pleural space. عندما يعيق أي شيء الانتقال من الصوت مثل التهاب الجنبة أو الجنبي سمك أي هواء (استرواح الصدر) أو سائل (انصباب جنبي) في الغشاء الجنبي. □ Increased breath sounds— زيادة أصوات التنفس — □ Bronchial sounds are abnormal over the peripheral lung fields. الأصوات الشعب الهوائية غير طبيعية فوق المناطق الطرفية للرئتين. □ They occur when consolidation (e.g., in pneumonia) or compression yields a denser lung area that enhances the transmission of sound from the bronchi. تحدث عندما يحدث الدمج (على سبيل المثال، في الالتهاب الرئوي) أو الضغط ينتج منطقة رئة أكثر كثافة تعزز انتقال الصوت من القصبات الهوائية. □ When the inspired air reaches the alveoli, it hits solid lung tissue, which conducts sound more efficiently to the surface. عندما يصل الهواء المستنشق إلى الحويصلات، تصطدم بنسيج الرئة الصلب، الذي ينقل الصوت بشكل أكثر كفاءة إلى السطح.
Adventitious Sounds أل أصوات العرضية	
□ Note the presence of any adventitious sounds. لاحظ وجود أي شيء طارئ أصوات: □ These are abnormal sounds caused by the collision of moving air with secretions in the tracheobronchial passageways or by the popping open of a previously deflated airway. هذه أصوات غير طبيعية ناتجة عن تصادم الهواء المتحرك مع الإفرازات في الممرات القصبية الرغامية أو بواسطة القفز مفتوح من مجرى هواء كان مغلق مسبقاً.	□ Crackles (or rales) occur with pneumonia and pulmonary edema, and wheezes (or rhonchi) occur with asthma and emphysema. تحدث فرقعات (أو رخازات) مع الالتهاب الرئوي وذمة الرئة، و الصفير (أو الرونكي) يحدث مع الربو والانتفاخ الرئوي.



sites

- 0 Upper left
- 1 Upper right
- 2 Middle right
- 3 Middle left
- 4 Lower left
- 5 Lower right
- 6 Costophrenic: right angle
- 7 Costophrenic: left angle

Auscultation of Posterior and Anterior Chest

Characteristics of Normal Breath Sounds

Characteristics of Breath Sounds				
	Duration of Sounds	Intensity of Expiratory Sound	Pitch of Expiratory Sound	Locations Where Heard Normally
Vesicular* 	Inspiratory sounds last longer than expiratory ones.	Soft	Relatively low	Over most of both lungs
Broncho-vesicular 	Inspiratory and expiratory sounds are about equal.	Intermediate	Intermediate	Often in the 1st and 2nd interspaces anteriorly and between the scapulae
Bronchial 	Expiratory sounds last longer than inspiratory ones.	Loud	Relatively high	Over the manubrium, if heard at all
Tracheal 	Inspiratory and expiratory sounds are about equal.	Very loud	Relatively high	Over the trachea in the neck

* The thickness of the bars indicates intensity; the steeper their incline, the higher the pitch.

29

Inspect the Anterior Chest

أفحص الصدر الأمامي

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Shape and Configuration الشكل والتكوين	
- The ribs are sloping downward with symmetric interspaces. الأضلاع مائلة للأسفل مع المسافات البينية المتماثلة. - The costal angle is within 90 degrees. زاوية الصلع تقع ضمن 90 درجة. - Development of abdominal muscles is as expected for the person's age, weight, and athletic condition. تطوير عضلات البطن يكون مثل متوقع لأمير الشخص ووزنه و اللياقة البدنية.	- Barrel chest has horizontal ribs and costal angle greater than 90 degrees. الصدر البرميلي له ضلوع أفقية و زاوية الأضلاع أكبر من 90 درجة. - Hypertrophy of abdominal muscles occurs with chronic emphysema. تضخم عضلات البطن يحدث مع النفاخ الرئوي المزمن.
Facial Expression تعبير الوجه	
Relaxed and benign, indicating an unconscious effort of breathing. مسترخ وودود، مما يشير إلى جهد التنفس اللاواعي.	Tense, strained, tired facies and pursed-lipped breathing accompany COPD. وجه متوتر، مشدود، متعب وشفاه مشدودة التنفس الشفوي يصاحب مرض الانسداد الرئوي المزمن.
Level of Consciousness مستوى الوعي	
Alert and cooperative. اليقظ ومتعاون.	Cerebral hypoxia presents with excessive drowsiness or anxiety, restlessness, and irritability. يظهر نقص الأكسجة الدماغية مع النعاس أو القلق المفرط التماثل والعصبية.
Skin Color and Condition لون الجلد وحالته	
- The lips and nail beds are free of cyanosis or unusual pallor. الشفاه وأحواض الأظافر خالية من الزرققة أو شحوب غير معتاد. - The nails are of normal configuration. الأظافر طبيعية الشكل.	Clubbing of fingertips occurs with chronic respiratory disease. تحدث تخرج أطراف الأصابع مع مرض تنفسي مزمن.
Quality of Respirations جودة التنفس	
Normal, relaxed breathing is automatic and effortless, regular, and even and produces no noise. التنفس الطبيعي تلقائي و سهّل، منتظم، ومتساوي ولا ينتج أي ضوضاء.	- Noisy breathing occurs with severe asthma or chronic bronchitis. يحدث التنفس الصاخب مع الحالات الشديدة الربو أو التهاب الشعب الهوائية المزمن. - Unequal chest expansion occurs when part of the lung is obstructed or يحدث توسع الصدر بشكل غير متساو عندما جزء من الرئة مسدود أو

University of Al Bayan/ College of Nursing 2 nd stage جامعة البصرة / كلية التمريض	Health assessment / Lab 7 المراجعة / تقييم الصحة / المختبر
- The chest expands symmetrically with each inspiration. الصدر يتمدد بشكل متماثل مع كل نفس إلهام. - Note any localized lag on inspiration. لاحظ أي تأخير موضعي عند الشهيق.	- collapsed, as with pneumonia, or with guarding to avoid postoperative incisional pain or the pain of pleurisy. انهيار. كما هو الحال مع الالتهاب الرئوي، أو مع الحراسة لتجنب بعد العملية الألم الشقي الجراحي أو ألم الجنبة. - The rectus abdominis and internal intercostal muscles are used to force expiration in COPD. تستخدم عضلات البطن والداخلية لتسريع عمليات بين الأضلاع لإجبار التنفس في مرض الانسداد الرئوي المزمن.
- The respiratory rate is within normal limits for the person's age, and the pattern of breathing is regular. معدل التنفس ضمن الحدود الطبيعية لعمر الشخص، ونمط التنفس منتظم. - Occasional sighs normally punctuate breathing. الزفرات العرضية عادة ما تقطع التنفس.	Tachypnea and hyperventilation, bradypnea and hypoventilation, periodic breathing. تسرع التنفس وفرط التهوية، بطء التنفس وانخفاض التهوية، دوري التنفس.

Percuss the Anterior Chest

اضغط على الصدر الأمامي

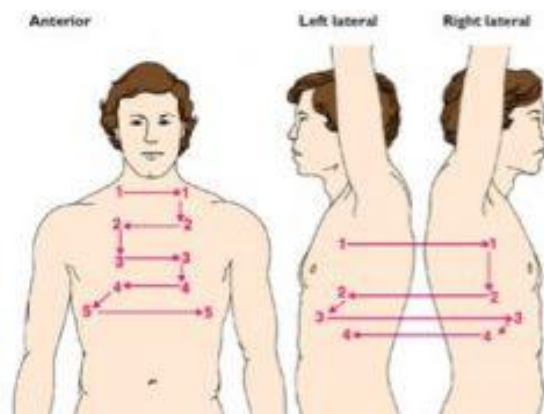
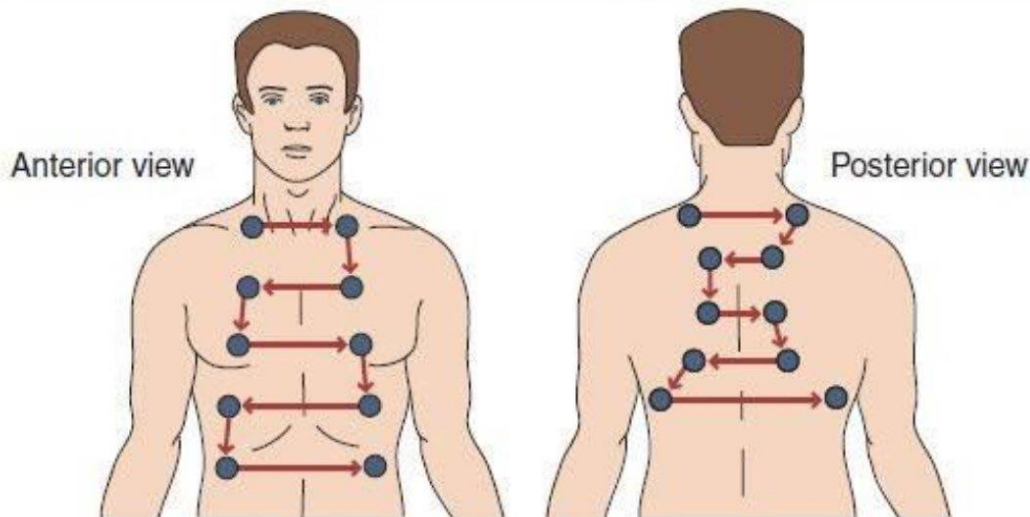
Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
- Begin at the apices. Percussing the interspaces and comparing one side to the other side then move down the anterior chest. ابداً عند القمم. اضغط برفق على المسافات بين الأشياء ومقارنة جانب بآخر الجانب الآخر ثم الانتقال للأسفل على الصدر الأمامي. - Normally you hear a resonant note over healthy lung tissue. عادة ما تسمع نغمة رنانة فوق نسيج رئوي سليم. - Note the borders of cardiac dullness normally found on the anterior chest and do not confuse these with suspected lung pathology. لاحظ حدود خمول القلب بشكل طبيعي. توجد على الصدر الأمامي ولا لا تخطئ بين هذا واعتلال الرئة المشتبه به. - In the right hemithorax the upper border of liver dullness is located in the 5th intercostal space in the right midclavicular line. في نصف الصدر الأيمن الحد العلوي لـ خمول الكبد موجود في الفراغ الضلعي الخامس المساحة في خط الترقوة المتوسط الأيمن. - On the left, tympany is evident over the gastric space. على اليسار، من الواضح وجود طبلية عند المعدة.	Lungs are hyperinflated with chronic emphysema, resulting in hyperresonance where cardiac dullness would be expected. الرئتان ممتلئتان بالهواء بشكل مفرط مع مزمن الانتفاخ الرئوي، مما يؤدي إلى الارتداد المفرط حيث خمول القلب من المتوقع.

Auscultate the Anterior Chest

استمع إلى صدر الأمام

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
- Auscultate the lung fields over the anterior chest from the apices in the supraclavicular areas down to the 6th rib. استمع إلى مناطق الرئة من الأمام الصدر من القمم في فوق الترقوة المناطق وصولاً إلى الضلع السادس. - Progress from side to side as you move downward and listen to one full respiration in each location. تحرك من جانب إلى آخر وأنت تتحرك انخفض واستمع إلى شهيق كامل كل موقع. - You should expect to hear vesicular breath sounds over most of the anterior lung fields. يجب أن تتوقع سماع التنفس الحويصلي أصوات فوق معظم مناطق الرئة الأمامية.	

Order of Auscultating Lung Sounds



Anterior

- 1 trachea
- 2 upper right lung field
- 3 upper left lung field
- 4 middle left lung field
- 5 middle right lung field
- 6 lower right lung field
- 7 lower left lung field



Posterior

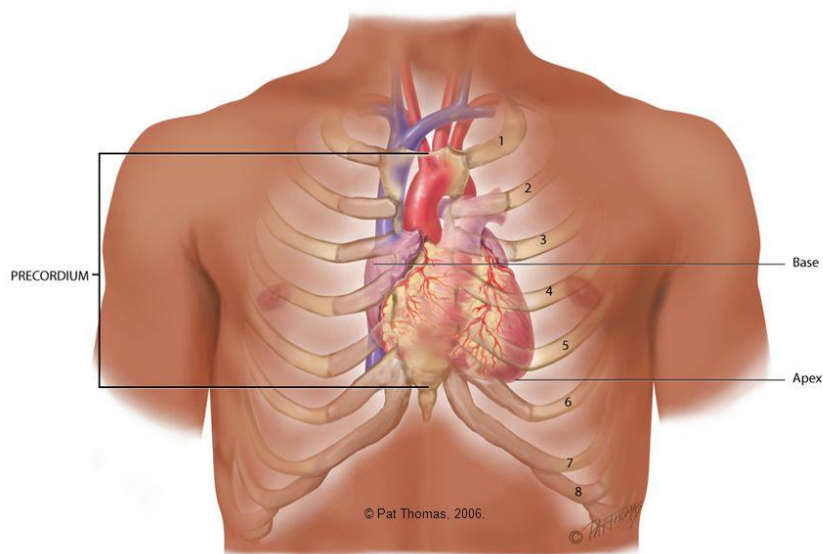
- 0 upper left lung field
- 1 upper right lung field
- 2 middle right lung field
- 3 middle left lung field
- 4 lower left lung field
- 5 lower right lung field
- 6 right costophrenic angle
- 7 left costophrenic angle

جامعة البيان كلية التمريض المرحلة الثانية

مادة التقييم الصحي والفحص البدني

عملي / مختبر 8

Precordium, Apex and Base



Heart and Neck Vessels Assessment

تقييم القلب والأوعية الدموية في الرقبة

Cardiovascular Assessment

تقييم القلب والأوعية الدموية

Heart and Neck Vessels Assessment

تقييم القلب والأوعية الدموية في الرقبة

Objectives:

الأهداف:

At the end of this lab, the student will be able to:

في نهاية هذا المختبر، سيكون الطالب قادراً على:

- Demonstrate the ability to safely and accurately complete heart & neck vessels assessment.
إظهار القدرة على إكمال فحص القلب بأمان ودقة تقييم.
- Demonstrate the ability to accurately document heart & neck vessels assessment data in organized manner.
إظهار القدرة على توثيق القلب بدقة بيانات التقييم بشكل منظم

Equipment needed:

المعدات المطلوبة:

- Marking pen
قلم تمييز
- Small ruler marked in centimeters
مسطرة صغيرة محددة بالسنتيمترات
- Stethoscope with diaphragm and bell endpieces
سماعة طبية مع رأس غشاء ورأس جرس
- Alcohol wipe (to clean endpieces)
منديل كحولي (لتنظيف الأطراف)

Preparation:

التحضير:

- To evaluate the carotid arteries, the person may be sitting up.
لتقييم شرايين الرقبة، قد يكون الشخص جالساً.
- To assess the jugular veins and the precordium, the person should be supine with the head and chest slightly elevated.
لتقييم الأوردة الوداجية والمنطقة الصدرية الأمامية، يجب أن يكون الشخص مستلقياً مع رفع الرأس والصدر قليلاً.
- Stand on the person's right side.
قف على الجانب الأيمن للشخص.
- The room should be warm
الغرفة يجب أن تكون دافئة
- Ensure the female's privacy by keeping her breasts draped.
احرص على خصوصية المرأة بتغطية صدرها.
- Gently displace the breast upward, or ask the client to hold it out of the way.
حرك الثدي برفق إلى الأعلى، أو اطلب من العميل أن تثبته بعيداً عن الطريق.

SUBJECTIVE DATA:

البيانات الشخصية:

1. Chest pain
1. ألم في الصدر2. Dyspnea
2. ضيق التنفس3. Orthopnea
3. ضيق التنفس عند الاستلقاء4. Cough
4. سعال5. Fatigue
5. التعب6. Cyanosis or pallor
6. ازرقاق أو شحوب7. Edema
7. وذمة8. Nocturia
8. التبول الليلي9. Past history (hypertension, elevated cholesterol, heart murmur, rheumatic fever, anemia, heart disease)
9. التاريخ الطبي السابق (ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، عطل القلب، الحمى الروماتيزمية، فقر الدم، أمراض القلب)10. Family history (hypertension, obesity, diabetes, coronary artery disease)
10. التاريخ العائلي (ارتفاع ضغط الدم، السمنة، السكري، أمراض الشرايين التاجية)11. Lifestyle (diet high in cholesterol, calories, or salt; smoking; alcohol use; drugs; amount of exercise)
11. نمط الحياة (نظام غذائي غني بالكوليسترول أو السعرات الحرارية أو الملح؛ التدخين؛ تناول الكحول؛ المخدرات؛ كمية التمرين)

OBJECTIVE DATA:
البيانات الموضوعية:**THE NECK VESSELS**
أوعية الرقبة**Procedure: Palpate the Carotid Artery (pulse)**
الإجراء: تحسس الشريان السباتي (النبض)

Normal Range of Findings	Abnormal Findings
المدى الطبيعي للنتائج □ Gently palpate only one carotid artery at a time to avoid compromising arterial blood to the brain. قم بالتحسس بلطف لشريان كاروتيد واحد فقط عند حان الوقت لتجنب التأثير على دم الشرايين إلى الدماغ. □ Feel the contour and amplitude of the pulse. Normally the contour is smooth with a brisk upstroke and slower downstroke, and the normal strength is moderate and equal bilaterally. اشعر بمخني وسعة النبض. عادة ما يكون الملمس ناعماً بحركة صعودية سريعة وأبطأ الهبوط، والقوة الطبيعية هي معتدلة ومتساوية على الجانبين.	نتائج غير طبيعية □ Diminished pulse feels small and weak (decreased stroke volume as in shock). النبض الضعيف يبدو صغيراً وضعيفاً (انخفاض حجم النبضة كما في الصدمة). □ Increased pulse feels full and strong and occurs with hyperkinetic states النبض المتسارع يبدو ممتلئاً وقوياً و يحدث مع الحالات المفرطة الحركة

**Auscultate the Carotid Artery**

استمع إلى شريان السباتي

Normal Range of Findings	Abnormal Findings
المدى الطبيعي للنتائج □ For people older than middle age or who show symptoms or signs of CVD, auscultate each carotid artery for the presence of a bruit. للاشخاص الأكبر من منتصف العمر أو الذين تظهر أعراض أو علامات مرض القلب والأوعية الدموية، استمع لكل شريان كاروتيد لوجود لغط. □ This is a blowing, swishing sound indicating blood flow turbulence; normally there is none. هذا صوت هبوب وتهيب يشير إلى اضطراب تدفق الدم بشكل طبيعي ليس هناك أحد. □ Keep the neck in a neutral position. حافظ على الرقبة في وضع محايد. □ Lightly apply the bell of the stethoscope over the carotid artery at three levels: ضع جرس السماعة الطبية برفق فوق الشريان السباتي عند ثلاثة مستويات: (1) the angle of the jaw, (2) the midcervical area, and (3) the base of the neck.	نتائج غير طبيعية □ A bruit indicates turbulence from a local vascular cause, e.g., atherosclerotic narrowing. الطنين يشير إلى اضطراب من مصدر محلي سبب وعائي، مثل التصلب العصيدي تضيق. □ A carotid bruit is audible when the lumen is occluded by 1 2 to 2 3. يمكن سماع صوت صغير الشريان السباتي عندما يكون التجويف محجوزاً من 1 2 إلى 2 3. □ Bruit loudness increases as the atherosclerosis worsens until the lumen is occluded by 2 3. يزداد ضجيج الصوت كلما تتفاقم تصلب الشرايين حتى يصبح التجويف محجوزاً بواسطة 2 3. □ When the lumen is completely occluded, the bruit disappears. عندما يتم انسداد اللومن تماماً، يختفي الضوضاء. □ Thus, absence of a bruit is not a sure sign of absence of a carotid lesion. لذا، عدم وجود صوت غير طبيعي ليس علامة مؤكدة غياب آفة في الشريان السباتي. □ A murmur sounds much the same but it is caused by a cardiac disorder. همسة تبدو متشابهة جداً لكنها ناتجة عن اضطراب قلبي. □ Some aortic valve murmurs radiate to the neck and must be distinguished from a local bruit. بعض لغط صمام الأبهر ينتشر إلى الرقبة ويجب تمييزها عن صوت محلي.

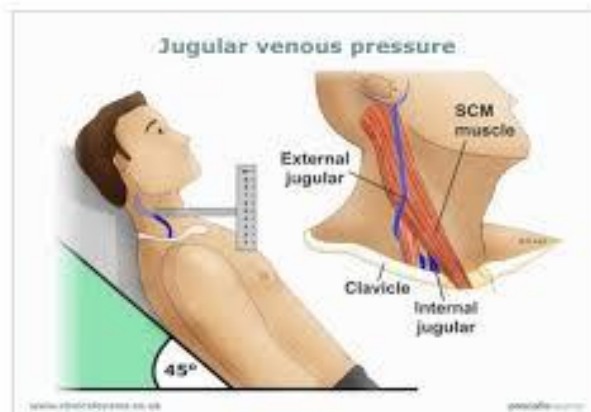
2 □ Avoid compressing the artery because this could create an artificial bruit. □ Ask the person to hold his or her breath while you listen.	الملاحظة تقييم الصحة / المختبر
--	---



Inspect the Jugular Venous Pulse

افحص نبض الوريد الوداجي

Normal Range of Findings	Abnormal Findings
المدى الطبيعي للنتائج □ Position the person supine with the torso elevated anywhere from a 30- to a 45-degree angle. □ Remove the pillow to avoid flexing the neck. □ Stand on the patient's right, turn the head slightly away from the examined side, and direct a strong light tangentially onto the neck to highlight pulsations and shadows.	نتائج غير طبيعية
عضلة القصبة الرقبية □ Note the external jugular veins overlying the sternomastoid muscle. □ In some people the veins are not visible at all; in others they are full in the supine position. □ As the person is raised to a sitting position, these external jugulars flatten and disappear, usually with bed at 45 degrees.	□ Unilateral distention of external jugular veins is from a local cause, e.g., kinking or aneurysm. □ Fully distended external jugular veins above 45 degrees show increased central venous pressure (CVP).



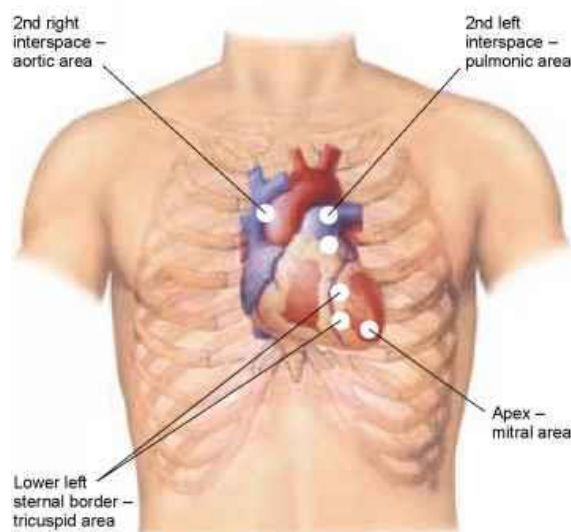
THE PRECORDIUM (heart)

الصدر أمام القلب (القلب)

Inspect the Anterior Chest (pulse)

أفحص الصدر الأمامي (النبض)

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
- You may or may not see the apical impulse. قد ترى أو لا ترى القمم القمي - When visible, it occupies the 4th or 5th intercostal space, at or inside the midclavicular line. عندما يكون مرئياً، يشغل المركز الرابع أو الخامس الفراغ بين الأضلاع، عند أو داخل الخط منتصف الترقوة - It is easier to see in children or those with thin chest walls. من الأسهل رؤيته لدى الأطفال أو الأشخاص الذين لديهم جدران صدر رقيقة.	- A heave or lift is a sustained forceful thrusting of the ventricle during systole. الرفع أو السحب هو قوة مستمرة وقوية اندفاع البطين أثناء الانقباض - It occurs with ventricular hypertrophy and is seen at the sternal border or the apex. يحدث مع تضخم البطين و يرى عند الحد القصبي أو القمة.

**Palpate the Apical Impulse**

اضغط على النبضة القمية

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
- Localize the apical impulse precisely using one finger pad. حدد نبضة القلب القمية بدقة باستخدام وسادة أصبع واحدة NOTE: Location—The apical impulse should occupy only one interspace, the 4th or 5th, and be at or medial to the midclavicular line المكان—يجب أن تكون النبضة القمية تشغل مساحة واحدة فقط، الرابعة أو الخامسة، وإن يكون عند أو في وسط الخط الأمامي المتوسط Size—Normally 1 cm × 2 cm الحجم—عادة 1 سم × 2 سم Amplitude—Normally a short, gentle tap السعة — عادة قصيرة ولطيفة Duration—Short, normally occupies only first half of systole المدة — قصيرة، عادة ما تستغرق النصف الأول فقط من الانقباض	Cardiac enlargement: تضخم القلب - Left ventricular dilation (volume overload) displaces apical impulse down and to the left and increases size more than one space. توسع البطين الأيسر (زيادة حجم الدم) يزاح نبض القلب القمي للأسفل وإلى اليسار ويزيد الحجم أكثر من واحد فضاء - Increased force and duration but no change in location occurs with left ventricular hypertrophy and no dilation (pressure overload). زيادة القوة والمدة لكن بدون تغيير يحدث في الموقع مع البطين الأيسر تضخم وعدم توسع (ضغط تحميل زائد).
- The apical impulse is palpable in about half of adults. النبضة القمية يمكن إحساسها تقريبا في نصف البالغين - It is not palpable in obese people or people with thick chest walls. لا يمكن الشعور به في الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو الأشخاص بجدران صدرية سمكية - With high cardiac output states (anxiety, fever, hyperthyroidism, anemia), the apical impulse increases in amplitude and duration. مع حالات ارتفاع ناتج القلب (القلق، الحمى، فرط نشاط الغدة الدرقية، فقر الدم)، القمي، يزداد نبضة في السعة والمدة	Apical impulse is not palpable with pulmonary emphysema due to hyperinflated lungs, which override the heart. لا يمكن الشعور بالنبضة القمية مع الانثقاع الرئوي بسبب الرئات منتفخة بشكل مفرط، تتجاوز القلب

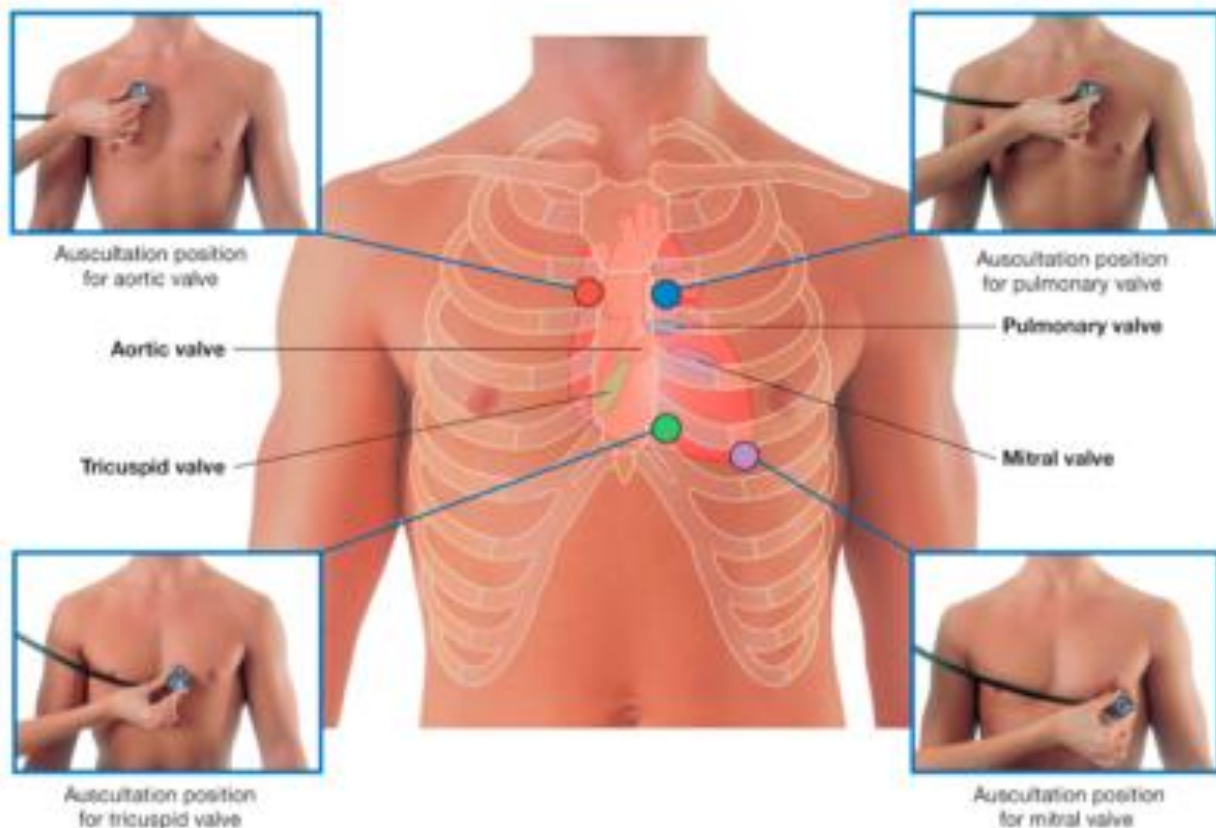
Palpate Across the Precordium

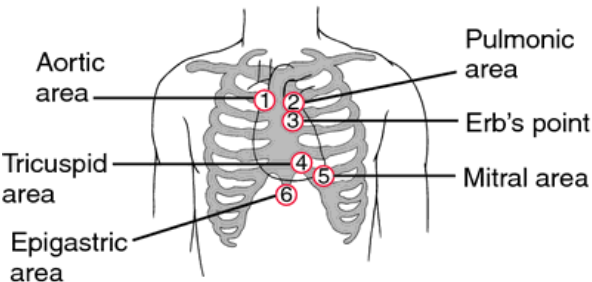
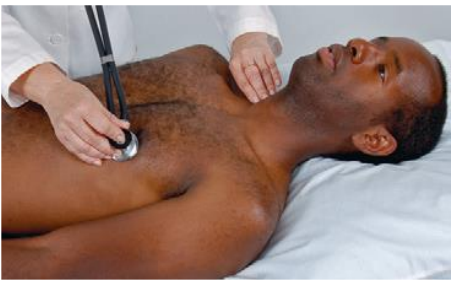
تحسس عبر منطقة الصدر الأمامية

Normal Range of Findings	Abnormal Findings
المدى الطبيعي للنتائج □ Using the palmar aspects of your four fingers, gently palpate the apex, the left sternal border, and the base, searching for any other pulsations; normally there are none. □ If any are present, note the timing. □ Use the carotid artery pulsation as a guide or auscultate as you palpate. استخدام الجوانب الكفية لأصابعك الأربعة باستخدام الأصابع، المحصن برفق القمة، الحافة اليسرى الحافة القصية، والقاعدة، باحثاً عن أي نبضات أخرى؛ عادة هناك لا شيء. إذا كان هناك أي منها، لاحظ الوقت. استخدم نبض شريان الرقبة كدليل أو استمع أثناء الضغط باللمس.	نتائج غير طبيعية □ A thrill is a palpable vibration. □ It feels like the throat of a purring cat. It signifies turbulent blood flow and accompanies loud murmurs. □ However, absence of a thrill does not necessarily rule out the presence of a murmur الضغيرة هي اهتزاز ملموس. يشعر وكأنه حنجرة قطرة تخرخر. إنه يشير إلى تدفق الدم المضطرب و يصاحب بهمهمات عالية. ومع ذلك، غياب الاهتزاز لا يعني لا يستبعد بالضرورة وجود همس.

**Auscultate the Heart Sounds**

استمع لصوت القلب

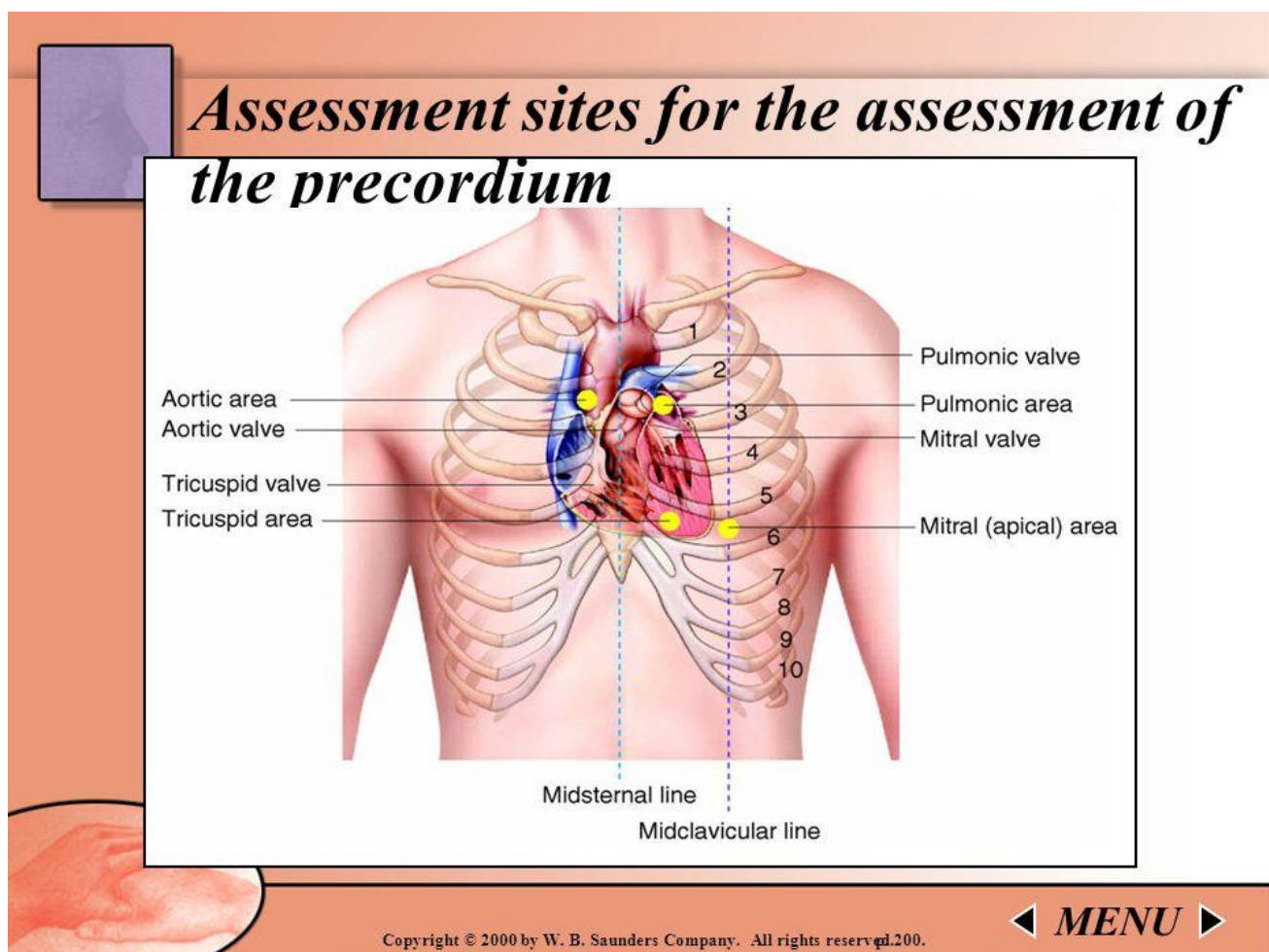


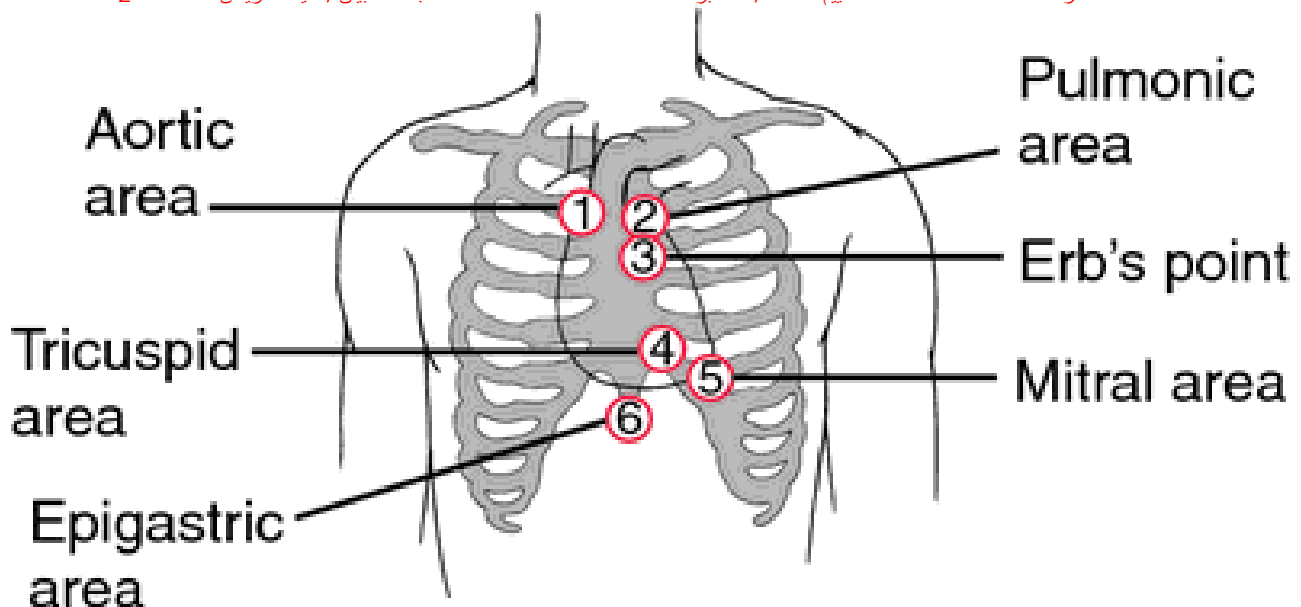
المدة الطبية للنتائج Normal Range of Findings	تقديم للصحة / المختبر Abnormal Findings لنتائج غير طبيعية
- Identify the auscultatory areas where you will listen. The four traditional valve “areas” are not over the actual anatomic locations of the valves but are the sites on the chest wall where sounds produced by the valves are best heard: Second right interspace—Aortic valve area المسافة بين الضلع الثاني اليميني - الأيمن Second left interspace—Pulmonic valve area المسافة بين الضلعين الثانيين من الجهة اليسرى — الرئوي Left lower sternal border—Tricuspid valve area الحد الأيسر السفلي لعظم القص Fifth interspace at around left midclavicular line—Mitral valve area مساحة صمام ثلاثي الشرف	
- Do not limit your auscultation to only four locations because sounds produced by the valves may be heard all over the precordium. - Learn to inch your stethoscope in a Z-pattern, from the base of the heart across and down and over to the apex; or start at the apex and work your way up. - Begin with the diaphragm endpiece and clean it with an alcohol wipe. - Use the following routine: (1) note the rate and rhythm; (2) identify S1 and S2; (3) assess S1 and S2 separately; (4) listen for extra heart sounds; and (5) Listen for murmurs. - Note the Rate and Rhythm. - The rate changes normally from 50 to 95 beats/min.	
- The rhythm should be regular, although sinus arrhythmia occurs normally in young adults and children. - With sinus arrhythmia, the rhythm varies with the person's breathing, increasing at the peak of inspiration and slowing with expiration. - Note any other irregular rhythm.	Premature beat—An isolated beat is early or a pattern occurs in which every 3rd or 4th beat sounds early. Irregularly irregular—No pattern to the sounds; beats come rapidly and at random intervals.
- Identify S1 and S2. - Usually you can identify S1 instantly because you hear a pair of sounds close together (“lub-dup”) and S1 is the first of the pair. - Other guidelines to distinguish S1 from S2 are as follows: - S1 is louder than S2 at the apex; S2 is louder than S1 at the base.	

University of Al Bayan/ College of Nursing جامعة البصرة / كلية التمريض	2 nd stage تقديم للصحة / المختبر	Health assessment / Lab 8 المرحلة
S1 coincides with the carotid artery Pulsation تتطابق مع الشريان السباتي S1 S1 coincides with the R wave (the upstroke of the QRS complex) if the person is on an ECG monitor. يتزامن مع موجة R (الضربة الصاعدة لمركب QRS) إذا كان الشخص مربوط على جهاز مراقبة رسم القلب.		
Listen to S1 and S2 Separately. - Note whether each heart sound is normal, accentuated, diminished, or split. Inch your diaphragm across the chest as you do this.	- Causes of accentuated or diminished S1 - Both heart sounds are diminished with increased air or tissue between the heart and your stethoscope such as emphysema (hyperinflated lungs), obesity, and pericardial fluid.	
First Heart Sound (S1). - Caused by closure of the AV valves, S1 signals the beginning of systole. - You can hear it over the entire precordium, although it is loudest at the apex		
Second Heart Sound (S2). - S2 is associated with closure of the semilunar valves. - You can hear it with the diaphragm over the entire precordium, although it is loudest at the base	Accentuated or diminished S2	
Splitting of S2. - A split S2 is a normal phenomenon that occurs toward the end of inspiration in some people. - Recall that closure of the aortic and pulmonic valves is nearly synchronous. - Because of the effects of respiration on the heart, inspiration separates the timing of the two valves' closure, and the aortic valve closes 0.06 second before the pulmonic valve. Instead of one "DUP," you hear a split sound—"T-DUP".		
- During expiration synchrony returns, and the aortic and pulmonic components fuse together. - A split S2 is heard only in the pulmonic valve area, the second left interspace.		
- Concentrate on the split as you watch the person's chest rise up and down with breathing. - The split S2 occurs about every 4th heartbeat, fading in with inhalation and fading out with exhalation.		- A fixed split is unaffected by respiration; the split is always there. - A paradoxical split is the opposite of what you would expect: the sounds fuse on inspiration and split on expiration
- Focus on Systole, Then on Diastole, and Listen for Any Extra Heart Sounds. - Listen with the diaphragm and then switch to the bell, covering all auscultatory areas. - Usually these are silent periods.	- During systole the midsystolic click is the most common extra sound. - The S3 and S4 occur in diastole; either may be normal or abnormal	

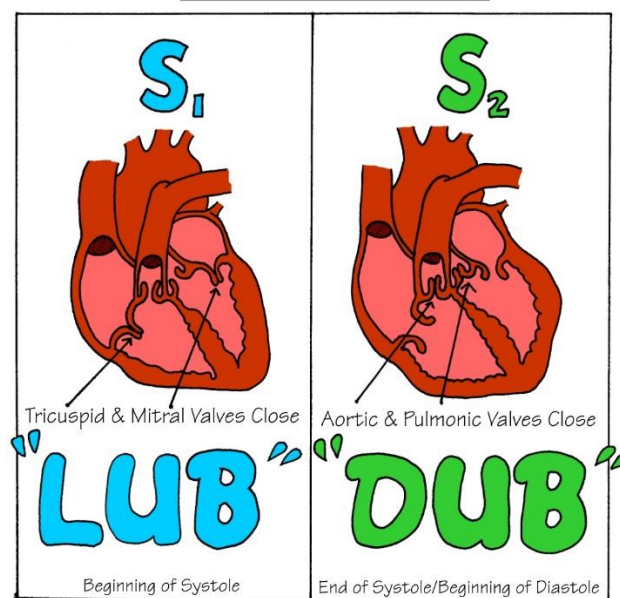
University of Al Bayan/ College of Nursing 2 nd stage جامعة البصرة / كلية التمريض	Health assessment / Lab 8 تقييم الصحة / المختبر المرحلة
When you do detect an extra heart sound, listen carefully to note its timing and characteristics.	
Listen for Murmurs. A murmur is a blowing, swooshing sound that occurs with turbulent blood flow in the heart or great vessels. - Except for the innocent murmur described on the following page, murmurs are abnormal. - If you hear a murmur, describe it by indicating these characteristics: Timing. Systole or diastole. Loudness. The intensity in terms of six grades: Grade 1—Barely audible, heard only in a quiet room and then with difficulty Grade 2—Clearly audible but faint Grade 3—Moderately loud Grade 4—Loud; associated with a thrill palpable on the chest wall Grade 5—Very loud; heard with one edge of the stethoscope lifted off the chest wall Grade 6—Loudest; still heard with entire stethoscope lifted just off the chest wall	- Conditions resulting in a murmur include high rate of flow through a normal valve such as with exercise, pregnancy, or thyrotoxicosis; - restricted forward blood flow through a stenotic valve; - backward flow through a regurgitant valve; and (4) blood flow through abnormal openings in the chambers. - For a description of pathologic murmurs, using these characteristics,
Pitch. High, medium, or low. Pattern. Growing louder (crescendo), tapering off (decrescendo), or increasing to a peak and then decreasing (crescendo-decrescendo, or diamondshaped). - Since the entire murmur is just milliseconds long, it takes practice to diagnose pattern. Quality. Musical, blowing, harsh, or rumbling. Location. Area of maximum intensity of the murmur (where it is best heard) as noted by the valve area or intercostal spaces. Radiation. Heard in another place on the precordium, the neck, the back, or the axilla. Posture. Murmurs may disappear or be enhanced by a change in position. Innocent Murmurs. Some murmurs are common in healthy children or adolescents and are termed innocent or functional. - The contractile force of the heart is greater in children. - This increases blood flow velocity. - The increased velocity, plus a smaller chest measurement, makes an audible murmur.	

University of Al Bayan/ College of Nursing 2nd stage جامعة البصرة / كلية التمريض	Health assessment / Lab 8 المرحلة تقييم الصحة / المختبر
□ The innocent murmur is generally soft (grade 2), midsystolic, short, and crescendo-decrescendo, with a vibratory or musical quality ("vooot" sound like fiddle strings). □ Also, the innocent murmur is heard at the 2nd or 3rd left intercostal space and disappears with sitting, and the young person has no associated signs of cardiac dysfunction.	□ Although it is important to distinguish innocent murmurs from pathologic ones, it is best to suspect all murmurs as pathologic until proved otherwise. □ Diagnostic tests such as ECG and echocardiography are needed to establish an accurate diagnosis.
□ Change Position. □ After auscultating in the supine position, roll the person toward his or her left side. □ Listen with the bell at the apex for the presence of any diastolic filling sounds.	□ S3 and S4 and the murmur of mitral stenosis may sometimes be heard only when on the left side.



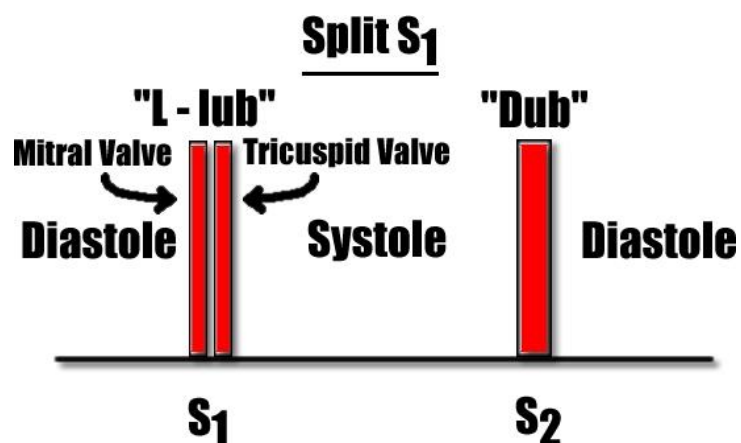


HEART SOUNDS



©2007 Nursing Education Consultants, Inc.

C.J. MILLER

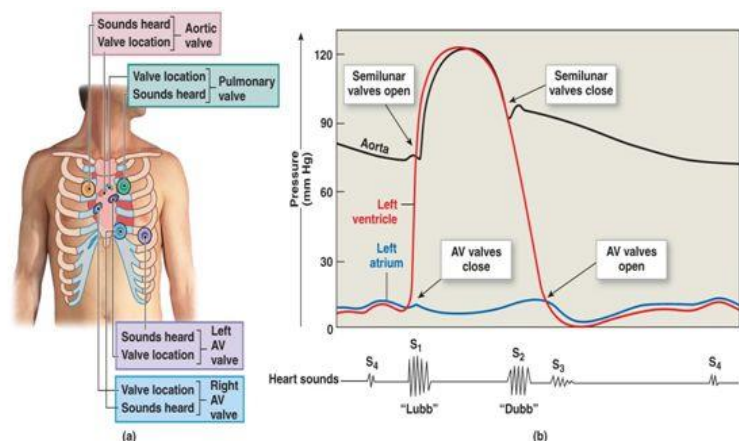


Heart sounds

- **S1**: closing of the AV valves
 - mitral then tricuspid
- **S2**: closing of the semilunar valves
 - aortic then pulmonary
- **S3**: ventricular overload
 - "TEN-NE-see": S1, S2, S3
 - <40yrs, pregnancy, MR/TR, CHF
- **S4**: decreased LV compliance
 - "ken-TUCK-Y": S4, S1, S2
 - more likely than S3 to be pathologic (HTN, CAD, cardiomyopathy), although can be normal (athletes)

Heart Sounds

- **S₁**
 - Loud sounds
 - Produced by AV valves
- **S₂**
 - Loud sounds
 - Produced by semilunar valves
- **S₃, S₄**
 - Soft sounds
 - Blood flow into ventricles and atrial contraction



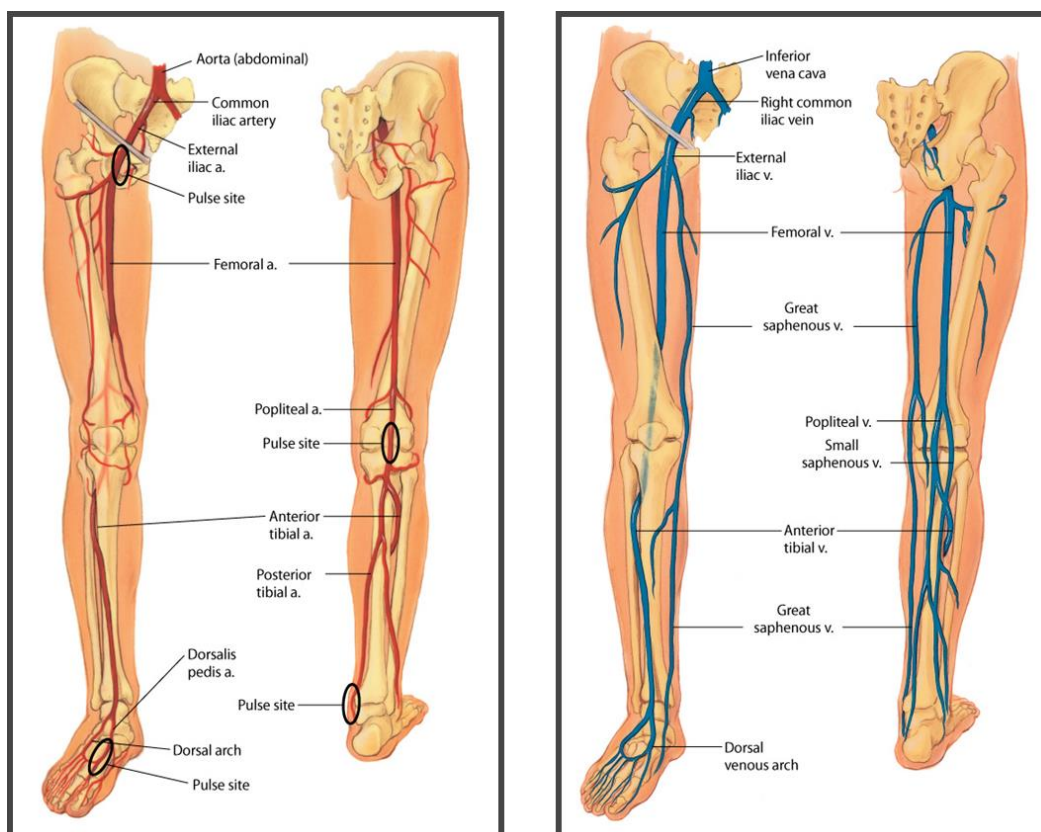
Heart Sounds

<http://depts.washington.edu/physdx/heart/tech1.html>

جامعة البيان كلية التمريض المرحلة الثانية

مادة التقييم الصحي والفحص البدني

عملي / مختبر 9



Peripheral Vascular System & Lymphatic System Assessment
الجهاز الوعائي الطرفي**Cardiovascular Assessment**

تقييم القلب والأوعية الدموية

Peripheral Vascular System & Lymphatic System Assessment

الجهاز الوعائي الطرفي

Objectives:

الأهداف:

At the end of this lab, the student will be able to:

في نهاية هذا المختبر، سيكون الطالب قادراً على:

- Demonstrate the ability to safely and accurately complete peripheral vascular system & lymphatic system assessment.
• إظهار القدرة على إكمال الفحوصات الوعائية الطرفية بأمان ودقة النظام
- Demonstrate the ability to accurately document peripheral vascular system & lymphatic system assessment data in organized manner
• إظهار القدرة على توثيق نظام الأوعية الدموية الطرفية بدقة بيانات تقييم الجهاز اللمفاوي بطريقة منظمة

Equipment needed:

المعدات المطلوبة:

- Tape measure
• شريط القياس
- Tourniquet or blood pressure cuff
• رباط ضاغط أو كم ضغط الدم
- Stethoscope
• سماعة طبية
- Doppler ultrasonic stethoscope
• سماعة دوبلر فوق صوتية

Preparation:

التحضير:

- During a complete physical examination, examine the arms at the very beginning when you are checking the vital signs and the person is sitting.
• أثناء الفحص البدني الكامل، افحص الذراعين عند الحد الأقصى ابداً عندما تتحقق من العلامات الحيوية والشخص جالس.
- Examine the legs directly after the abdominal examination while the person is still supine.
• افحص الساقين مباشرة بعد فحص البطن بينما يكون الشخص لا يزال مستلقياً على ظهره.
- Then have the person stand up to evaluate the leg veins.
• بعد ذلك، اجعل الشخص يقف لتقييم أوردة الساق.

SUBJECTIVE DATA:

البيانات الشخصية:

1. Leg pain or cramps
1. ألم أو تشنجات في الساق
2. Skin changes on arms or legs
2. تغيرات في الجلد على الذراعين أو الساقين
3. Swelling in legs
3. تورم في الساقين
4. Lymph node enlargement (swollen glands)
4. تضخم العقد اللمفاوية (التضخم المنتفخة)
5. Medications
5. الأدوية
6. Smoking history
6. تاريخ التدخين

OBJECTIVE DATA:
البيانات الموضوعية:**Procedure: INSPECT AND PALPATE THE ARMS**
الإجراء: فحص وجس الذراعين

Normal Range of Findings	Abnormal Findings
المدى الطبيعي للنتائج □ Note color of skin and nail beds; temperature, texture, and turgor of skin; and the presence of any lesions, edema, or clubbing. لاحظ لون الجلد وأصابع الأظفار؛ درجة حرارة الجلد، وملمسه، وتورمه؛ ووجود أي آفات أو وذمة أو clubbing. انتعاب إلى الشوائب.	نتائج غير طبيعية □
Check capillary refill. افحص إعادة تعبئة الشرايين الدموية. □ Depress and blanch the nail beds; release and note the time for color return. اضغط وحول أظفار الأصابع إلى اللون الشاحب؛ حرر واكتب الوقت لرجوع اللون. □ Usually the vessels refill within a fraction of a second. Consider it normal if the color returns in 1 or 2 seconds. عادة ما تعود الأوعية للأحمر خلال جزء من الوقت من ثانية. اعتبره طبيعياً إذا كان اللون يعود خلال ثانية أو ثانيتين. □ Note conditions that can skew your findings, including a cool room, decreased body temperature, cigarette smoking, peripheral edema, and anemia. لاحظ الظروف التي يمكن أن تؤثر على الاكتشافات، بما في ذلك غرفة باردة، قلت درجة حرارة الجسم تدخين التبغ، وذمة الأطراف وهبوط الدم.	□ Refill lasting more than 1 or 2 seconds signifies vasoconstriction or decreased cardiac output (hypovolemia, heart failure, and shock). إعادة الملء التي تستمر أكثر من ثانية أو ثانيتين يشير إلى تضيق الأوعية أو انخفاض خرج القلب (نقص حجم الدم، فشل القلب، والصدمة). □ The hands are cold, clammy, and pale. اليدين باردتين ورطبتين وفاتحتين.
□ The two arms should be symmetric in size. يجب أن تكون الذراعان متماثلتين في الحجم.	□ Edema of upper extremities occurs when lymphatic drainage is obstructed after breast surgery or radiation تورم الأطراف العلوية يحدث عندما التصريف اللمفاوي هو مسدود بعد جراحة الثدي أو العلاج الإشعاعي
□ Note the presence of any scars on hands and arms. لاحظ وجود أي ندوب في اليدين والذراعين. □ Many occur normally with usual childhood abrasions or with occupations involving hand tools. الكثير يحدث بشكل طبيعي مع المعابد خدوش الطفولة أو مع المهن التي تستخدم الأدوات اليدوية.	□ Needle tracks in hands, arms, and antecubital fossae occur with intravenous drug use; linear scars in wrists may signify past self-inflicted injury. آثار الإبر في اليدين والذراعين و تحدث جفيرة المرفق الأمامية مع الحقن الوريدي تعاطي المخدرات؛ قد تشير الندوب الخطية في المعصمين إصابة سابقة سببها لنفسك.
Palpate both radial pulses, noting rate, rhythm, elasticity of vessel wall, and equal force. افحص نبضتي الراسغين، مع ملاحظة السرعة، الإيقاع، ومرونة جدار الوعاء الدموي، والتساوي قوة. Grade the force (amplitude) on a three-point scale: قيم القوة (السعة) على ثلاثة نظام النقاط: ❖ 3+ increased, bounding □ 3 متزايدة، نابضة ❖ 2+ normal □ 2 عادي ❖ 1+ weak □ 1 ضعيف ❖ 0 absent □ 0 غائب	□ Weak, thready pulse occurs with shock or peripheral arterial disease; النبض ضعيف وخفيف يحدث مع الصدمة أو مرض الشرايين المحيطية; □ full bounding pulse (3+) with hyperkinetic states (exercise, anxiety, fever), anemia, hyperthyroidism. نبض كامل مرتفع (3) مع فرط حركي الحالات (ممارسة الرياضة، القلق، الحمى)، فقر الدم فرط نشاط الغدة الدرقية □ Dropped beats; irregular pulse نبضات متقطعة؛ دقات غير منتظمة
Palpate the brachial pulses; their force should be equal bilaterally. اشعر بنبضات الشريان العضدي؛ قوتها يجب أن يكون متساوية من الجانبين. □ Check the epitrochlear lymph nodes in the depression above and behind the medial condyle of the humerus. افحص العقد اللمفاوية فوق وخلف الجزء الوسيط الاكتئاب فوق وخلف الجزء الوسيط للترس.	□ An enlarged epitrochlear node occurs with infection of hand or forearm, lymphoma, leukemia, infectious mononucleosis. تحدث عقدة إيتروكلية متضخمة مع عدوى في اليد أو الباعد، ورم لمفاوي، لوكيميا، داء كثرة الوحيدات المعدي.

INSPECT AND PALPATE THE LEGS**افحص وحسس الساقين**

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Inspect both legs together, noting skin color, hair distribution, venous pattern, size (swelling or atrophy), and any skin lesions or ulcers. افحص الساقين معاً، مع ملاحظة لون البشرة توزيع الشعر، نمط الأوردة، الحجم (الانتفاخ أو التضمور)، وأي تقرحات أو جروح في الجلد.	- Pallor with vasoconstriction; erythema with vasodilation; cyanosis. شحوب مع تضيق الأوعية الدموية؛ احمرار مع توسع الأوعية الدموية؛ الزرقاء. - Ulcers occur both with chronic arterial and chronic venous insufficiency. تحدث القرح سواء مع المزمن شرياني ووردي مع ضعف كفاءة الأوعية الدموية.
- Hair normally covers the legs. عادةً ما يغطي الشعر الساقين. - Even if leg hair is shaved, you will still note hair on the dorsa of the toes. حتى لو تم حلاقة شعر الساق، ستنظر لا يزال وجود الشعر على ظهر أصابع القدم.	- Malnutrition: thin, shiny, atrophic skin, thick-rimmed nails, loss of hair, ulcers, gangrene. سوء التغذية: نحيف، لامع، ضمائر الجلد، الأظافر السمكية والمختلة، فقدان الشعر، القرحة، الغرغرينا. - Malnutrition, pallor, and coolness occur with arterial insufficiency. سوء التغذية، شحوب، وبرودة يحدث مع نقص الشريان.
- The venous pattern is normally flat and barely visible. النمط الوريدي عادةً يكون مسطحاً و بالكاد مرئياً. - Note obvious varicosities, although these are best assessed while the person is standing. لاحظ الأوردة المتوسعة الواضحة، رغم أن هذه من الأفضل تقييمها بينما يكون الشخص واقفاً. - Both legs should be symmetric in size without swelling or atrophy. يجب أن تكون الساقان متماثلتين في الحجم بدون تورم أو ضمور. - If the lower legs appear asymmetric, measure the calf circumference with a nonstretchable tape measure. إذا كانت الساقان السفليتين غير متماثلتين، قم بقياس محيط الساق باستخدام شريط غير قابل للتمدد شريط قياس. - Measure at the widest point, in exactly the same place, the same number of centimeters down from the patella or other landmark. قم عند أوسع نقطة، بنفس الطريقة بالضبط المكان، نفس عدد السنتيمترات للأسفل من الركبة أو أي علامة أخرى. - Record your findings in centimeters. سجل نتائجك بالسنتيمتر.	- Diffuse bilateral edema occurs with systemic illnesses, e.g., heart failure. تورم منتشر في الجانبين يحدث مع الأمراض الجهازية، مثل فشل القلب. - Unilateral swelling indicates a local obstruction, e.g., deep venous thrombosis, lymphedema. يشير التورم من جهة واحدة إلى وجود مشكلة موضعية السداد، مثل الوريد العميق خثار الدم، وورم ليفي.
Palpate for temperature along the legs and down to the feet, comparing symmetric spots. افحص درجة الحرارة على طول الساقين و حتى القدمين، مع مقارنة الأماكن المتماثلة. - The skin should be warm and equal bilaterally. يجب أن تكون البشرة دافئة ومتساوية على الجانبين. - Bilateral cool feet may be due to environmental factors such as cool room temperature, apprehension, and cigarette smoking. قد يكون برودة القدمين بشكل ثنائي بسبب البيئة عوامل مثل برودة درجة حرارة الغرفة، القلق، وتبخين السجائر. - If there is any increase in temperature up the leg, note whether it is gradual or abrupt. إذا كان هناك أي ارتفاع في درجة الحرارة على الساق، لاحظ ما إذا كان تدريجياً أم مفاجئاً.	A unilateral cool foot or leg occurs with arterial deficit. يحدث شعور بالبرودة في قدم أو ساق واحدة مع نقص شرياني.
Palpate the inguinal lymph nodes. افحص العقد الليمفاوية الإربية. - It is not unusual to find palpable nodes that are small (1 cm or less), movable, and nontender. ليس من غير المعتاد أن تجد عقداً محسوسة التي هي صغيرة (1 سم أو أقل)، قابل للحركة، وغير مؤلمة.	Enlarged nodes, tender or fixed in area. عقد متضخمة، مؤلمة أو ثابتة المنطقة.
Palpate these peripheral arteries in both legs: femoral, popliteal, dorsalis pedis, and posterior tibial. Grade the force on the three-point scale. اضغط على هذه الشرايين الطرفية في كلا الساقين: الفخذية، خلف الركبة، الظنبوية الأمامية، والخلفية. قيم القوة على مقياس النقاط الثلاث. Femoral Pulse: نبض الفخذ: - Locate the femoral arteries just below the inguinal ligament halfway between the pubis and anterior superior iliac spines. حدد الشرايين الفخذية أسفل إلى الرباط الإربي في منتصف الطريق بين العانة والتوءات العرقية الأمامية العلوية. - To help expose the femoral area, particularly in obese people, ask the person to bend his or her knees to the side in a froglike position. لمساعدة في كشف منطقة الفخذ، خصوصاً في الأشخاص البدينين، اطلب من الشخص أن يحنى الركبتين إلى الجانب في وضع يشبه الضفدع. - Press firmly and then slowly release, noting the pulse tap under your fingertips. اضغط بقوة ثم أفرج ببطء، مع ملاحظة نبضة تلمس أطراف أصابعك. - If this pulse is weak or diminished, auscultate the site for a bruit. إذا كان هذا النبض ضعيفاً أو منخفضاً، فاستمع إليه باستخدام السماعة الموقع لوجود نفخة.	A bruit occurs with turbulent blood flow, indicating arterial occlusion. يحدث ضجيج مع الدم المضطرب تدفق، مما يشير إلى انسداد شرياني.

University of Al Bayan/ College of Nursing 2nd stage جامعة البصرة / كلية التمريض	Health assessment / Lab 9 المراجعة / تقييم الصحة / المختبر
Popliteal Pulse: النبض الابطالي الخلفي: - This is a more diffuse pulse and is hard to locate. هذه نبضة أكثر انتشاراً ومن الصعب تحديد الموقع. - With the person's leg extended but relaxed, anchor your thumbs on the knee and curl your fingers around into the fossa. مع بقاء رجل الشخص ممدودة لكن مسترخية، ثبت إبهاميك على الركبة ولف الأصابع حول الحفرة. - Press your fingers forward hard to compress the artery against the bone. اضغط بأصابعك للأمام بقوة للضغط على شريان مقابل العظم. - It is often just lateral to the medial tendon. غالباً ما يكون بجانب الوتر الوسطي. - A normal popliteal pulse is often impossible to palpate. غالباً ما يكون من المستحيل الشعور بنبض الركبة الطبيعي.	
Posterior Tibial Pulse: نبض العرقوب الخلفي: - Curve your fingers around the medial malleolus. قم بثنى أصابعك حول الكعب الداخلي. - You will feel the tapping right behind it in the groove between the malleolus and the Achilles tendon. ستشعر بالنقر خلفه مباشرة في الأخدود بين الكعب والعصب الأخيلي.	The posterior tibial pulse and the dorsalis pedis pulse are diminished or absent in PAD. النبض الابطالي الخلفي ونبض الشريان الظهري إلى القدم ضعيف أو غائب في PAD.
Dorsalis Pedis Pulse: نبض الشريان الظهري في القدم: - This requires a very light touch. هذا يحتاج لمسة خفيفة جداً. - It is normally just lateral to and parallel with the extensor tendon of the big toe. عادة ما يكون بجانب وبالتوازي مع وتر الماسطية للابهام.	
Check for pretibial edema: افحص وذمة البطنيوب: - Firmly depress the skin over the tibia or the medial malleolus for 5 seconds and release. اضغط بقوة على الجلد فوق الظنوب أو الكعب الداخلي لمدة 5 ثوانٍ ثم أتركه. - Your finger should normally leave no indentation, although a pit is commonly seen if the person has been standing all day or is pregnant. يجب أن يترك إصبعك عادة لا شيء؛ المستافة الباذخة، رغم أنه غالباً ما يرى حفرة إذا الشخص كان واقفاً طوال اليوم أو هو حامل. If pitting edema is present, grade it on this scale: إذا كان وُثمة انطباعية موجودة، قم بتصنيفها على هذا المقياس: ❖ 1+ Mild pitting; slight indentation; no perceptible swelling of the leg خفيفة الغرز؛ انغماس طفيف؛ لا تورم ملحوظ في الساق. ❖ 2+ Moderate pitting; indentation subsides rapidly 2 حفرة متوسطة؛ يخف الغرز بسرعة. ❖ 3+ Deep pitting; indentation remains for a short time; leg looks swollen 3 حفرة عميقة؛ يبقى الانبعاج لمدة لفترة قصيرة؛ يبدو أن الساق منتفخة. ❖ 4+ Very deep pitting; indentation lasts a long time; leg is grossly swollen and distorted 4 حفرة عميقة جداً؛ يستمر الانخفاض منذ وقت طويل؛ الساق منتفخة بشكل كبير و مشوهة. ❖ This scale is subjective. هذا المقياس شخصي.	- Bilateral, dependent, pitting edema occurs with heart failure and hepatic cirrhosis. وذمة ثنائية الجانب، معتمدة، غائرة يحدث مع فشل القلب والكبد. - Unilateral edema occurs with occlusion of a deep vein and lymphatic obstruction. تورم أحادي الجانب يحدث مع انسداد وريد عميق و من جانب واحد أو من جانبيين مع انسداد لمفي. - With these factors, it is "brawny" or nonpitting and feels hard to the touch. مع هذه العوامل، فهو «قوي البنية» أو غير غائر ويشعر بالصلابة لمس.
Ask the person to stand so you can assess the venous system. Note any visible, dilated, or tortuous veins. اطلب من الشخص أن يقف حتى تتمكن من تقييم الجهاز الوريدي. لاحظ أي أوردة مرئية أو متوسعة أو الجيوب الوريدية المعقدة.	Varicosities occur in the saphenous veins. تحدث الدوالي في الوريد السافن الأوردة.



Posterior tibial pulse.
نبض قصبه الساق الخلفيه. نبض الظهر القدم.



Dorsalis pedis pulse.

ADDITIONAL TECHNIQUES

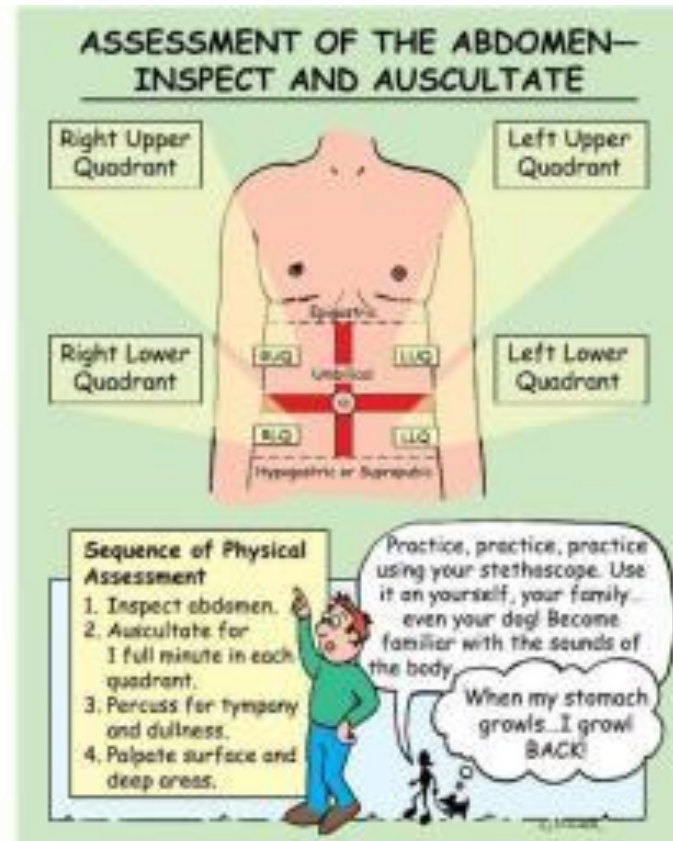
تقنيات إضافية

Normal Range of Findings	Abnormal Findings
The Doppler Ultrasonic Probe: مقياس دوبلر فوق الصوتي - Use this device to detect a weak peripheral pulse, monitor BP in infants and children, and measure a low BP or BP in a lower extremity استخدم هذا الجهاز لاكتشاف طرف ضعيف النبض، مراقبة ضغط الدم لدى الرضع والأطفال، وقياس ضغط دم منخفض أو ضغط دم أقل في الطرف - The Doppler probe magnifies pulsatile sounds from the heart and blood vessels. يقوم مسبار دوبلر بتكبير النبضات أصوات من القلب والأوعية الدموية - Place a drop of coupling gel on the end of the handheld transducer. ضع قطرة من هلام التوصيل على النهاية المجوّل اليدوي - Place the transducer over a pulse site, tilted at a 45-degree angle. ضع جهاز التحويل فوق موقع النبض، مائل بزاوية 45 درجة - Apply very light pressure; locate the pulse site by the swishing, whooshing sound. اضغط بخفة شديدة؛ حدد النبض المكان بصوت الهسهس والصفير	 استخدام جهاز دوبلر لتحديد النبض.
The Ankle-Brachial Index (ABI): مؤشر الكاحل-العضد (ABI) - The patient is lying flat with the head and heels fully supported المريض مستلقي بشكل مسطح مع الرأس و الكعب مدعوم بالكامل - Confirm no smoking within 2 hours of the measurement and allow a 5- to 10-minute rest period supine before measurement. تأكد من عدم التدخين خلال ساعتين من القياس والتمتع بالراحة لمدة 5 إلى 10 دقائق فترة راحة مستلقيا قبل القياس - Choose the correct cuff width for the arm and the ankle; width should be 40% of limb circumference. Position the ankle cuff just above the malleoli with straight wrapping. اختر عرض الكم الصحيح للذراع والكاحل؛ يجب أن تكون العرض 40% من محيط الطرف. ضع الكم فوق الكعب بكامه مستقيمة wrapping	
Use the Doppler probe for both brachial and ankle measurements: استخدم مسبار دوبلر لكل من الشريان العضدي والكاحل: - In all sites locate the pulse by Doppler, inflate the cuff 20 mm Hg above disappearance of flow signal; and then deflate slowly to detect reappearance of flow signal. في جميع المواقع حدد النبض باستخدام دوبلر، اضخم الكم 20 ملم زئبق فوق اختفاء إشارة التدفق؛ ومن ثم افرغ الهواء ببطء لاكتشاف عودة إشارة التدفق - Moving counterclockwise, measure: right arm, right PT, right DP, left PT, left DP, left arm. Calculate both ABIs using this formula: تحرك عكس اتجاه عقارب الساعة، يمين الذراع، اليمين PT، اليمين DP، اليسرى PT، اليسرى DP، اليسرى. احسب كلا مؤشري الضغط الكاحلي العضدي باستخدام هذا الصيغة: - Right ABI واجهة برمجة التطبيقات الصحيحة $= \frac{\text{Highest right ankle pressure DP or PT}}{\text{Highest arm pressure right or left}}$ أعلى ضغط ذراع: اليمين أم اليسرى - Example: $\frac{132 \text{ ankle systolic}}{124 \text{ arm systolic}} = 1.06$ or 106%, مثال: $\frac{132}{124} = 1.06$ أو 106% ضغط الدم الانقباضي للذراع = 124 أو 106% indicating no flow reduction يشير إلى عدم انخفاض التدفق - Left ABI الطرف الأيسر ABI $= \frac{\text{Highest left ankle pressure DP or PT}}{\text{Highest arm pressure right or left}}$	- AN ABI between 0.91 and 1 is borderline cardiovascular risk مؤشر ضغط الكاحل مقابل الذراع بين 0.91 و 1 يعتبر حدوديا خطر القلب والأوعية الدموية - An ABI of 0.90 or less indicates PAD. (AB) الذي يساوي 0.90 أو أقل يشير إلى مرض الشرايين المحيطية (PAD) 0.90 to 0.70—mild claudication من 0.90 إلى 0.70 — عرج خفيف 0.70 to 0.40—moderate-to severe claudication من 0.70 إلى 0.40 — معتدل إلى شديد عرج 0.40 to 0.30—severe claudication, usually with rest pain, except in the presence of diabetic neuropathy من 0.40 إلى 0.30 — عادة ما يكون مصحوبا بالعرج التشنج مع ألم الراحة، ما عدا في حالة الاعتلال العصبي السكري <0.30—ischemia, with impending loss of tissue <0.30—نقص التروية، مع فقدان وشيك لـ نسيج

جامعة البيان كلية التمريض المرحلة الثانية

مادة التقييم الصحي والفحص البدني

عملي / مختبر 10



Copyright © 2011 by Mosby, Inc., an affiliate of Elsevier Inc. All rights reserved.

Abdominal Assessment

تقييم البطن

Objectives:

الأهداف:

At the end of this lab, the student will be able to:

في نهاية هذا المختبر، سيكون الطالب قادراً على:

- Demonstrate the ability to safely & accurately complete abdominal assessment.
• إظهار القدرة على القيام بالأمور بأمان
- Demonstrate the ability to accurately document abdominal assessment data in organized manner
• إظهار القدرة على توثيق بيانات تقييم البطن بدقة في
بطريقة منظمة

Equipment needed:

المعدات المطلوبة:

- Stethoscope
• سماعة طبية
- Small ruler marked in centimeters
• مسطرة صغيرة محددة بالسنتيمترات
- Skin-marking pen
• قلم تعليم على البشرة
- Alcohol wipe (to clean endpiece)
• منديل كحولي (لتنظيف الطرف النهائي)

Preparation:

التحضير:

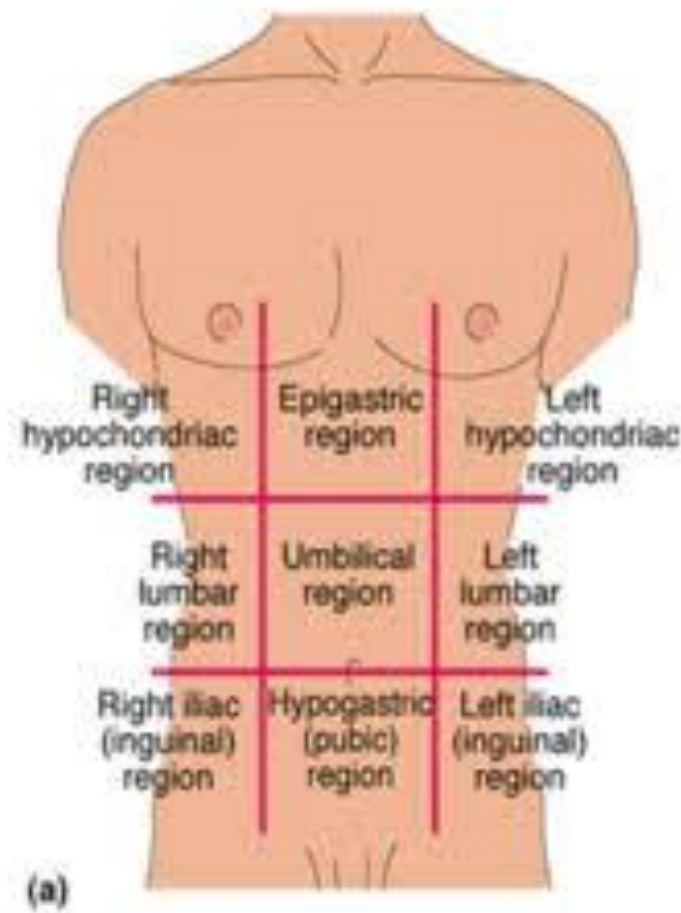
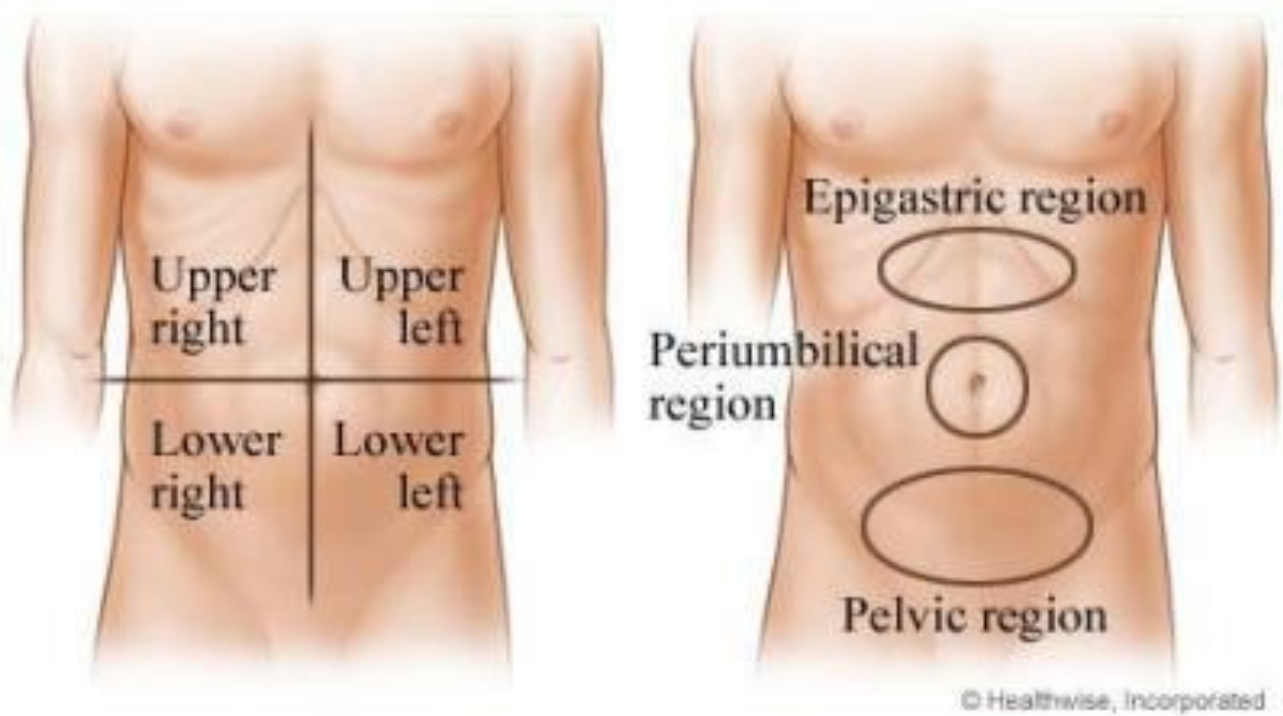
- Turn on a strong overhead light and a secondary stand light.
• شغل ضوءاً قوياً من الأعلى وضوءاً ثانوياً قائماً.
- Expose the abdomen so it is fully visible. Drape the genitalia and female breasts.
• كشف البطن ليكون مرئياً بالكامل. غط الأعضاء التناسلية والأنثى الثديين.
- The following measures enhance abdominal wall relaxation:
• التدابير التالية تعزز استرخاء جدار البطن:
- Have the person empty the bladder, saving a urine specimen if needed.
• أطلب من الشخص تفريغ المثانة، وحفظ عينة من البول إذا لزم الأمر.
- Keep the room warm.
• احرص على أن تكون الغرفة دافئة.
- Position the person supine, with the head on a pillow, knees bent or on a pillow, and arms at the sides or across the chest.
• ضع الشخص مستلقياً على ظهره، مع وضع الرأس على وسادة، والركبتين مثنيتين أو على وسادة والذراعان على الجانبين أو على الصدر.
- Keep the stethoscope endpiece warm, your hands warm, and your fingernails very short.
• حافظ على دفء قطعة السماعة في السماعة، ودفء يديك، وأظفارك قصيرة جداً.
- Examine any painful areas last to avoid any muscle guarding.
• فحص أي مناطق مؤلمة في النهاية لتجنب أي شد عضلي.
- Use distraction: breathing exercises; emotive imagery; your low, soothing voice;
• استخدم الإلهاء: تمارين التنفس؛ الصور العاطفية؛ صوتك المنخفض والمهدئ؛
and the person relating his or her abdominal
والشخص الذي يروي عن بطنه

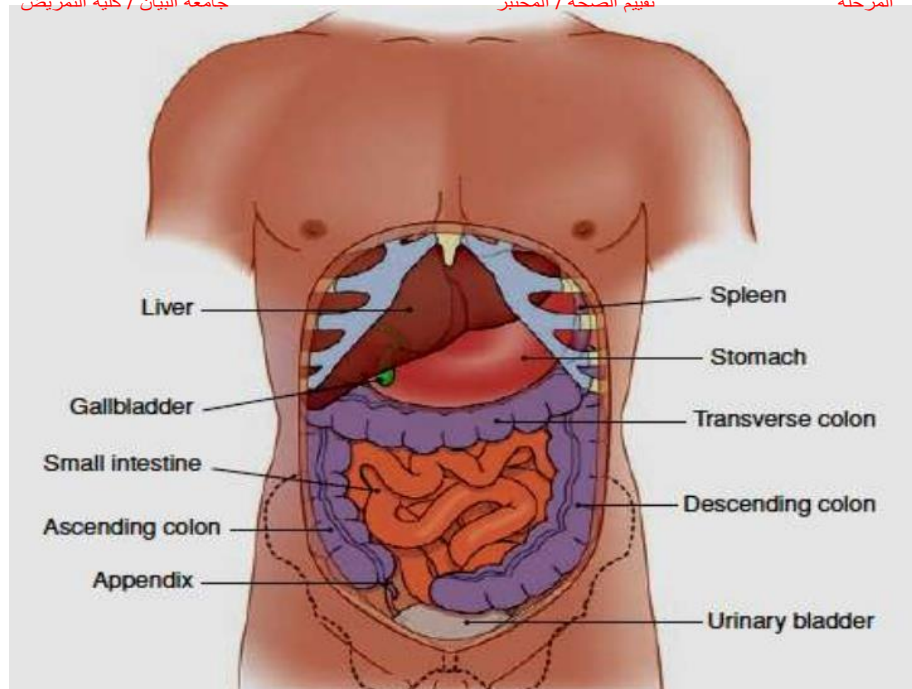
SUBJECTIVE DATA:

البيانات الشخصية:

1. Change in appetite
1. تغير في الشهية
2. Dysphagia (difficulty swallowing)
2. صعوبة البلع (مشاكل في البلع)
3. Food intolerance
3. عدم تحمل الطعام
4. Abdominal pain
4. ألم في البطن
5. Nausea/vomiting
5. غثيان/تقيؤ
6. Bowel habits
6. عادات الأمعاء
7. Rectal conditions
7. مشاكل الشرج
8. Past abdominal history (ulcer, gallbladder disease, hepatitis, appendicitis, colitis, hernia)
8. التاريخ البطني السابق (قرحة، أمراض المرارة، التهاب الكبد، التهاب الزائدة الدودية، التهاب القولون، الفتق)
9. Medications (prescription, over-the-counter, including antacids)
9. الأدوية (الوصفة الطبية، بدون وصفة، بما في ذلك مضادات الحموضة)
10. Alcohol, drug, cigarette use
10. استخدام الكحول والمخدرات والسجائر
11. Nutritional assessment (24-hour recall)
11. تقييم التغذية (استرجاع 24 ساعة)

Abdominal regions: مناطق البطن:





Underlying Structures by Abdominal Region		
<u>Right Hypochondriac Region</u> -Ascending colon -Transverse -Liver -Gall bladder -Kidney (R) -Small intestine	<u>Epigastric Region</u> -Liver -Stomach -Pancreas -Adrenal Glands (R&L) -Spleen -Transverse colon -Small intestine -Oesophagus -Kidneys (R&L)	<u>Left Hypochondriac Region</u> -Pancreas -Stomach -Spleen -Transverse colon -Descending colon -Small intestine -Liver -Kidney (L)
<u>Right Lumber Region</u> -Liver -Kidney (R) -Gall bladder -Small intestine -Ascending colon	<u>Umbilical Region</u> -Small intestine -Stomach -Transverse colon -Kidneys (R,L) -Pancreas -Ureters (R,L)	<u>Left Lumber Region</u> -Kidney (L) -Small intestine -Descending colon
<u>Right Iliac Region</u> -Appendix -Ovary (R)(F) -Fallopian tube (R)(F) -Ascending colon and caecum -Small intestine	<u>Hypogastric Region</u> -Rectum -Bladder -Sigmoid colon -Ureters (R&L) -Uterus (F) -Ovaries (R,L) (F) -Fallopian tubes (R,L)(F)	<u>Left Iliac Region</u> -Ovary (L)(F) -Fallopian tube (L)(F) -Descending colon -Sigmoid colon -Small intestine

OBJECTIVE DATA:
البيانات الموضوعية:**Procedure: Inspect Contour, Symmetry, Umbilicus, Skin, Pulsation or Movement, and Hair Distribution**
الإجراء: فحص الملامح، التناسق، السرة، الجلد، النبض أو الحركة، وتوزيع الشعر

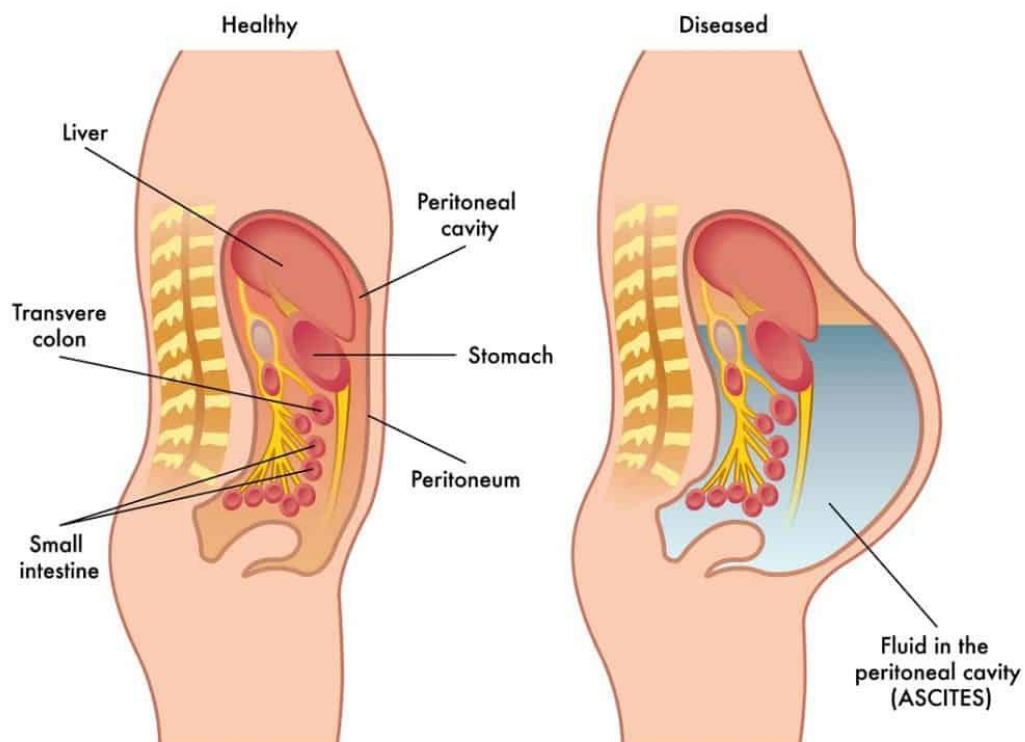
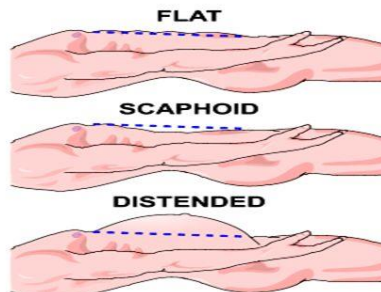
Normal Range of Findings النتائج الطبيعية للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Contour: الكونتور: Stand on the person's right side and stoop to gaze across the abdomen. قف على الجانب الأيمن للشخص و انحنى لتتأمل عبر البطن. Determine the profile from the rib margin to the pubic bone, normally flat to rounded. حدد الملف الشخصي من الضلع الهامش إلى عظم الحانة، عادة يكون مسطحا إلى مستدير.	Protuberant abdomen, abdominal distention بطن بارز، انتفاخ البطن Scaphoid abdomen occurs with malnourishment. البطن الغليصي يحدث مع سوء التغذية.
Symmetry: تماثل: Shine a light across the abdomen toward you or lengthwise across the person. سلط ضوءا على البطن باتجاهك أو بالطول عبر الشخص. The abdomen should be symmetric bilaterally. يجب أن يكون البطن متماثلا جانبا. Note any localized bulging, visible mass, or asymmetry. لاحظ أي انتفاخ موضعي أو كتلة ظاهرة أو عدم التماثل.	Bulges, masses. انتفاخات، كتل. Hernia—Protrusion of abdominal viscera through abnormal opening in muscle wall الفتق— بروز أعضاء البطن من خلال فتحة غير طبيعية في جدار العضلة.
Umbilicus: السرة: It is normally midline and inverted with no sign of discoloration, inflammation, or hernia. عادة يكون في منتصف الخط ومقلوبا مع لا يوجد أي علامة على تغير اللون أو الالتهاب، أو فتق. It becomes everted and pushed upward with pregnancy. يصبح مقلوبا ويدفع إلى الأعلى مع الحمل.	Everted with ascites or underlying mass. ميسوطة مع استسقاء أو كتلة أساسية. Deeply sunken with obesity. غارق في السمنة يشدق. Enlarged and everted with umbilical hernia. متضخم ومتنفخ مع فتق سري.
Skin: البشرة: The surface is smooth and even, with homogeneous color. السطح ناعم ومستوي، مع لون موحد.	Redness with localized inflammation; jaundice with hepatitis (shows best in natural daylight). احمرار مع التهاب موضعي؛ اليرقان مع التهاب الكبد (يظهر بشكل أفضل في ضوء النهار الطبيعي). Skin glistening and taut with ascites. البشرة تلملح وتنتفخ مع استسقاء.
Normally there are no lesions, although sometimes well-healed surgical scars are present. عادة لا توجد آفات، رغم ذلك أحيانا تكون الندوب الجراحية التي التئمت جيدا الحاضرين. If a scar is present, draw its location in the person's record, indicating the length in centimeters. إذا كان هناك ندبة، أرسم موقعها في سجل الشخص، موضح طول المدة بالسنتيمترات.	Cutaneous angiomas (spider nevi) occur with portal hypertension or liver disease. تحدث الآورام الوعائية الجلدية (العيون العنكبوتية) مع ارتفاع ضغط البوابة أو مرض الكبد. Lesions, rashes الآفات، الطفح الجلدي
Pulsation or Movement: النبض أو الحركة: Pulsations from the aorta may show beneath the skin in the epigastric area, particularly in thin people with good muscle wall relaxation. قد تظهر النبضات من الشريان الأورطي تحت الجلد في منطقة فوق المعدة، خصوصا عند الأشخاص النحيفين جيدين استرخاء جدار العضلات. Respiratory movement also shows in the abdomen, particularly in males. الحركة التنفسية تظهر أيضا في البطن، خاصة عند الذكور.	Marked pulsation of the aorta with widened pulse pressure خفقان واضح في الشريان الأورطي مع اتساع فرق النبض (e.g., hypertension, aortic insufficiency, thyrotoxicosis), and aortic aneurysm. (مثل ارتفاع ضغط الدم، قصور الأبهر، فرط نشاط الغدة الدرقية)، وتمدد الشريان الأورطي. Marked visible peristalsis, together with a distended abdomen, indicates intestinal obstruction. حركة معوية واضحة بشكل ملحوظ، مع انتفاخ البطن، يشير إلى الأمعاء المعوقة.
Demeanor: السلوك: A comfortable person is relaxed quietly on the examining table and has a benign facial expression and slow, even respirations. الشخص المريح يكون مسترخيا بهدوء على طاولة الفحص ولديه ورم حميد تعبير الوجه وبطيء، حتى التنفصات.	Restlessness and constant turning to find comfort occur with the colicky pain of gastroenteritis or bowel obstruction. الاضطراب والتقلب المستمر للبحث عن الراحة مع ألم المغص التهاب المعدة والأمعاء أو انسداد الأمعاء. Absolute stillness, resisting any movement, is demonstrated with the pain of peritonitis. اليكنية المطلقة، مقاومة أي حركة، يظهر ذلك بألم التهاب الصفاق. Knees flexed up; facial grimacing; and rapid, uneven respirations also indicate pain. الركبت مثنية للأعلى؛ وتعبير الوجه متجهم؛ و التنفس السريع وغير المنتظم يشير أيضا إلى الألم.

inspection

1. Contour and symmetry :

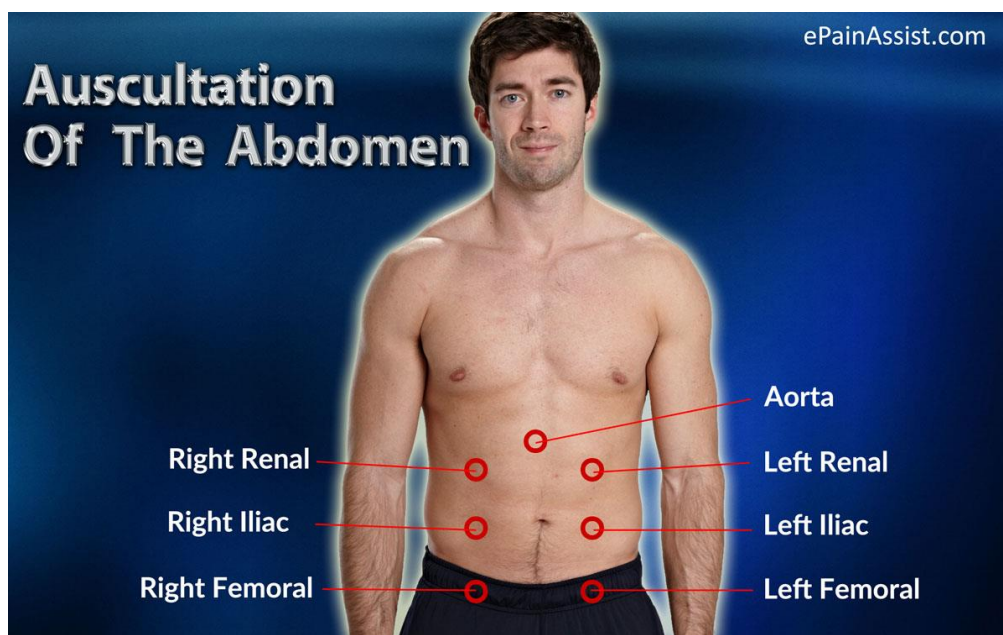


Flat abdomen (قابلوني اذا شفتوها)



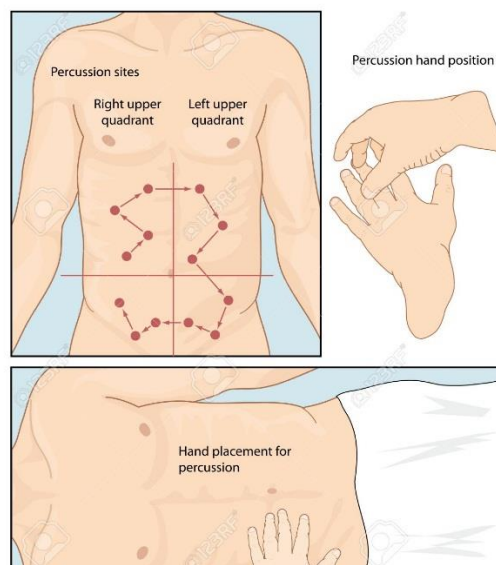
Auscultate Bowel Sounds and Vascular Sounds:

Normal Range of Findings	Abnormal Findings
Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج - Auscultation is done next because percussion and palpation can increase peristalsis, which would give a false interpretation of bowel sounds. يتم الاستماع باستخدام السماعة بعد ذلك بسبب الطرق والتحسس يمكن أن يزيد من الحركة الدودية، والتي قد يعطي تفسيراً خاطئاً للأصوات للأمعاء. - Use the diaphragm endpiece and hold the stethoscope lightly against the skin. استخدم طرف الحجاب الحاجز وامسك به وضع السماعة الطبية بخفة على الجلد. - Begin in the right lower quadrant (RLQ) at the ileocecal valve area because bowel sounds normally are always present here. ابداً في الربع السفلي الأيمن (RLQ) عند منطقة الصمام اللانقي الأعمري بسبب أصوات الأمعاء عادة ما يكونون موجودين هنا دائماً.	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية Two distinct patterns of abnormal bowel sounds may occur: نمطين مختلفين من الشذوذ قد تحدث أصوات الأمعاء:
Bowel Sounds: أصوات الأمعاء: - Note the character and frequency, normally highpitched, gurgling, cascading sounds occurring irregularly, anywhere from 5 to 30 times per minute. لاحظ الحرف والتكرار، بشكل عادي highpitched, gurgling, cascading sounds أصوات حادة، متموجة، متسلسلة، تحدث بشكل غير منتظم، في أي مكان من 5 إلى 30 مرة في الدقيقة. - Do not bother to count them. لا تهتم بعددها. - Judge if they are present, hypoactive, or hyperactive. احكم إذا كانوا حاضرين، منخفضي النشاط أو فرط النشاط. - You must listen for 5 minutes by your watch before deciding that bowel sounds are completely absent. يجب أن تستمع لمدة 5 دقائق حسب ساعتك قبل أن تقرر أن أصوات الأمعاء هي غائبة تماماً.	Hyperactive sounds are loud, high-pitched, rushing, tinkling sounds that signal increased motility. They occur with early mechanical bowel obstruction, gastroenteritis, brisk diarrhea, laxative use, and subsiding paralytic ileus. الأصوات المفرطة النشاط تكون عالية، مرتفعة، أصوات جادة، متسارعة، ورنانة التي تشير إلى زيادة الحركة. تحدث مع الأمعاء الميكانيكية المبكرة obstruction, gastroenteritis, brisk diarrhea, laxative use, and subsiding paralytic ileus. شلل معوي. Hypoactive or absent sounds: أصوات منخفضة أو غائبة: follow abdominal surgery or occur with inflammation of the peritoneum or from late bowel obstruction يتبع جراحة البطن أو يحدث مع التهاب الصفاق أو من انسداد الأمعاء في المراحل المتأخرة
Vascular Sounds: أصوات الأوعية الدموية: - Note the presence of any vascular sounds or bruits. لاحظ وجود أي أصوات وعائية أو أصوات. - Using firmer pressure, listen over the aorta, renal arteries, and iliac and femoral arteries, especially in people with hypertension. باستخدام ضغط أقوى، استمع فوق الشريان الأورطي، الشرايين الكلوية، والشرايين الحرقفية والفخذية، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. - Usually there is no such sound. عادة لا يوجد مثل هذا الصوت.	- Note location, pitch, and timing of a vascular sound. سجل موقع النغمة ودرجة الصوت، وتوقيتها. - A systolic bruit is a pulsatile, blowing sound and occurs with occlusion of an artery. صوت الأوعية الدموية الطنين الانقباضي هو نابض، صوت نفخ ويحدث مع انسداد شرياني. - Venous hum and peritoneal friction rub are rare الطنين الوريدي واحتكاك الصفاق النفرات نادر.



Percuss General Tympany, Liver Span, and Splenic Dullness

Normal Range of Findings	Abnormal Findings
General Tympany: الانتفاخ العام: - Percuss lightly in all four quadrants. - Tympany should predominate because air in the intestines rises to the surface when the person is supine.	Dullness occurs over a distended bladder, adipose tissue, fluid, or a mass. يحدث الخمول فوق متسع المثانة، النسيج الدهني، السوائل، أو كتلة. Hyperresonance is present with gaseous distention. الرنين المفرط موجود مع انتفاخ غازي.
Liver Span. Measure the height of the liver in the right midclavicular line. Begin in the area of lung resonance and percuss down the interspaces until the sound changes to a dull quality. Mark the spot, usually in the 5th intercostal space. Then find abdominal tympany and percuss up in the midclavicular line. Mark where the sound changes from tympany to a dull sound, normally at the right costal margin.	
Measure the distance between the two marks; the normal liver span in the adult ranges from 6 to 12 cm. Taller people have longer livers. Males also have a larger liver span than females of the same height. Overall the mean liver span is 10.5 cm for males and 7 cm for females.	An enlarged liver span indicates liver enlargement or hepatomegaly. Accurate detection of liver borders is confused by dullness above the 5th intercostal space, which occurs with lung disease, e.g., pleural effusion or consolidation; lower border of dullness pushed up with ascites or pregnancy; gas distention in colon, which obscures lower border.
Splenic Dullness: خمول الطحال: Locate it by percussing a dull note from the 9th to the 11th intercostal spaces just behind the left midaxillary line. The area of splenic dullness is normally not wider than 7 cm in adults and should not encroach on the normal tympany over the gastric air bubble.	A dull note forward of the midaxillary line indicates enlargement of the spleen, as occurs with mononucleosis, trauma, and infection.



Palpate Surface and Deep Areas, Liver Edge, Spleen, and Kidneys

تحسس المناطق السطحية والعميقة، حافة الكبد، الطحال، والكلى

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Light and Deep Palpation اللمس الخفيف والعميق	
- Begin with light palpation. أبدأ بفحص لطيف باللمس. - With the four fingers close together, depress the skin about 1 cm. مع تقريب الأصابع الأربعة معاً، اضغط على الجلد حوالي 1 سم. - Make a gentle rotary motion, lift the fingers (do not drag them), and move clockwise. قم بحركة دائرية لطيفة، ارفع الأصابع (أفعل لا تسحبهم)، وتحرك باتجاه عقارب الساعة.	- Muscle guarding. تشنج العضلات. - Rigidity. الجمود. - Large masses. كتل كبيرة. - Tenderness. الرقّة.
- As you circle the abdomen, discriminate between voluntary muscle guarding and involuntary rigidity. أثناء تحريكك حول البطن، فرق بين التشنج العضلي الطوعي وغير الطوعي. Voluntary guarding occurs when the person is cold, tense, or ticklish. It is bilateral, and the muscles relax slightly during exhalation. يحدث التحمّية الطوعية عندما يكون الشخص بارداً، متوتراً، أو داغض. إنه ثنائي الجانب، وتسترخي العضلات قليلاً أثناء الزفير. - Use relaxation measures to try to eliminate this type of guarding or it will interfere with deep palpation. If rigidity persists, it probably is involuntary. استخدم طرق الاسترخاء لمحاولة التخلص من هذا نوع من الحماية أو سيتداخل مع العمق الممس. إذا استمر الصلابة، فمن المحتمل أن تكون لا إرادية.	- Involuntary rigidity is a constant, board like hardness of the muscles. التصلب اللاإرادي مستمر صلابية مثل خشونة العضلات. - It is a protective mechanism accompanying acute inflammation of the peritoneum. إنه آلية حماية الالتهاب الحاد المصاحب من الصفاق. - It may be unilateral, and the same area usually becomes painful when the person increases intraabdominal pressure by attempting a sit-up. قد يكون أحادي الجانب، وهو نفسه عادة ما تصبح المنطقة مؤلمة عندما الشخص يزيد الضغط داخل البطن الصنط بمحاولة القيام بتمرين البطن.
- Now perform deep palpation, pushing down about 5 to 8 cm (2 to 3 inches). الآن قم بالضغط العميق، اضغط لأسفل حوالي 5 إلى 8 سم (2 إلى 3 بوصات). - Moving clockwise, explore the entire abdomen. تحرك في اتجاه عقارب الساعة، واستكشف كامل البطن.	
- To overcome the resistance of a very large or obese abdomen, use a bimanual technique. لتجاوز مقاومة كبيرة جداً أو البطن البدنية، استخدم تقنية اليدين معاً. - Place your hands on top of one another. ضع يديك فوق بعضهما. - The top hand pushes; the bottom hand is relaxed and can concentrate on the sense of palpation. اليد العليا تدفع؛ اليد السفلى مسترخية ويمكنه التركيز على إحساس اللمس. - With either technique, note the location, size, consistency, and mobility of any palpable organs and the presence of any abnormal enlargement, tenderness, or masses. مع أي من الطريقتين، لاحظ الموقع والحجم، الصلابة والحركة لأي شيء ملموس الأعضاء، وجود أي تضوّد تورم، أو حبياسية، أو كتل. - Remember that some structures are normally palpable. تذكر أن بعض الهياكل تكون عادة ملموس.	
- Normally there is mild tenderness when palpating the sigmoid colon. عادة يكون هناك حساسية خفيفة عند التحسس القولون السيني. - Any other tenderness should be investigated. يجب فحص أي حساسية أخرى.	Tenderness occurs with local inflammation; with inflammation of the peritoneum or underlying organ; and with an enlarged organ whose capsule is stretched. يحدث الشعور بالحنان مع المنطقة المحلية التهاب؛ مع الالتهاب من الغشاء البطني أو ما تحته عضو؛ ومع عضو متضخم الذي كبسولته مشدودة.
If you identify a mass, first distinguish it from a normally palpable structure or an enlarged organ. إذا تعرفت على كتلة، فابداً بتمييزها عن هيكل يمكن لمسه عادة أو عضو متضخم. Then note its: ثم لاحظ ذلك: Location الموقع Size الحجم Shape شكل Consistency (soft, firm, hard) القوام (ناعم، متماسك، صلب) Surface (smooth, nodular) السطح (أملس، عقدي) Mobility (including movement with respirations) الحركة (بما في ذلك الحركة مع التنفّسات) Pulsatility النبض Tenderness حنان	

University of Al Bayan/ College of Nursing جامعة البصرة / كلية التمريض		2 nd stage تقييم الصحة / المختبر	Health assessment / Lab 10 المرجعة
Liver: الكبد:			
- Place your left hand under the person's back, parallel to the 11th and 12th ribs, and lift up to support the abdominal contents. ضع يديك اليسرى تحت ظهر الشخص، مواز للضلعين الحادي عشر والثاني عشر، وارفع للأعلى إلى دعم محتويات البطن. - Place your right hand on the right upper quadrant (RUQ), with fingers parallel to the midline. ضع يديك اليمنى على الربع العلوي الأيمن (RUQ)، مع وضع الأصابع موازية للخط الأوسط. - Push deeply down and under the right costal margin. ادفع بعمق للأسفل وتحت الضلع اليميني هامش.		- Except with a depressed diaphragm, a liver palpated more than 1 to 2 cm below the right costal margin is considered enlarged. إلا مع شخص مكتئب الحجاب الحاجز، كبد محسوس أكثر من 1 إلى 2 سم أسفل الجهة اليمنى يعتبر حافة القفص الصدري ممتد. - Record the number of cm it descends and note its consistency (hard, nodular) and any tenderness. سجل عدد السنتيمترات ينزل و يلاحظ قوامه (صلب، عقدي) وأي ألم عند التماس.	
- Ask the person to take a deep breath. It is normal to feel the edge of the liver bump your fingertips as the diaphragm pushes it down during inhalation. اطلب من الشخص أن يأخذ نفسا عميقا. هذا طبيعي لتشعر بحافة الكبد باطراف أصابعك بينما يضغط الحجاب الحاجز للأسفل أثناء استنشاق. - It feels like a firm, regular ridge. يبدو وكأنه حافة صلبة ومنظمة. - The liver is often not palpable, and you may feel nothing firm. الكبد غالبا لا يمكن لمسه، وقد تشعر بـ شيء ثابت.		The liver edge is often palpated below the right costal margin in people with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) because their distended lungs and depressed diaphragm push the liver lower. غالبا ما يتم جس حافة الكبد أسفل الحد الأيمن للأضلاع في الأشخاص المصابون بالانسداد الرئوي المزمن (COPD) لأن رئتهم المتضخمة و الحجاب الحاجز المنخفض يدفع الكبد الأسفل.	
Spleen: الطحال:			
- Normally the spleen is not palpable and must be enlarged 3 times its normal size to be felt. عادة الطحال غير ملموس ويجب أن يكون تكبر ثلاث مرات عن حجمه الطبيعي لتكون محسوسة. - Reach your left hand over the abdomen and behind the left side at the 11th and 12th ribs. مد يديك اليسرى فوق البطن و خلف الجانب الأيسر عند الضلع الحادية عشرة والثانية عشرة. - Lift up for support. Place your right hand obliquely on the LUQ with the fingers pointing toward the left axilla and just inferior to the rib margin. Push your hand deeply down and under the left costal margin and ask the person to take a deep breath. ارفع للمساعدة. ضع يديك اليمنى بزاوية على الجزء العلوي الأيمن من البطن مع توجيه الأصابع نحو الإبط الأيسر وأسفل الضلع مباشرة. الهامش. ادفع يديك بعمق للأسفل وتحت الهامش الضلعي الأيسر واطلب من الشخص أن يأخذ نفسا عميقا. - You should feel nothing firm. When enlarged, the spleen slides out and bumps your fingertips. يجب ألا تشعر بأي شيء صلب. عندما يتضخم، الطحال يخرج ويطرق أطراف أصابعك.		- The spleen enlarges with mononucleosis and trauma الطحال يكبر مع التهاب الغدة الوحيدة والصدمة - Refer the person with an enlarged spleen; do not continue to palpate. An enlarged spleen is friable and can rupture easily with over palpation. حول الشخص الذي لديه تضخم الطحال؛ لا تستمر في الجس. الطحال المتضخم هش و يمكن أن يتمزق بسهولة عند الإفراط في الجس. - Describe the number of cm it extends below the left costal margin. صف عدد السنتيمترات له يمتد أسفل الضلع الأيسر هامش.	
Kidneys: الكلى:			
- Search for the right kidney by placing your hands together in a "duckbill" position at the person's right flank. ابحث عن الكلى اليمنى بوضع يديك معا في وضعية "منقار البط" عند الشخص الجانب الأيمن. - Press your two hands firmly and ask the person to take a deep breath. With most people, you feel no change. اضغط بيديك الاثنتين بقوة واطلب من الشخص أن يأخذ نفسا عميقا. مع معظم الناس، لن تشعر بأي شيء تغيير. - Occasionally you may feel the lower pole of the right kidney as a round, smooth mass slide between your fingers. Either condition is normal. أحيانا قد تشعر بالقطب السفلي لـ الكلى اليمنى كتلة مستديرة وناعمة تنزلق بين أصابعك. أي حالة من الحالتين طبيعية. - The left kidney sits 1 cm higher than the right kidney and normally is not palpable. الكلى اليسرى تقع أعلى من اليمنى بمقدار 1 سم الكلى عادة غير ملموسة.		- Enlarged kidney. كلى متضخمة - Kidney mass. كتلة في الكلى.	
Aorta: الشريان الأورطي:			
- Using your opposing thumb and fingers, palpate the aortic pulsation in the upper abdomen slightly to the left of midline. باستخدام إبهامك وأصابعك المقابلة، قم بالتدحرج نبض الأورطى في الجزء العلوي من البطن بالقرب من خط منتصف. - It is normally 2.5 to 4 cm wide in adults and pulsates in an anterior direction. إلى يسار خط منتصف. عادة يكون عرضه من 2.5 إلى 4 سم لدى البالغين و يمتد في اتجاه أمامي.		- Widened aorta with aneurysm. توسعت الأورطى مع وجود تمدد وعائي. - Prominent lateral pulsation with aortic aneurysm نبض جانبي بارز مع تمدد الشريان الأورطى	
Costovertebral Angle Tenderness: الم زاوية الفقرة الصدري			
- Place one hand over the 12th rib at the costovertebral angle on the back. ضع يدا واحدة فوق الضلع الثاني عشر عند المفصل الحديبي الفقري الزاوية على الخلف. - Thump that hand with the ulnar edge of your other fist. اضغط على تلك اليد بحافة كف يديك الأخرى قبضة. - The person normally feels a thud but no pain. يشعر الشخص عادة بطرقعة لكن بدون ألم.		Sharp pain occurs with inflammation of the kidney or paranephric area. يحدث ألم حاد مع التهاب الكلى أو المنطقة حول الكلى	

Gastro-intestinal examination

Palpation

Palpate the abdomen using light (depress approx 1.5cm) then deep (depress approx 5 – 7.5cm) palpation. You are assessing the size, shape, position and tenderness of major organs and to detect masses and fluid. The abdomen should be soft and non-tender as you palpate all four quadrants. Note any lumps or bumps, masses and areas of tenderness or resistance.



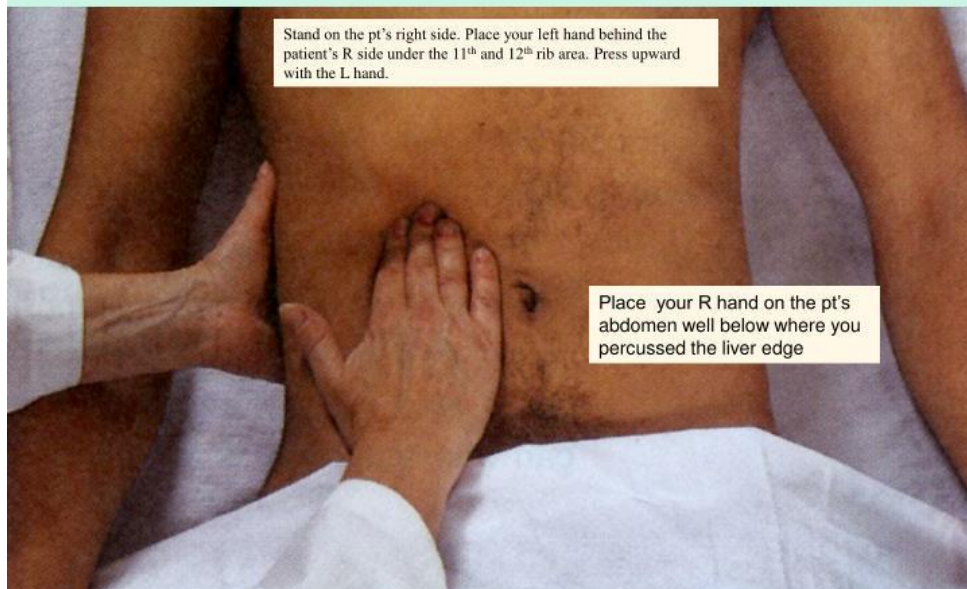
Light palpation



Deep palpation

bettertogether

Palpation: Liver



Palpation of Kidneys



Special Procedures:

إجراءات خاصة :

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Rebound Tenderness: اختبار الارتداد:	
- Choose a site away from the painful area. اختر موقعاً بعيداً عن المنطقة المؤلمة. - Hold your hand 90 degrees or perpendicular to the abdomen. Push down slowly and deeply; then lift up quickly. امسك يدك بزاوية 90 درجة أو بشكل عمودي على البطن. اضغط ببطء وعمق؛ ثم ارفع بسرعة. - This makes structures that are indented by palpation rebound suddenly. هذا يصنع هياكل مزاحة بمقدار الارتداد عند الجس فجأة. - A normal, or negative, response is absence of pain on release of pressure. الاستجابة الطبيعية، أو السلبية، هي غياب الألم عند رفع الضغط. - Perform this test at the end of the examination because it can cause severe pain and muscle rigidity. قم بإجراء هذا الاختبار في نهاية الامتحان لأنه يمكن أن يسبب ألماً شديداً وتيبس العضلات.	- Pain on release of pressure confirms rebound tenderness, which is a reliable sign of peritoneal inflammation. الألم عند رفع الضغط يؤكد ألم الارتداد، وهو علامة موثوقة للبريتونيوم الالتهاب. - Cough tenderness localized to a specific spot also signals peritoneal irritation. حساسية السعال محلياً في النقطة المحددة تشير أيضاً إلى التهاب البطنى الانزعاج.
Fluid Wave for Ascites: موجة السائل للاستسقاء:	
- Place the ulnar edge of another examiner's hand or the patient's own hand firmly on the abdomen midline. ضع الحافة الزندية ليد فاحص آخر أو وضع يد المريض بنفسه بثبات على البطن الخط الوسطى. - Place your left hand on the person's right flank. With your right hand reach across the abdomen and give the left flank a firm strike. ضع يدك اليسرى على جانب الشخص الأيمن. بيدك اليمنى، مدها عبر البطن وضرب الجهة اليسرى بقوة. - If ascites is present, the blow will generate a fluid wave through the abdomen and you will feel a distinct tap on your left hand. إذا كان هناك استسقاء، فإن الضربة ستؤدي إلى موجة سائلة تمر عبر البطن وستشعر بلحظة مميزة على يدك اليسرى. - If the abdomen is distended from gas or adipose tissue, you will feel no change. إذا كان البطن منتفخاً من الغاز أو الدهون، لن تشعر بأي تغيير.	- Ascites occurs with heart failure, portal hypertension, cirrhosis, hepatitis, pancreatitis, and cancer. يحدث الاستسقاء مع فشل القلب، ارتفاع ضغط البواب، تليف الكبد، التهاب الكبد، التهاب البنكرياس، والسرطان. - A positive fluid wave test occurs with large amounts of ascitic fluid. يحدث اختبار موجة السوائل الإيجابي مع كميات كبيرة من السائل البطنى.

Assessment of the Abdomen

Rebound Tenderness

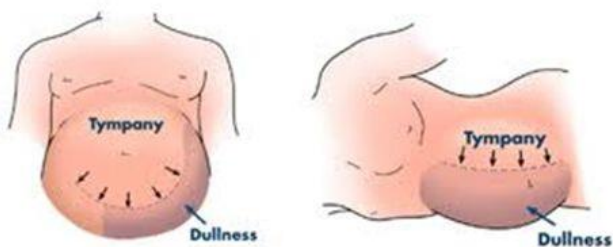


- Apply firm pressure for several seconds to the abdomen with hand at right angles and fingers extended
- Quickly release the pressure
- Test away from site where pain is initially determined

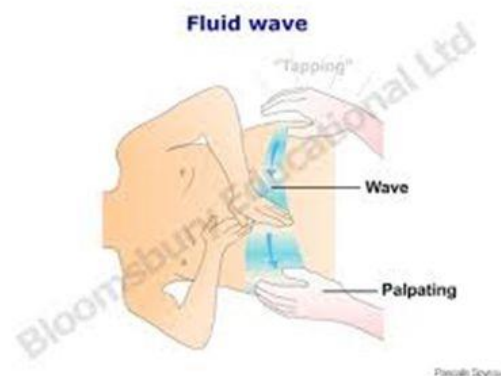
46

Tests for Ascites

Shifting Dullness



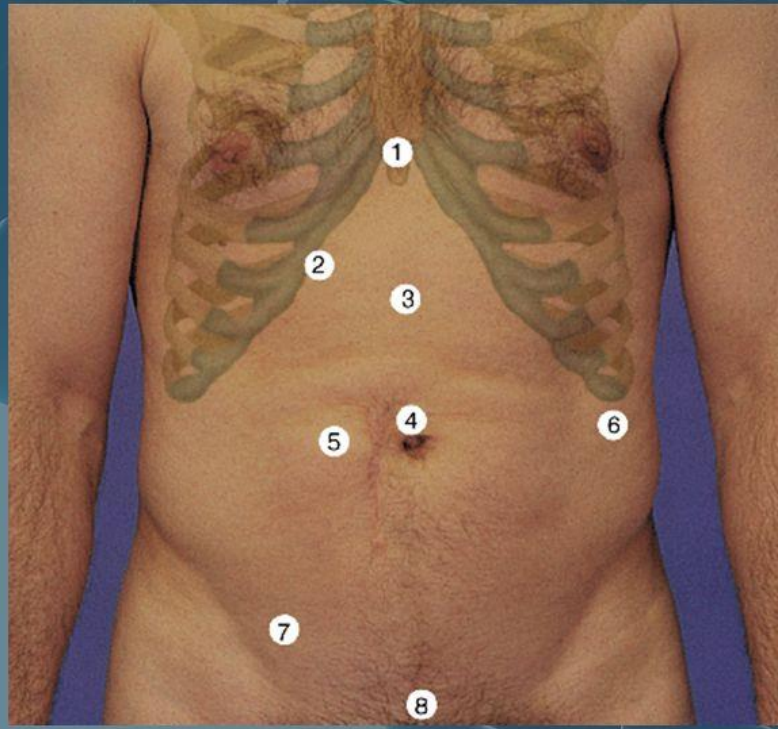
Fluid Wave





Abdominal Assessment Landmarks

1. Xiphoid process
2. Costal margin
3. Abdominal midline
4. Umbilicus
5. Rectus Abdominis Muscle
6. Anterior Superior Iliac Spine
7. Inguinal Ligament
8. Symphysis Pubis



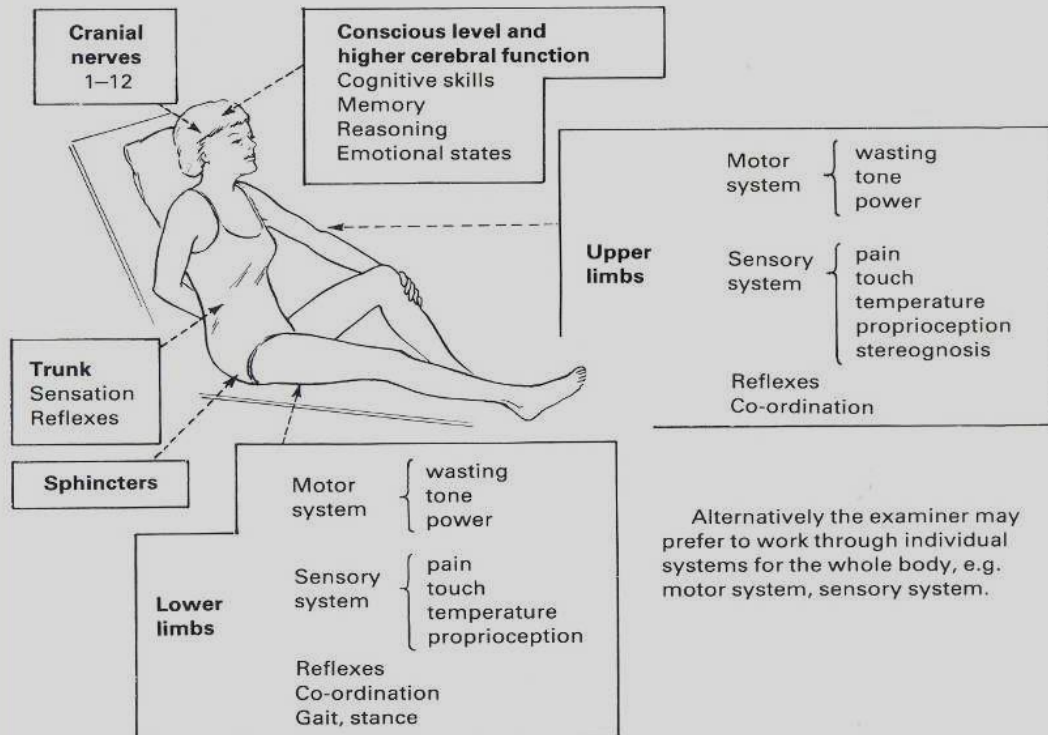
جامعة البيان كلية التمريض المرحلة الثانية

مادة التقييم الصحي والفحص البدني

عملي / مختبر 11

Nervous System Examination

CNS examination is described systematically from the head downwards and includes:



Neurological System Assessment

تقييم الجهاز العصبي

Objectives:

الأهداف:

At the end of this lab, the student will be able to:

في نهاية هذا المختبر، سيكون الطالب قادراً على:

- Demonstrate the ability to safely & accurately complete neurological assessment.
• إظهار القدرة على القيام بالأمر بأمان
- Demonstrate the ability to accurately document neurological assessment data in organized manner.
• إظهار القدرة على توثيق بيانات التقييم العصبي بدقة في طريقة منظمة

Equipment needed:

المعدات المطلوبة:

- Penlight
• مصباح يدوي صغير
- Tongue blade
• شفرة لسان
- Cotton swab
• عودان قطنية
- Cotton ball
• قطن
- Tuning fork (128 or 256 Hz)
• شوكة رنين (128 أو 256 هرتز)
- Percussion hammer
• مطرقة الطرق

Preparation:

التحضير:

- Perform a **screening** neurologic examination (items identified in following sections) on seemingly well people who have no significant subjective findings from the history.
• إجراء فحص عصبي مبدئي (العناصر المحددة في التالي أقسام) عن الأشخاص الذين يبدوون بصحة جيدة ولا لديهم أي نتائج ذاتية مهمة من التاريخ.
- Perform a **neurologic recheck** examination on people with demonstrated neurologic deficits who require periodic assessments (e.g., hospitalized people or those in extended care).
• قم بإجراء فحص متابعة عصبي على الأشخاص الذين تم إظهار القصور العصبي الذين يحتاجون إلى تقييمات دورية (مثل الأشخاص المحتجزين في المستشفى أو أولئك في الرعاية الممتدة)

SUBJECTIVE DATA:

البيانات الشخصية:

1. Headache (unusually frequent or severe)
1. صداع (متكرر أو شديد بشكل غير عادي)
2. Head injury
2. إصابة في الرأس
3. Dizziness (feeling light-headed or faint)/vertigo (feeling a rotational spinning)
3. دوخة (الشعور بالدوار أو الإغماء)/الدوار المركزي (الشعور بالدوران)
4. Seizures
4. النوبات
5. Tremors
5. اهتزازات
6. Weakness or incoordination
6. ضعف أو فقدان التنسيق
7. Numbness or tingling
7. خدر أو شعور بوخز
8. Difficulty swallowing
8. صعوبة في البلع
9. Difficulty speaking
9. صعوبة في الكلام
10. Significant neurologic past history (stroke, spinal cord injury, meningitis or encephalitis, congenital defect, alcoholism)
10. تاريخ عصبي مهم في الماضي (مثل السكتة الدماغية، إصابة الحبل الشوكي، التهاب السحايا أو التهاب الدماغ، العيب الخلقي، إدمان الكحول)

OBJECTIVE DATA:
البيانات الموضوعية:**Include examining the followings;**
يشمل فحص الأمور التالية:

- ❖ **Mental Status:** Assess level of consciousness (as described in the printed pages)
□ الحالة العقلية: تقييم مستوى الوعي (كما هو موصى به في الطباعة)
- ❖ **Cranial Nerves**
□ الأعصاب القحفية
- ❖ **Motor System**
□ الجهاز الحركي
- ❖ **Reflexes**
□ الانعكاسات

Procedure: Test Cranial Nerves

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Cranial Nerve I—Olfactory Nerve العصب القحفي الأول — العصب الشمي	
- Test for identifying scent (e.g. coffee) by holding a scent under one nostril while closing eyes and the other nostril - اختبار للتعرف على الرائحة (مثل القهوة) بواسطة إمساك الرائحة تحت إحدى أنفك بينما أغلق العينين والأنف الأخرى بإصبعك	
Cranial Nerve II—Optic Nerve العصب القحفي الثاني — العصب البصري	
- Test visual acuity and test visual fields by confrontation. When indicated, use the ophthalmoscope to examine the ocular fundus - اختبار حدة البصر وفحص مجالات الرؤية بالمواجهة. عند اللزوم، استخدم المنظار العيني لفحص قاع العين	- Visual loss - فقدان البصر - Papilledema with increased intracranial pressure; optic atrophy - وذمة حليمية العصب البصري مع زيادة ضغط داخل الجمجمة؛ ضمور العصب البصري
Cranial Nerves III, IV, and VI—Oculomotor, Trochlear, and Abducens Nerves الأعصاب القحفية III و IV و VI — العصب المحرك للعين، العصب الترقلي، والعصب البعدي	
- Palpebral fissures are usually equal in width or nearly so. - شقوف الجفون عادة تكون متساوية في العرض أو قريب منه.	- Ptosis (drooping) with myasthenia gravis, dysfunction of cranial nerve III, or Horner syndrome - تدلي الجفن (هبوطه) مع الوهن العضلي الوبيل خلل في العصب القحفي الثالث، أو هورنر متلازمة
- For CN III, check pupils for size, regularity, equality, light reaction, and accommodation. - لفحص العصب القحفي الثالث، تحقق من حجم الحدقتين، الانتظام، المساواة، التفاعل الضوئي، و التكيف. - The pupils are normally equal, round, react to light promptly, and react to accommodation (PERRLA). - عادة تكون بؤبؤ العين متساويًا ومستديرًا، تتفاعل مع الضوء بسرعة، وتتكيف مع التكيف (PERRLA).	- Unequal size, constricted pupils, dilated pupils, or no response to light. - حجم غير متساو، حدقتان متضيقتان، متوسعة التلاميذ، أو عدم الاستجابة للضوء.
- Assess extraocular movements by the cardinal positions of gaze - تقييم حركات العين الخارجية بواسطة المواضع الأساسية للنظر	- Deviated gaze or limited movement. - نظرة منحرفة أو حركة محدودة.
- Nystagmus is a back-and-forth oscillation of the eyes. Endpoint Nystagmus, a few beats of horizontal Nystagmus at extreme lateral gaze, occurs normally. - الزلازلة هي حركة ذهابًا وإيابًا رجفة العينين. النقطة النهائية الزلازلة، بعض الدقات الأفقية زلازلة العين عند النظر لأقصى الجنب يحدث بشكل طبيعي. - Assess any other Nystagmus carefully. - قيم أي زلازلة عين أخرى بعناية.	
Cranial Nerve V—Trigeminal Nerve العصب القحفي الخامس — العصب الثلاثي التوائم	
Motor Function الوظيفة الحركية - Palpate the temporal and masseter muscles as the person clenches the teeth. - لمس العضلات الزمنية والكتلية عندما يعض الشخص أسنانه. - Muscles should feel equally strong on both sides. - يجب أن تشعر أن العضلات قوية بنفس القدر على الجانبين. - Try to separate the jaws by pushing down on the chin; normally you cannot. - حاول فصل الفكين بالضغط أسفل الذقن؛ عادة لا يمكنك ذلك.	- Decreased strength on one or both sides. - انخفاض القوة في جانب واحد أو كلا الجانبين. - Pain with clenching of teeth. - ألم عند شد الأسنان.

University of Al Bayan/ College of Nursing جامعة البصرة / كلية التمريض Sensory Function الوظيفة الحسية - With the person's eyes closed, test light touch sensation by touching a cotton wisp to these designated areas on the person's face: forehead, cheeks, and chin. مع غلق عيني الشخص، اختبار الضوء إحساس اللمس بلمس القطن خيط إلى هذه المناطق المخصصة على وجه الشخص: الجبهة، الخدين، و chin. - Ask the person to say "now" whenever the touch is felt. اطلب من الشخص أن يقول "الآن" كلما يشعر باللمس.	2nd stage تقييم الصحة / المختبر Health assessment / Lab 11 المراجعة Decreased or unequal sensation. شعور منخفض أو غير متساو.
Motor Function الوظيفة الحركية Note mobility and facial symmetry as the person responds to these requests: smile, frown, close eyes tightly (against your attempt to open them), lift eyebrows, show teeth, and puff cheeks. لاحظ الحركة وتناظر الوجه باعتبارها الشخص يرد على هذه الطلبات: ابتسمة، التجهم، اغمض عينيك بإحكام (ضدك حاول فتحها)، ارفع الحاجبين، اظهر أسنانك، و انتفخ خديك.	Cranial Nerve VII—Facial Nerve العصب القحفي السابع - للعصب الوجهي Muscle weakness shows by loss of the nasolabial fold, drooping of one side of the face, lower eyelid sagging, and escape of air from only one puffed cheek when both are pressed in. ضعف العضلات يظهر بفقدان ثنية أنفية شفوية، ترهل جانب واحد من الوجه، ترهل الجفن السفلي، وهروب الهواء من خد متنفخ واحد فقط بينما كلاهما مدروس بعناية.
Cranial Nerve VIII—Acoustic العصب القحفي الثامن - السعوي Test hearing by patient's ability to hear normal conversation and the whispered voice test. اختبار السمع من خلال قدرة المريض على السمع المحادثة العادية والهمس المختار الصوت	Cranial Nerve VIII—Acoustic العصب القحفي الثامن - السعوي
Cranial Nerves IX and X—Glossopharyngeal and Vagus العصب القحفي التاسع والعشر - العصب البلعومي البلعومي والعصب الوعائي Depress with a tongue blade and note movement as the person says "ahh"; uvula and soft palate should rise in the midline, and tonsillar pillars move medially. اضغط باستخدام شريحة اللسان ودرن الملاحظات الحركة عندما يقول الشخص "أوه"؛ يجب أن يرتفع النخاع والحنك إلى الوسط، والخط الأوسط، وأعمدة اللوزتين تتحرك من الناحية الوسطية.	Cranial Nerves IX and X—Glossopharyngeal and Vagus العصب القحفي التاسع والعشر - العصب البلعومي البلعومي والعصب الوعائي Absence or asymmetry of soft palate movement may occur after a stroke; swallowing then increases risk of aspiration. غياب أو عدم تماثل الحنك الرخو قد يحدث تحرك بعد السكتة الدماغية؛ البلع بعد ذلك يزيد من خطر الاستنشاق.
Cranial Nerve XI—Spinal Accessory العصب القحفي الحادي عشر - العصب القحفي الحادي عشر Check strength of neck muscles by asking person to turn head forcibly against your resistance at side of chin and to shrug shoulders against resistance. Both sides should feel equally strong. تحقق من قوة عضلات الرقبة عن طريق طلب من الشخص أن يدير رأسه بالقوة ضد مقاومتك عند جانب الدفن ولا ترتخ عند مواجهة المقاومة. يجب أن يشعر كلا الجانبين بالقوة نفسها.	Cranial Nerve XI—Spinal Accessory العصب القحفي الحادي عشر - العصب القحفي الحادي عشر Atrophy of neck muscles. Muscle weakness or paralysis occurs with a stroke. ضمور في عضلات الرقبة. ضعف العضلات أو يحدث الشلل مع السكتة الدماغية.
Cranial Nerve XII—Hypoglossal العصب القحفي الثاني عشر - العصب القحفي الثاني عشر - Ask person to stick out tongue; should protrude in the midline. اطلب من الشخص إخراج لسانه؛ يجب أن يبرز في الخط الأوسط. - Ask person to say, "light, tight, dynamite;" lingual speech should be clear and distinct. اطلب من الشخص أن يقول، "خفيف، ضيق، الديناميت؛" الكلام اللساني يجب أن يكون الكلام اللساني واضح ومميز.	Cranial Nerve XII—Hypoglossal العصب القحفي الثاني عشر - العصب القحفي الثاني عشر Fasciculations. Tongue deviates to side. اهتزازات عضلية. اللسان ينحرف إلى الجانب.

Inspect and Palpate the Motor System:

افحص وتحسس الجهاز الحركي:

Normal Range of Findings المدى الطبيعي للنتائج	Abnormal Findings نتائج غير طبيعية
Muscles عضلات	Muscles عضلات
Size الحجم - Muscle groups should be within the normal size limits for age and should be symmetric bilaterally. يجب أن تكون مجموعات العضلات ضمن الحدود الطبيعية للحجم حسب العمر، ويجب أن تكون متماثلة على الجانبين. - When muscles in the extremities appear asymmetric, measure each in centimeters and record the difference. عندما تظهر العضلات في الأطراف غير متماثلة، قس كل واحد بالسنتيمترات و سجل الفرق. - A difference of 1 cm or less is not significant. الفرق بمقدار 1 سم أو أقل ليس ملحوظ. - Note that it is difficult to assess muscle mass in very obese people. لاحظ أنه من الصعب تقييم العضلات الكتلة في الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.	Atrophy—Abnormally small muscle with a wasted appearance; occurs with disuse, injury, lower motor neuron disease, and muscle disease. ضمور — عضلة صغيرة بشكل غير طبيعي مع مظهر مهتر؛ يحدث مع قلة الاستخدام، إصابة، مرض العصبون الحركي السفلي، و مرض العضلات. Hypertrophy—Increased size and strength; occurs with isometric exercise. التضخم — زيادة الحجم والقوة؛ يحدث مع التمرين المتساوي القياس.

University of Al Bayan/ College of Nursing جامعة البصرة / كلية التمريض	2 nd stage تقييم الصحة / المختبر	Health assessment / Lab 11 المراجعة
Strength ▪ Test homologous muscles simultaneously اختبار العضلات المتماثلة في نفس الوقت	Paralysis —Loss of motor power الشلل — فقدان القدرة الحركية	
Cerebellar Function وظيفة المخيخ		
▪ Gait. Observe as the person walks 10 to 20 feet, turns, and returns to the starting point. المشية. راقب الشخص أثناء مشيه 10 خطوات إلى 20 قدم، يدير، ويعود إلى نقطة البداية. ▪ Normally the gait is smooth, rhythmic, and effortless; the opposing arm swing is coordinated; turns are smooth. عادة ما تكون طريقة المشي سلسة وإيقاعية، وسهلة؛ وتاريخ الذراع المقابلة هو منسق؛ التحولات سلسة. ▪ The step length is about 15 inches from heel to heel. طول الخطوة حوالي 15 بوصة من كعب إلى كعب.	▪ Stiff, immobile posture. Staggering or reeling. Wide base of support. وضعية متيبسة وغير متحركة. التمايل أو دوار. قاعدة دعم واسعة. ▪ Lack of arm swing or rigid arms. قلة حركة الذراعين أو ثبات الذراعين. ▪ Unequal rhythm of steps. Slapping of foot. إيقاع غير متساوي للخطوات. صفع القدم. Scraping of toe of shoe. خدش أطراف الحذاء.	
▪ Ask the person to walk a straight line in a heel-to-toe fashion (tandem walking). اطلب من الشخص أن يمشي في خط مستقيم بطريقة كعب إلى أصبع القدم (المشي بالتتابع). ▪ This decreases the base of support and accentuates any problem with coordination. Normally the person can walk straight and stay balanced. هذا يقلل من قاعدة الدعم و يبرز أي مشكلة في التنسيق. عادة الشخص يمكن أن يمشي مستقيماً ويحافظ على توازنه.	▪ Ataxia—Uncoordinated or unsteady gait. الترنح—مشية غير متناسقة أو غير مستقرة. ▪ Crooked line of walk. خط المشي المعوج. ▪ Widens base to maintain balance. يوسع القاعدة للحفاظ على التوازن. ▪ Staggering, reeling, loss of balance. تمايل، مرتبك، فقدان التوازن.	
Romberg Test. ▪ Ask the person to stand with feet together and arms at the sides. اطلب من الشخص أن يقف وقدميه معاً والذراعان على الجانبين. ▪ Once in a stable position, ask the person to close the eyes and hold the position. بمجرد أن يكون الشخص في وضع مستقر، اسأله إغماض العينين والحفاظ على الوضعية. ▪ Wait about 20 seconds. انتظر حوالي 20 ثانية. ▪ Normally a person can maintain posture and balance, although there may be slight swaying. (Stand close to catch the person in case he or she falls.) عادة يمكن للشخص المحافظة على وضعية الجسم والتوازن، رغم أنه قد يكون هناك بعض الطفيف والتأرجح. (قف قريباً لتمكك بالشخص في حال وقع هو أو هي.)	▪ An ataxia that did not appear with regular gait may now appear. عدم تنسيق لم يظهر بشكل منتظم قد يظهر المشي الآن. ▪ Swaying, falling, widening of base of feet to avoid falling. التمايل، السقوط، توسيع قاعدة القدمين إلى تجنب السقوط. ▪ Positive Romberg sign is loss of balance increased by closing of the eyes. It occurs with cerebellar ataxia (multiple sclerosis, alcohol intoxication), loss of proprioception, and loss of vestibular function. العلامة الإيجابية لرومبيرغ هي فقدان التوازن بزيادة عند إغلاق العينين. يحدث ذلك مع ترنح المخيخ (التصلب المتعدد، التسمم بالكحول، فقدان الإحساس بالموضع والتسمم وظيفته الدهليز.	
▪ Ask the person to perform a shallow knee bend or to hop in place, first on one leg and then the other. اطلب من الشخص أن يقوم بتنفس سطحي ثني الركبة أو القفز في المكان، أولاً على رجل واحدة ثم الآخر. ▪ This demonstrates normal position sense, muscle strength, and cerebellar function. Note that some individuals cannot hop because of aging or obesity. هذا يوضح الإحساس بالوضع الطبيعي، قوة العضلات، ووظائف المخيخ. لاحظ أن بعض الأشخاص لا يستطيعون القفز بسبب الشيخوخة أو السمنة.		



Walk heel-to-toe



Romberg test

Assess the Sensory System:

قيم النظام الحسي:

Normal Range of Findings	Abnormal Findings
المدى الطبيعي للنتائج - Make sure the person is alert, cooperative, and comfortable and has an adequate attention span; otherwise you may get misleading and invalid results. - Routine screening procedures include testing superficial pain, light touch, vibration in a few distal locations, and stereognosis. - The person's eyes should be closed during each test. Take time to explain what will be happening and exactly how you expect the person to respond.	نتائج غير طبيعية
Superficial Pain	
ألم سطحي - Twist and break a tongue blade lengthwise, forming a sharp point at the fractured end and a dull spot at the rounded end. - Lightly apply the sharp point and the dull end to the person's body in a random, unpredictable order. - Ask the person to say "sharp" or "dull," depending on the sensation felt. (Note that the sharp edge is used to test for pain; the dull edge is used as a general test of the person's responses.) - Alternatively break a cotton swab in half, forming a sharp point and using the dull spot at the cotton end.	- Hypoalgesia—Decreased pain sensation. - Analgesia—Absent pain sensation. - Hyperalgesia—Increased pain sensation.
- Let at least 2 seconds elapse between each stimulus to avoid summation. - With summation, frequent consecutive stimuli are perceived as one strong stimulus.	
Light Touch	
لمسة خفيفة - Apply a wisp of cotton to the skin. - Stretch a cotton ball to make a long end and brush it over the skin in a random order of sites and at irregular intervals. - Ask the person to say "now" or "yes" when touch is felt. Compare symmetric points.	- Hypoesthesia—Decreased touch sensation. - Anesthesia—Absent touch sensation. - Hyperesthesia—Increased touch sensation.
Vibration	
اهتزاز - Strike a low-pitched tuning fork on the heel of your hand and hold the base on a bony surface of the fingers and great toe. - Ask the person to indicate when the vibration starts and stops. - The normal response is vibration or a buzzing sensation on these distal areas.	- Unable to feel vibration; states that vibration stops when fork is still vibrating. - Loss of vibration sense occurs with peripheral neuropathy, e.g., diabetes and alcoholism. - This is often the first sensation lost.

University of Al Bayan/ College of Nursing 2 nd stage جامعة البيلان / كلية التمريض	Health assessment / Lab 11 تقييم الصحة / المختبر المرحلة
- If no vibrations are felt, move proximally and test ulnar processes, ankles, patellae, and iliac crests. • إذا لم تشعر بأي اهتزازات، تحرك تجاه الأعلى وفحص النتوءات الزندية والكاحلين والركبتين وعروض الحرقفتين. - Compare the right side to the left. • قارن الجانب الأيمن بالجانب الأيسر. - If you find a deficit, note whether it is gradual or abrupt. • إذا وجدت عجزاً، لاحظ ما إذا كان تدريجياً أو مفاجئاً.	
Stereognosis الاستشعار الشكلي	
- Test the person's ability to recognize objects by feeling their forms, sizes, and weights. • اختبار قدرة الشخص على التعرف الأشياء عن طريق الإحساس بأشكالها وأحجامها و أوزانها. - Place a familiar object (paper clip, key, coin) in the person's hand and ask the person to identify it with the eyes closed. • ضع شيئاً مألوفاً (مبنيك ورق، مفتاح، عملة) في يد الشخص واطلب من شخص لتحديده و عيناه مغمضتان. - A person normally explores it with the fingers and correctly names it. • عادة ما يستكشف الشخص ذلك باستخدام يديه بشكل صحيح. - Test a different object in each hand; testing • جرب شيئاً مختلفاً في كل يد؛ اختبار - the left hand assesses right parietal lobe functioning • اليد اليسرى تقيم الفص الجداري الأيمن	Astereognosis—Unable to identify object correctly; occurs in sensory cortex lesions. • اضطراب التحسس اللمسي — عدم القدرة على التعرف على الجسم بشكل صحيح؛ يحدث في أفات القشرة الحسية.



Test superficial pain.
 اختبار الألم السطحي.



Stereognosis.
 الاستشعار الشكلي

Test the Reflexes

اختبر ردود الفعل

Normal Range of Findings		Abnormal Findings	
المدى الطبيعي للنتائج		النتائج غير الطبيعية	
Stretch or Deep Tendon Reflexes (DTRs) (المدى أو ردود فعل الأوتار العصبية) (DTRs)			
- For an adequate response, the limb should be relaxed, and the muscle partially stretched. - Stimulate the reflex by directing a short, snappy blow of the reflex hammer onto the insertion tendon of the muscle. Strike a brief, well-aimed blow and bounce up promptly; do not let the hammer rest on the tendon. - Use the pointed end of the reflex hammer when aiming at a smaller target such as your thumb on the tendon site; use the flat end when the target is wider or to diffuse the impact and prevent pain. - Use just enough force to get a response. Compare right and left sides; the responses should be equal.		Clonus is a set of short, jerking contractions of the same muscle following the hammer blow. Hyperreflexia is the exaggerated reflex seen when the monosynaptic reflex arc is released from the influence of higher cortical levels. - This occurs with CNS upper motor neuron lesions, e.g., after a stroke. Hyporeflexia, which is the absence of a reflex, is a lower motor neuron problem. It occurs with interruption of sensory afferents or destruction of motor efferents and anterior horn cells, e.g., spinal cord injury.	
- The reflex response is graded on a four-point scale: 4 + Very brisk, hyperactive with clonus; indicates disease 3 + Brisker than average; may indicate disease 2 + Average; normal 1 + Diminished; low normal 0 No response			
Biceps Reflex (C5 to C6). (الرجاج العصبية ذات الرأسين (C5 إلى C6)).			
- Support the person's forearm on yours; this position relaxes and partially flexes his or her arm. - Place your thumb on the biceps tendon and strike a blow on your thumb. - You can both feel and see the normal response, which is flexion of the forearm			
Triceps Reflex (C7 to C8). (رد فعل العصبية الثلاثية الرؤوس (C7 إلى C8)).			
- Tell the person to let the arm "just go dead" as you suspend it by holding the upper arm. Strike the triceps tendon directly just above the elbow. - The normal response is extension of the forearm. Alternatively hold the person's wrist across the chest to flex the arm at the elbow and tap the tendon.			
Patellar Reflex ("Knee Jerk") (L2 to L4) (رد فعل الركبة (زرققة الركبة) (L2 إلى L4))			
- Let the lower legs dangle freely to flex the knee and stretch the tendons. - Strike the tendon directly just below the patella.			

University of Al Bayan/ College of Nursing جامعة البصرة / كلية التمريض	2 nd stage تقييم الصحة / المختبر	Health assessment / Lab 11 المراجعة
Extension of the lower leg is the expected response. Also you can feel the contraction of the quadriceps.		
Achilles Reflex (“Ankle Jerk”) (L5 to S2). - Position the person with the knee flexed and the hip externally rotated. - Hold the foot in dorsiflexion and strike the Achilles tendon directly. - Feel the normal response as the foot plantar flexes against your hand.	رد فعل أخيل (من L5 إلى S2).	
Plantar Reflex (L4 to S2). - With the end of the reflex hammer, draw a light stroke up the lateral side of the sole and across the ball of the foot, like an upside-down J - The normal response is plantar flexion of the toes and sometimes of the entire foot.	رد فعل القدم الأخمصية (من L4 إلى S2). - Except in infancy, the abnormal response is dorsiflexion of the big toe and fanning of all toes, which is a positive Babinski sign. - This occurs with upper motor neuron disease of the pyramidal tract	



Biceps reflex.

انعكاس العضلة ذات الرأسين. انعكاس العضلة ثلاثية الرؤوس.



Triceps reflex.



Patellar reflex

رد فعل أخيل



Achilles reflex

رد فعل الركبة



A. Plantar reflex.

أ، منعكس باطن القدم. ب، علامة بابينسكي.



B, Babinski sign.

NURSE'S PRAYER

Almighty **G**od, **D**ivine **H**ealer of all,
Grant me, **Y**our handmaiden,
strength and courage in my calling.

Give to my heart compassion
and understanding

Give to my hands skill and tenderness

Give to my mind knowledge
and wisdom.

Our Lady's Mantle

Especially, **D**ear **L**ord, help me
always to remember the true
purpose of my vocation,
that of selfless service
and dedication to the weak
and despairing in body and spirit.